

PRESCRIÇÃO PEDIÁTRICA SEGURA

Dossiê integral de configuração, reconstrução e continuidade

Dimensão	Conteúdo consolidado
Interface clínica	Calculadora, bibliotecas, seleção múltipla, prévia e segurança
Catálogo diagnóstico	315 diagnósticos e síndromes na interface; 238 solicitados validados
Catálogo farmacológico	265 medicamentos; 577 linhas; 391 indicações clínicas validadas
Scores clínicos	25 instrumentos complementares cadastrados
Design vigente	Azul e roxo, responsivo, alto contraste
Finalidade	Recuperação integral do projeto em caso de perda ou migração

Versão documental: 15/08/2026. Este dossiê registra o máximo de informações recuperáveis do projeto atual. Ele não substitui revisão médica, bula vigente, diretriz atualizada ou protocolo institucional.

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Identidade e finalidade
 2. Requisitos funcionais
 3. Fontes e governança clínica
 4. Arquitetura da interface
 5. Modelo de dados
 6. Motor de cálculo
 7. Tripla checagem e segurança
 8. Seleção de medicamentos e apresentações
 9. Prévia consolidada em linguagem simples
 10. Recomendações, evolução, alarmes e retorno
 11. Scores clínicos
 12. Emergências e limites de alta
 13. Design azul e roxo
 14. Acessibilidade e responsividade
 15. Arquitetura técnica e implantação
 16. Testes e critérios de aceite
 17. Prompt mestre completo
 18. Procedimento de reconstrução
 19. Histórico consolidado das solicitações
- Anexo A. Diagnósticos
- Anexo B. Scores clínicos
- Anexo C. Índice de medicamentos
- Anexo D. Inventário farmacológico integral (577 linhas)
- Anexo E. Checklist de auditoria

Os anexos são parte da configuração. A presença de um medicamento no inventário não equivale a indicação automática; a decisão depende do diagnóstico, idade, peso, apresentação, contraindicações, evidência e contexto clínico.

1. Identidade e finalidade

- Nome do produto: **Prescrição Pediátrica Segura**.
- Idioma: português brasileiro.
- Público primário: médicos e profissionais habilitados em pediatria, urgência, emergência e terapia intensiva.
- Público da saída domiciliar: pais e responsáveis, com linguagem simples e instruções práticas.
- Objetivo: apoiar decisão clínica e cálculo por diagnóstico, peso e idade, produzindo receita auditável e pronta para copiar.
- Escopo: condições ambulatoriais, pronto atendimento, sala vermelha, terapia intensiva, trauma, toxicologia e pós-operatório.

Princípios inegociáveis

- Não inventar dose, apresentação, concentração, compatibilidade, estabilidade, indicação ou fonte.
- Distinguir tratamento domiciliar, observação, internação, UTI e emergência tempo-dependente.

- Mostrar incerteza, contraindicação e status off-label.
- Manter revisão humana antes de finalizar qualquer receita.
- Preservar todos os catálogos, algoritmos, textos e validações em cada atualização.

2. Requisitos funcionais

Requisito	Comportamento obrigatório
Diagnóstico	Busca e seleção entre 315 diagnósticos/síndromes, em ordem alfabética.
Peso e idade	Entradas que recalculam doses, elegibilidade e apresentações.
Data	Preenchimento inicial automático com a data atual no fuso America/Sao_Paulo.
Seleção múltipla	Permitir uma ou várias medicações e medidas de suporte.
Apresentações	Exibir opções brasileiras clicáveis; recalcular mL, gotas ou unidades.
Prévia	Receita completa, simples, numerada e pronta para copiar.
Vias	Agrupar individualmente e ocultar vias sem indicação.
Bibliotecas	Diagnósticos e medicamentos em ordem alfabética, com busca e filtros.
Scores	Exibir instrumentos pertinentes por diagnóstico, em ordem de relevância.
Segurança	Bloquear automação quando faltarem dose/apresentação/equivalência validadas.

3. Fontes e governança clínica

- Prioridade 1: diretrizes municipais de Belo Horizonte, Betim, Contagem e demais municípios da RMBH.
- Prioridade 2: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.
- Prioridade 3: Sociedade Brasileira de Pediatria.
- Prioridade 4: Ministério da Saúde.
- Prioridade 5: ANVISA, bulas e registros sanitários vigentes.
- Diretrizes internacionais somente quando não houver recomendação nacional ou quando forem mais atuais/relevantes; informar a origem.
- Referências complementares fornecidas: emergencia-pediatrica-doses.iagovalmeida.chatgpt.site e invertexto.com/iagoalmeida.

Governança de conteúdo

- Cada linha farmacológica deve registrar medicamento, indicação, via, apresentação, dose, máximo, intervalo, preparo, monitorização, cautelas, risco e off-label.
- Cada diagnóstico deve ter opções principais, alternativas, suporte, itens a evitar, sinais de alarme e evolução esperada.
- Atualizações devem preservar ordem alfabética e passar pelos validadores automáticos.
- Apresentações comerciais e disponibilidade devem ser confirmadas no momento da prescrição.

4. Arquitetura da interface

Área	Conteúdo	Interação
Cabeçalho	Marca e navegação	Âncoras para calcular, conferir, protocolos, medicações e segurança.
Hero	Proposta de valor e contadores	Acesso direto à calculadora.
Calculadora	Peso, idade, data, diagnóstico	Atualização reativa.
Medicamento/estratégia	Opções principais e alternativas	Checkboxes, seleção múltipla e ajuste individual.
Apresentações	Concentrações/formas brasileiras	Botões clicáveis por medicamento.
Resultados	Dose, volume, frequência e fórmulas	Atualização conforme entradas.
Prévia consolidada	Receita domiciliar completa	Copiar texto.
Recomendações clicáveis	Condutas, orientações, alarmes e scores	Seções expansíveis.
Biblioteca clínica	315 diagnósticos	Busca e filtros por categoria.
Biblioteca farmacológica	265 medicamentos/577 linhas	Busca e expansão por medicamento.
Segurança	Tripla checagem e referências	Leitura e auditoria.

Categorias diagnósticas

Alergia; Ambiental; Cardiologia; Cirurgia; Dermatologia; Emergência; Endocrinologia; Gastroenterologia; Gastrointestinal; Hematologia; Infectologia; Nefrologia; Neurologia; Oftalmologia; Onco-hematologia; Ortopedia; Otorrino; Respiratória; Reumatologia; Sala vermelha; Toxicologia; Trauma; Urinária; Urologia.

5. Modelo de dados

Diagnóstico/protocolo

Identificador; nome; categoria; resumo; critérios; avaliação; medicamentos/estratégias; itens a evitar; sinais de alarme; evolução; referências; acuidade; associação com scores.

Medicamento do protocolo

Identificador; nome; papel; via; base de dose; mínimo; usual; máximo; doses por dia; máximo por dose/dia; duração; observações; apresentações; concentração mg/mL; mg/unidade; gotas/mL; unidade.

Linha do inventário farmacológico

ID; medicamento; indicação; via; apresentação; dose; máximo; intervalo; preparo; monitorização; cautelas; status; highRisk; offLabel.

Score clínico

ID; nome; edição; prioridade; palavras-chave; fonte; flag de uso geral.

6. Motor de cálculo

Entrada: peso (kg), idade (anos), dose selecionada, base posológica, frequência e apresentação. **Saída:** dose total, volume, gotas ou unidades e horários sugeridos.

```
mg/kg/dose: dose_total = dose_ponderal × peso.
mg/kg/dia: dose_total_por_dose = (dose_diária × peso) ÷ número_de_doses.
mL/dose = dose_total ÷ concentração_mg_por_mL.
gotas/dose = mL/dose × gotas_por_mL.
unidades/dose = dose_total ÷ mg_por_unidade.
```

- Aplicar máximo por dose e máximo diário antes da conversão final.
- Usar valor fixo usual quando houver faixa terapêutica validada.
- Arredondar de forma compatível com seringa, conta-gotas, dispositivo ou forma farmacêutica.
- Se não houver equivalência segura, não gerar quantidade final automática.

7. Tripla checagem e segurança

Etapa	Verificações
1. Matemática	Peso, unidade, mg/kg/dose ou mg/kg/dia, frequência, máximos e arredondamento.
2. Farmacêutica	Produto, forma, concentração, mg/mL, mg/unidade, gotas/mL e conversão.
3. Clínica	Indicação, idade, alergia, contraindicação, função renal/hepática, interação, duplicidade, duração e contexto.
Checagem reversa	Partir do mL/gotas/unidades finais e recalcular mg e mg/kg.

- Para alta vigilância: dupla checagem humana de peso, unidade, concentração, via e programação.
- Itens condicionais/off-label não entram automaticamente.
- A receita não deve ocultar quando o tratamento exige monitorização hospitalar.
- Não usar apresentação adulta inadequada quando houver opção pediátrica.

8. Seleção de medicamentos e apresentações

- Permitir selecionar mais de uma opção por diagnóstico.
- Incluir terapia causal, sintomáticos, suporte, hidratação, cuidados locais e alternativas clinicamente pertinentes.
- Exibir todas as apresentações brasileiras cadastradas para seleção.
- Priorizar líquidos, gotas, sprays, inaladores e tópicos apropriados à idade.
- Excluir medicamentos sem uso pediátrico reconhecido, mesmo off-label.
- Aplicar bloqueios etários e contraindicações relevantes.
- Rotular off-label e exigir validação individual.
- Indicar quando uma opção é primeira linha, alternativa, adjuvante ou somente hospitalar.

9. Prévia consolidada em linguagem simples

A prévia é a saída central destinada ao cuidador. Ela deve ser direta, completa, sem explicação matemática e pronta para copiar e colar.

Cabeçalho obrigatório

DIAGNÓSTICO: X
PESO: Y kg
IDADE: Z anos
DATA: data atual

Vias individualizadas

- USO ORAL; USO TÓPICO; USO NASAL; USO INALATÓRIO; USO OTOLÓGICO; USO OFTÁLMICO; USO RETAL; ou uso no serviço de saúde.
- Exibir apenas vias com pelo menos um item selecionado.
- Numeração contínua entre vias.
- Cada linha: nome + apresentação + quantidade fixa + intervalo + duração + horários + orientação + finalidade.

Formato farmacológico

1. NOME DO MEDICAMENTO + APRESENTAÇÃO - Dar X mL/gotas/unidades/comprimidos, de X em X horas, por Y dias. Horários sugeridos: A, B, C. Orientação prática. Finalidade em linguagem simples.

- Não mostrar mg/kg, mg/kg/dia ou memória de cálculo ao cuidador.
- Usar um valor fixo, não uma faixa, quando a escolha estiver validada.
- Para remédio de dor/febre, deixar claro “somente se necessário”.
- Considerar febre domiciliar como temperatura axilar $\geq 37,5$ °C associada ao estado geral.

10. Recomendações, evolução, alarmes e retorno

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- Explicar o que pode, deve, não pode e não deve ser feito.
- Incluir hidratação, alimentação, repouso, ambiente e medidas específicas.
- Não acrescentar remédios por conta própria nem duplicar produtos com a mesma finalidade.
- Evitar fumaça, irritantes e medidas potencialmente prejudiciais conforme o diagnóstico.

ORIENTAÇÕES GERAIS - texto-base

- Siga os horários e o tempo de uso descritos acima. Use seringa dosadora para medir líquidos.
- Remédios para dor ou febre devem ser usados apenas quando a criança estiver desconfortável; não é necessário dar de forma preventiva.
- Considere febre em casa quando a temperatura medida na axila for igual ou maior que 37,5 °C, levando em conta também o estado geral.
- Antes de administrar qualquer medicação, exclua alergias, outros remédios em uso e doença nos rins ou no fígado.

EVOLUÇÃO CLÍNICA ESPERADA

- Descrever quando a melhora costuma iniciar e quanto pode durar.
- Personalizar conforme causa e gravidade.
- Orientar reavaliação se houver piora, ausência de melhora esperada ou sintoma diferente.

SINAIS DE ALARME

- Personalizar para cada diagnóstico.
- Sempre destacar comprometimento da respiração, circulação, consciência e hidratação.
- Alerta universal: dificuldade para respirar, lábios arroxeados, convulsão, desmaio, sonolência excessiva, recusa persistente de líquidos ou redução importante da urina.

RETORNO / REAVALIAÇÃO

- Retorno imediato se houver sinal de alarme, piora, sintoma diferente ou dúvida dos responsáveis.
- Sem sinais de alarme e com melhora progressiva, não retornar ao pronto atendimento apenas para revisão de rotina.

11. Scores clínicos

- Citar scores existentes, atualizados e validados para o diagnóstico selecionado.
- Não explicar extensamente cada instrumento na interface.
- Ordenar por importância clínica, validação médico-científica e atualização.
- Prioridade crescente: 1 é a mais alta.
- Desempate: ano mais recente e nome em ordem alfabética.
- Exibir no máximo sete scores por diagnóstico; incluir PEWS como instrumento geral.

12. Emergências e limites de alta

- Emergências tempo-dependentes devem destacar ABCDE e estabilização paralela.
- Não simular receita domiciliar quando há indicação de monitorização, procedimento, internação, UTI ou transferência.
- Medicções parenterais, vasoativas, sedação, bloqueio neuromuscular e drogas de alta vigilância exigem protocolo institucional.
- Confirmar acesso, monitorização, concentração final, diluição e dupla checagem humana.
- A ferramenta deve separar claramente suporte inicial de prescrição de alta.

13. Design azul e roxo

Token	Valor	Uso
--navy	#16205F	Textos principais, títulos, bordas e cabeçalho.
--blue	#2563EB	Ações, gradientes e estados ativos.
--purple	#7C3AED / #6D28D9	Destaques, seleção, avisos e gradientes.
--ivory	#F4F3FF	Fundo-base.
--paper	FFFFFF	Cartões e superfícies.
--ink	#24264B	Texto corrido.
--teal	#5B3FD1	Token legado usado como violeta.
--teal-pale	#ECE9FF	Destaques claros.
--line	#D9D5F2	Bordas e divisores.
--muted	#646887	Textos secundários.

- Fundo com gradiente claro azul-violeta.
- Botão principal e estados selecionados com gradiente azul-roxo.
- Rodapé em gradiente azul profundo-violeta.
- Cartões brancos, bordas suaves, sombras discretas e foco visível.
- Tipografia de interface: Geist/Inter; títulos editoriais de alto contraste.
- Não aplicar filtro grayscale.

14. Acessibilidade e responsividade

- Rótulos explícitos para campos e controles.
- Foco visível em inputs, selects e botões.
- Checkboxes com cor de destaque e estado selecionado inequívoco.
- Área dinâmica com aria-live quando apropriado.
- Navegação por teclado e alvos adequados para toque.
- Desktop: duas colunas no hero e grades de conteúdo.
- Tablet: redução de colunas e navegação simplificada.
- Celular: formulários, resultados, recomendações e cartões em coluna única.
- Texto da prévia selecionável e copiável.

15. Arquitetura técnica e implantação

Componente	Configuração
Framework	React 19 + TypeScript.
Camada web	Next 16 compatível via Vinext.
Build	Vite/Vinext para Cloudflare Worker ESM.
Estilos	CSS global + Tailwind importado; tokens CSS.
Hospedagem	OpenAI Sites.
Manifesto	dist/.openai/hosting.json válido.
Saída Worker	dist/server/index.js com default.fetch executável.
Validação	Scripts próprios de diagnóstico, medicação e artefato.
Persistência clínica	Catálogos versionados no código/JSON.

Arquivos essenciais

app/page.tsx; app/globals.css; app/layout.tsx; app/requested-diagnoses.ts; app/clinical-scores.ts;
app/medication-inventory.json; scripts/validate-diagnosis-catalog.mjs; scripts/validate-medication-catalog.mjs;
scripts/build-verified.sh; scripts/validate-artifact.sh; tests/rendered-html.test.mjs; .openai/hosting.json.

16. Testes e critérios de aceite

- 238/238 diagnósticos solicitados validados.
- 265/265 medicamentos únicos validados.
- 577/577 linhas farmacológicas validadas.
- 391/391 indicações clínicas validadas.
- Diagnósticos e medicamentos ordenados alfabeticamente.
- Busca e filtros funcionam.
- Seleção múltipla e apresentações clicáveis funcionam.
- Alterar peso, idade ou apresentação recalcula a saída.
- Vias vazias não aparecem na prévia.
- Nenhum medicamento é duplicado entre vias.
- Data atual no fuso de São Paulo.
- Prévia contém todas as seções obrigatórias.
- Layout azul/roxo responsivo em desktop e celular.
- Build e artefato de hospedagem válidos.

17. Prompt mestre completo

Crie ou restaure o projeto “Prescrição Pediátrica Segura” como ferramenta profissional de apoio à decisão pediátrica, em português brasileiro. Mantenha 315 diagnósticos/síndromes e 265 medicamentos em ordem alfabética, com busca e filtros. Permita selecionar múltiplos medicamentos, medidas de suporte e apresentações comercializadas no Brasil. Calcule individualmente por diagnóstico, peso e idade, aplicando dose ponderal, máximos, frequência, concentração e checagem reversa. Faça tripla checagem matemática, farmacêutica e clínica. Bloqueie itens sem apresentação ou equivalência validada. Exclua fármacos sem uso pediátrico reconhecido; identifique uso off-label. Diferencie tratamento domiciliar, observação, internação, UTI e emergência. Gere prévia pronta para copiar, em linguagem simples, com diagnóstico, peso, idade, data atual, medicamentos numerados agrupados apenas pelas vias aplicáveis, quantidade fixa em mL/gotas/unidades/comprimidos, intervalo, duração, horários, orientação, finalidade, recomendações, orientações gerais, evolução esperada, sinais de alarme e retorno. Considere febre axilar $\geq 37,5$ °C no domicílio. Priorize RMBH, SES-MG, SBP, Ministério da Saúde e ANVISA. Inclua scores clínicos pertinentes, ordenados por relevância e atualização. Preserve bibliotecas, validações e alertas. Use design responsivo em azul e roxo.

18. Procedimento de reconstrução

- Restaurar todos os arquivos essenciais listados neste dossiê.
- Recriar o modelo de dados e importar o inventário farmacológico integral.
- Validar os 238 diagnósticos solicitados e o total de 315 diagnósticos da interface.
- Validar os 265 medicamentos, 577 linhas e 391 indicações.
- Reimplementar cálculo, máximos, conversão e checagem reversa.
- Reimplementar seleção múltipla, apresentações e filtros pediátricos.
- Reimplementar a prévia exatamente conforme as seções obrigatórias.
- Reaplicar a paleta azul e roxa, responsividade e acessibilidade.
- Testar um diagnóstico de alta e uma emergência.
- Testar solução, gotas, inalador, tópico e unidade/comprimido.
- Executar build, validar artefato e publicar somente após revisão.

19. Histórico consolidado das solicitações

- Ampliar diagnósticos e medicamentos, inclusive opções off-label clinicamente plausíveis.
- Manter diagnósticos e medicamentos em ordem alfabética.
- Importar e contemplar medicamentos do site de doses pediátricas indicado.
- Permitir selecionar várias medicações por diagnóstico.
- Calcular todas as opções por peso e/ou idade.
- Incluir medidas de suporte, sintomáticos, antibióticos, antivirais e corticoides quando indicados.
- Criar recomendações, orientações, cuidados, evolução e sinais de alarme clicáveis.
- Adicionar scores clínicos validados por diagnóstico.
- Oferecer todas as apresentações brasileiras cadastradas como opções clicáveis.
- Excluir fármacos contraindicados sem uso pediátrico.
- Priorizar apresentações pediátricas.
- Gerar prévia consolidada em linguagem simples, pronta para copiar e colar.
- Separar cada via de uso e ocultar vias vazias.
- Incluir horários sugeridos, orientações de administração e quantidade fixa.
- Alterar o design inicialmente para preto e branco e, na versão vigente, para azul e roxo.
- Salvar e publicar todas as configurações.
- Gerar documentação integral reutilizável do projeto.

ANEXO A - DIAGNÓSTICOS E SÍNDROMES

Relação alfabética consolidada. Foram recuperados 315 nomes únicos diretamente das fontes do projeto; a interface validada informa 315 diagnósticos/síndromes.

Nº	Diagnóstico/síndrome	Nº	Diagnóstico/síndrome
1	Abscesso Cerebral	159	Hemofilia A ou B com Hemartrose ou Sangramento de SNC
2	Abscesso cutâneo	160	Hemorragia Alveolar Difusa
3	Abscesso Cutâneo / Furunculose	161	Hemorragia digestiva
4	Abscesso Periamigdaliano	162	Hemorragia Digestiva Alta (HDA) — Varizes Esofágicas ou Úlcera
5	Abscesso Pulmonar	163	Hemorragia Digestiva Baixa (HDB) Grave
6	Abscesso Retrofaríngeo	164	Hemotórax
7	Abuso Sexual Agudo	165	Hérnia Incarcerada / Hérnia Estrangulada
8	Acidente elétrico	166	Herniação Cerebral Aguda
9	Acidente ofídico	167	Herpangina
10	Acidente Ofídico Botrópico (Jararaca)	168	Hipercalcemia Crítica
11	Acidente Ofídico Crotálico (Cascavel)	169	Hipercalcemia Grave com Repercussão Eletrocardiográfica
12	Acidente Ofídico Elapídico (Coral)	170	Hipernatremia Grave
13	Acidente por Escorpião (Escorpionismo) Leve	171	Hiperreatividade Brônquica
14	Acidente por Escorpião Moderado a Grave	172	Hipertensão Intracraniana (HIC) Aguda
15	Acidente por Loxosceles (Aranha-Marrom)	173	Hipocalcemia Aguda (Tetania)
16	Acidente por Phoneutria (Aranha-Armadeira)	174	Hipocalemia Grave
17	Acidente Vascular Cerebral (AVC) Isquêmico Pediátrico	175	Hipoglicemia Aguda Sintomática
18	Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico / Hemorragia Intracraniana Espontânea	176	Hipoglicemia sintomática
19	Acidose Metabólica Grave Refratária	177	Hiponatremia Grave com Sintomas Neurológicos
20	Adenite cervical aguda	178	Hipotermia Acidental Grave
21	Adenite Mesentérica	179	Hipotireoidismo Congênito Descompensado / Coma Mixedematoso
22	Afogamento	180	Impetigo
23	Afogamento Grau 1 a 6	181	Imunodeficiência Primária Manifestada por Infecção Grave
24	Alcalose Metabólica / Respiratória Grave	182	Infecção de Vias Aéreas Superiores (IVAS)
25	Amigdalite Aguda	183	Infecção do Trato Urinário Inferior (Cistite)
26	Anafilaxia	184	Infecção pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR)
27	Anemia Aguda Grave por Sangramento	185	Infecção urinária na criança
28	Anemia Falciforme com Crise Aplásica	186	Influenza (Gripe)
29	Anemia Falciforme com Síndrome Torácica Aguda	187	Ingestão de cáustico
30	Anemia Falciforme em Crise Álgica (Crise Vaso-Oclusiva)	188	Insuficiência Adrenal Aguda (Crise Addisoniana / Síndrome de Waterhouse-Friderichsen)
31	Anemia Falciforme em Crise de Sequestro Esplênico Agudo	189	Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) Descompensada
32	Angioedema com Obstrução de Via Aérea	190	Insuficiência Hepática Aguda Grave (IHAG)
33	Angioedema sem Insuficiência Respiratória	191	Insuficiência Renal Aguda (IRA) / Lesão Renal Aguda (LRA)
34	Apendicite aguda	192	Insuficiência Respiratória Aguda (IRpA)
35	Apendicite Aguda Complicada / Peritonite Difusa	193	Insuficiência Respiratória Tipo 1 (Hipoxêmica)
36	Apendicite Aguda Inicial	194	Insuficiência Respiratória Tipo 2 (Hiperclínica)
37	Apneia da Prematuridade / Apneia Obstrutiva Grave	195	Intermação / Hipertermia Maligna
38	Arbovirose — Dengue Clássica	196	Intolerância Alimentar Aguda
39	Arbovirose — Dengue com Sinais de Alarma	197	Intoxicação Exógena Aguda Acidental
40	Artrite séptica	198	Intoxicação Exógena Aguda por Tentativa de Autoexterminio
41	Ataxia Cerebelar Aguda	199	Intoxicação por Domissanitários (Saneantes, Cáusticos, Ácidos/Alcalis)
42	Atelectasia Pulmonar Massiva	200	Intoxicação por Medicamentos (Paracetamol, Anticonvulsivantes, Antidepressivos, Opiáceos)
43	Bacteremia Oculta	201	Intoxicação por Monóxido de Carbono ou Inalação de Fumaça
44	Balanite e balanopostite	202	Intoxicação por paracetamol

Nº	Diagnóstico/síndrome	Nº	Diagnóstico/síndrome
45	Bloqueio Atrioventricular Total (BAVT)	203	Intussuscepção Intestinal (Invaginação Intestinal)
46	Bradicardia Sintomática Grave	204	Invaginação intestinal
47	Broncoespasmo Agudo	205	Lactente febril <90 dias
48	Bronquiolite viral aguda	206	Laringite Estridulosa (Crupe Espasmódico)
49	Bronquiolite Viral Aguda (BVA)	207	Laringotraqueobronquite Aguda (Crupe Viral)
50	Bronquiolite Viral Aguda Grave	208	Lesão renal aguda
51	Bronquite Aguda	209	Litíase Renal / Cólica Nefrética
52	Candidíase oral	210	Malária Pediátrica
53	Cardiopatía Congênita Acianótica Descompensada	211	Mastoidite aguda
54	Cardiopatía Congênita Cianótica em Crise de Hipóxia (Crise de Hipercianose)	212	Megacólon Tóxico
55	Cefaleia Tensional Aguda	213	Meningite bacteriana
56	Celulite Infecciosa Periorbitária (Pré-Septal)	214	Meningite Bacteriana Aguda
57	Celulite não purulenta	215	Meningite Viral / Asséptica
58	Celulite orbitária	216	Meningococcemia sem Meningite
59	Celulite Orbitária (Pós-Septal)	217	Miastenia Gravis Juvenil em Crise Miastênica
60	Celulite pré-septal	218	Mielite Transversa Aguda
61	Cetoacidose diabética	219	Miocardite / pericardite
62	Cetoacidose Diabética (CAD) Grave com Edema Cerebral	220	Miocardite Aguda
63	Cetoacidose Diabética (CAD) Leve a Moderada	221	Mononucleose infecciosa
64	Chikungunya — Fase Aguda	222	Mordedura de cão/gato/humana
65	Choque Anafilático	223	Nasofaringite viral aguda
66	Choque Cardiogênico	224	Náuseas e vômitos
67	Choque Hipovolêmico Hemorrágico	225	Necrólise Epidérmica Tóxica (NET)
68	Choque Hipovolêmico por Desidratação	226	Necrose Tubular Aguda (NTA)
69	Choque Obstrutivo	227	Neutropenia febril
70	Choque Pós-Operatório Refratário	228	Neutropenia Febril em Paciente Oncológico
71	Choque Séptico	229	Obstrução Intestinal por Brida
72	Coagulação Intravascular Disseminada (CIVD)	230	Osteomielite aguda
73	Colecistite Aguda	231	Otite externa aguda
74	Cólica do Lactente Aguda	232	Otite média aguda
75	Coma de Causa a Esclarecer	233	Otite Média Aguda (OMA)
76	Conjuntivite aguda	234	Otite Média Efusiva
77	Constipação Intestinal Crônica Agudizada	235	Pancreatite Aguda Pediátrica
78	Constipação intestinal funcional	236	Parada cardiorrespiratória
79	Contusão Musculoesquelética / Entorse	237	Parada Cardiorrespiratória (PCR) Reanimada
80	Convulsão febril	238	Parafimose
81	Coqueluche	239	Parasitose Intestinal Agudizada
82	Coqueluche (Síndrome Coqueluchoide)	240	Pediculose do couro cabeludo
83	Cor Pulmonale Agudo	241	Perfuração de Viscera Oca
84	Corpo Estranho em Conduto Auditivo Externo	242	Pericardite Aguda
85	Corpo Estranho em Fossa Nasal	243	Pielonefrite Aguda Grave com Seps
86	Corpo Estranho em Orofaringe / Esôfago	244	Pielonefrite Aguda Não Complicada
87	Corpo estranho em via aérea	245	Pneumonia adquirida na comunidade
88	Crise Convulsiva Afebril Inicial	246	Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC)
89	Crise Convulsiva Febril Complexa	247	Pneumonia Bacteriana Não Complicada
90	Crise Convulsiva Febril Simples	248	Pneumonia Grave com Derrame Pleural
91	Crise de Asma Leve	249	Pneumonia Viral
92	Crise de Asma Moderada	250	Pneumotórax Espontâneo
93	Crise de Enxaqueca / Migrânea com ou sem Aura	251	Pneumotórax Hipertensivo
94	Crise Hemolítica Aguda (G6PD)	252	Politratismo Grave

Nº	Diagnóstico/síndrome	Nº	Diagnóstico/síndrome
95	Crise Hipertensiva na Infância (Urgência e Emergência)	253	Pós-Operatório de Cirurgia Cardíaca com Circulação Extracorpórea
96	Crise Tireotóxica (Tempestade Tireoidiana)	254	Pós-Operatório de Cirurgia Torácica de Grande Porte
97	Crise vaso-oclusiva falciforme	255	Pós-Operatório de Escoliose / Cirurgia de Coluna Espinal Complexa
98	Crupe / laringotraqueíte	256	Pós-Operatório de Neurocirurgia (Ressecção de Tumor, Derivação Ventricular)
99	Dengue	257	Pós-Operatório de Transplante Hepático / Renal Pediátrico
100	Dengue Grave (Choque por Dengue)	258	Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculite por IgA) com Complicação Abdominal ou Renal
101	Dermatite atópica	259	Púrpura por IgA
102	Dermatite de Contato Agudizada	260	Púrpura Trombocitopênica Idiopática (PTI) com Sangramento Ativo
103	Desidratação	261	Quase-Afogamento com Parada Respiratória
104	Desidratação Leve (Grau I)	262	Quase-Sufocamento / Aspiração de Corpo Estranho em Via Aérea Inferior
105	Desidratação Moderada (Grau II)	263	Queimadura de 3º Grau / Grande Queimado
106	Disfunção Orgânica Múltipla Associada à Seps	264	Queimadura Elétrica / Eletrocussão de Alta Voltagem
107	Displasia Broncopulmonar Agudizada	265	Queimadura Química
108	Divertículo de Meckel Complicado	266	Queimadura térmica
109	Doença de Kawasaki	267	Queimadura Térmica de 1º Grau
110	Doença de Kawasaki em Fase Aguda	268	Queimadura Térmica de 2º Grau — Pequena Extensão
111	Doença mão-pé-boca	269	Quilotórax
112	Dor Abdominal Aguda a Esclarecer	270	Rabdomiólise / miosite viral
113	Eczema Atópico Sobreinfectado (Eczema Herpético)	271	Reação Transfusional Aguda (Hemolítica, Anafilática ou TRALI)
114	Edema Agudo de Pulmão	272	Refluxo Gastroesofágico Descompensado
115	Emergência hipertensiva	273	Resfriado Comum
116	Empiema Pleural	274	Retenção Urinária Aguda
117	Encefalite Viral Aguda	275	Rinite alérgica
118	Encefalopatia Hepática	276	Seps e choque séptico
119	Encefalopatia Hipóxico-Isquêmica Pós-PCR	277	Seps Grave
120	Endocardite Infecciosa Aguda	278	Síncope
121	Enterobíase	279	Síndrome Compartimental Abdominal
122	Envenenamento por Organofosforados / Carbamatos (Chumbinho)	280	Síndrome da Pele Escaldada Estafilocócica
123	Enxaqueca / cefaleia primária	281	Síndrome da Veia Cava Superior / Compressão de Via Aérea por Massa Mediastinal
124	Epiglotite Aguda	282	Síndrome de Aspiração Meconial
125	Epistaxe	283	Síndrome de Guillain-Barré com Insuficiência Respiratória
126	Erisipela	284	Síndrome de Lise Tumoral Aguda (SLT)
127	Erro Inato do Metabolismo em Crise de Descompensação Aguda (Hiperamonemia, Acidemia Orgânica)	285	Síndrome do Choque Tóxico Estafilocócico / Estreptocócico
128	Escabiose	286	Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA)
129	Escarlatina	287	Síndrome Febril
130	Escorpionismo	288	Síndrome gripal / influenza
131	Estado de Mal Asmático (Asma Aguda Grave Refratária)	289	Síndrome hemolítico-urêmica
132	Estado de mal epiléptico	290	Síndrome Hemolítico-Urêmica (SHU)
133	Estado de Mal Epiléptico Convulsivo	291	Síndrome Mão-Pé-Boca
134	Estado de Mal Epiléptico Não Convulsivo	292	Síndrome nefrótica
135	Estenose hipertrófica do piloro	293	Sinusite Aguda (Rinosinusite Bacteriana Aguda)
136	Estomatite Aftosa Recorrente / Gengivostomatite Herpética Aguda	294	Sinusite bacteriana aguda
137	Estomatite herpética primária	295	Subluxação da Cabeça do Rádio (Prono Doloroso)
138	Exacerbação aguda de asma	296	Tamponamento Cardíaco
139	Faringite Aguda	297	Taquicardia supraventricular
140	Faringoamigdalite Bacteriana	298	Taquicardia Supraventricular Instável (TSV)

Nº	Diagnóstico/síndrome	Nº	Diagnóstico/síndrome
141	Faringoamigdalite estreptocócica	299	Taquicardia Ventricular (TV)
142	Faringoamigdalite Viral	300	Torção testicular
143	Farmacodermia Grave — Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ)	301	Traqueíte Bacteriana
144	Fasciíte Necrosante	302	Trauma Abdominal Fechado com Lesão de Viscera Maciça (Fígado, Baço)
145	Febre Amarela	303	Trauma Torácico Fechado / Contusão Pulmonar
146	Febre sem foco em criança	304	Traumatismo cranioencefálico
147	Febre Sem Sinal Localizatório (FSSL)	305	Traumatismo Cranioencefálico (TCE) Grave com PIC Elevada
148	Fecaloma	306	Traumatismo Cranioencefálico (TCE) Leve com Sintomas
149	Ferimento Cortocontuso Necessitando de Sutura	307	Traumatismo Cranioencefálico (TCE) Moderado
150	Fibrilação Ventricular (FV)	308	Tromboembolismo Pulmonar (TEP)
151	Fratura de Ossos Longos Fechada	309	Trombose Venosa Cerebral
152	Fratura Exposta	310	Urticária aguda
153	Gastrite Aguda	311	Varicela (Catapora) Não Complicada
154	Gastroenterite aguda	312	Varicela Hemorrágica ou Complicada com Infecção Secundária
155	Gastroenterite Aguda (GECA) Viral	313	Violência Física Doméstica contra a Criança / Síndrome do Bebê Sacudido
156	Gastroenterite Aguda Bacteriana	314	Volvo de Intestino
157	Glomerulonefrite aguda	315	Zika Vírus Agudo
158	Glomerulonefrite Difusa Aguda (GNDA) Pós-Estreptocócica		

ANEXO B - SCORES CLÍNICOS CADASTRADOS

Ordenação operacional por prioridade, atualização e nome. As fontes abaixo são as cadastradas no projeto e devem ser revisitadas periodicamente.

Prior.	Score	Edição/validação	Fonte
1	Bacterial Meningitis Score	Validação multicêntrica pediátrica	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bacterial+Meningitis+Score+validation+children
1	Clinical Dehydration Scale (CDS)	Escala pediátrica validada	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Clinical+Dehydration+Scale+children+validation
1	KDIGO — estadiamento de lesão renal aguda	Critério internacional vigente	https://kdigo.org/guidelines/acute-kidney-injury/
1	Lund–Browder — superfície corporal queimada	Método ajustado à idade	https://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline_index/Burns/
1	Nomograma de Rumack–Matthew	Ferramenta validada para ingestão aguda	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rumack-Matthew+nomogram
1	PALICC-2 — estratificação de PARDS por OI/OSI	Consenso internacional, 2023	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9848214/
1	PECARN — regra para TCE pediátrico	Validação prospectiva, 2024	https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(24)00029-4/abstract
1	PECARN — regra para trauma abdominal fechado	Validação prospectiva multicêntrica	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=PECARN+blunt+abdominal+trauma+prospective+validation
1	Pediatric Appendicitis Score (PAS)	Escore pediátrico validado	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pediatric+Appendicitis+Score+validation
1	PedNIHSS — Pediatric NIH Stroke Scale	Escore pediátrico validado	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=PedNIHSS+validation
1	Phoenix Sepsis Score	Consenso internacional, 2024	https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2814296
1	PRAM — Pediatric Respiratory Assessment Measure	Escore pediátrico validado	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pediatric+Respiratory+Assessment+Measure+PRAM+validation
1	Westley Croup Score	Escore clínico validado	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Westley+croup+score
2	Buchanan Bleeding Score	Sangramento na PTI pediátrica	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Buchanan+bleeding+score+ITP
2	Classificação de Ross modificada	Insuficiência cardíaca pediátrica	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=modified+Ross+classification+pediatric+heart+failure
2	Escala de Coma de Glasgow Pediátrica	Versão pediátrica	https://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline_index/Head_injury/
2	PELOD-2	Disfunção orgânica pediátrica	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=PELOD-2+validation
2	Poisoning Severity Score (PSS)	Escore internacional de gravidade	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Poisoning+Severity+Score
2	Silverman–Andersen Score	Desconforto respiratório neonatal	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Silverman+Andersen+score
2	SIPA — Shock Index Pediatric Age-adjusted	Índice pediátrico ajustado por idade	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shock+Index+Pediatric+Age-adjusted+SIPA
3	Kobayashi Score — risco de resistência à imunoglobulina	Kawasaki; validação populacional variável	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kobayashi+score+Kawasaki+validation
3	PRISM IV	Modelo pediátrico, 2016	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=PRISM+IV+pediatric
3	SCORTEN	Prognóstico em NET/SSJ; não pediátrico específico	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=SCORTEN+validation
4	PIM 3	Modelo pediátrico validado	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=PIM3+pediatric+validation
5	PEWS — Pediatric Early Warning Score	National PEWS, 2023	https://www.england.nhs.uk/long-read/national-pews-observation-and-escalation-chart/

Regra de associação

Normalizar diagnóstico e categoria; buscar palavras-chave específicas; acrescentar scores gerais; ordenar por prioridade crescente, ano decrescente e nome; remover duplicatas; limitar a sete instrumentos por diagnóstico.

ANEXO C - ÍNDICE ALFABÉTICO DE MEDICAMENTOS

265 medicamentos únicos. A presença no índice não autoriza uso automático.

Medicamento 1	Medicamento 2	Medicamento 3	Medicamento 4
Acebrofilina	Acetilcisteína	Aciclovir	Ácido acetilsalicílico (Aspirina)
Ácido fusídico	Ácido mefenâmico	Ácido nalidíxico	Adenosina
Adrenalina (epinefrina)	Albendazol	Alizaprida	Amantadina
Amicacina	Amilorida	Aminofilina	Amoxicilina
Amoxicilina + clavulanato de potássio	Amoxicilina + Sulbactam	Ampicilina	Ampicilina + sulbactam
Ampicilina-sulbactam	Anfotericina B	Azelastina	Azitromicina
Aztreonam	Bacitracina	Bamifilina	Beclometasona
Benzidamina	Benzilpenicilina	Benzoato de benzila	Betametasona
Brometo de N-butilescopolamina	Bromexina	Bromoprida	Budesonida
Bumetanida	Buprenorfina	Cambendazol	Captopril
Carbamazepina	Carbocisteína	Cefaclor	Cefadroxila
Cefalexina	Cefalotina	Cefazolina	Cefepima
Cefotaxima	Cefprozila	Ceftazidima	Ceftriaxona
Cefuroxima	Celulose natural	Cetamina	Cetirizina
Cetoconazol	Cetoprofeno	Ciclesonida	Ciclopiroxolamina
Cimetidina	Cinchocaína	Ciprofloxacina	Claritromicina
Clemastina	Clindamicina	Clioquinol	Clobazam
Clonazepam	Clonidina	Cloperastina	Cloranfenicol
Cloreto de potássio (KCl)	Cloreto de sódio 0,9%	Cloroquina	Clorpromazina
Clotrimazol	Codeína	Colagenase	Colchicina
Cromoglicato dissódico	Deflazacorte	Deltametrina	Desloratadina
Dexametasona	Dexmedetomidina	Dextroclorfeniramina	Dextrometorfano
Diazepam	Dicicloverina	Diclofenaco (dietilamônio, potássico, sódico)	Didanosina
Digoxina	Dimenidrinato	Dimeticona	Dipirona (metamizol)
Dobutamina	Domperidona	Dopamina	Dornase alfa
Doxiciclina	Dropropizina	Ebastina	Emedastina
Epinaestina	Erdosteína	Eritromicina	Escopolamina
Esmolol	Espiramicina	Espironolactona	Etofamida
Etomidato	Fenitoína	Fenobarbital	Fenoterol
Fentanila	Fexofenadina	Fitomenadiona (Vitamina K)	Fluconazol
Flumazenil	Fluticasona	Formoterol	Furazolidona
Furosemida	Gentamicina	Glucametacina	Gluconato de cálcio
Gramicidina	Granisetrona	Griseofulvina	Haloperidol
Hidralazina	Hidrato de cloral	Hidroclorotiazida	Hidrocortisona
Hidroxicloroquina	Hidróxido de alumínio + magnésio	Hidroxiquinolina	Hidroxizina
Hioscina	Ibuprofeno	Idoxuridina	Imipenem / cilastatina sódica
Indometacina	Ipratrópio brometo	Isoniazida	Ivermectina
Ketodex (cetamina + dexmedetomidina)	Labetalol	Lactulose	Lamotrigina
Lanatosídeo C	Levocabastina	Levodropropizina	Levofloxacina
Levotiroxina sódica	Lidocaína	Lincomicina	Linezolida
Lodoxamida	Loratadina	Manitol	Mebendazol
Meropenem	Metoclopramida	Metronidazol	Midazolam
Mometasona	Monossulfiram	Montelucaste sódico	Morfina
Moxifloxacina	Mupirocina	N-acetil aspartilglutamato de sódio	Naloxona
Naproxeno	Nedocromil sódico	Neomicina	Nifedipina

Medicamento 1	Medicamento 2	Medicamento 3	Medicamento 4
Nimesulida	Nimorazol	Nistatina	Nitrofurantoína
Nitroglicerina	Nitroprussiato de sódio	Noradrenalina (norepinefrina)	Óleo mineral
Olopatadina	Omeprazol	Ondansetrona	Oxacilina
Oxcarbazepina	Oxiconazol	Oxitetraciclina	Pantoprazol
Paracetamol (acetaminofeno)	Penicilamina	Penicilina (benzatina, G, V)	Penicilina G benzatina
Penicilina G cristalina	Penicilina G procaína	Permetrina	Petidina (Meperidina)
Picossulfato sódico	Pimetixeno	Pipazetato	Pirantel (Pamoato)
Pirimetamina	Pirvínio (Pamoato)	Polimixina B	Prednisolona
Prednisona	Prometazina	Propranolol	Ranitidina
Rifampicina	Roxitromicina	Saccharomyces boulardii	Salbutamol — inalador
Salbutamol — nebulização	Salmeterol	Secnidazol	Sertaconazol
Simeticona	Sinvastatina	Sobrerol	Solução de reidratação oral (SRO)
Somatropina (Hormônio do crescimento)	Soro glicosado 10%	Soro glicosado 5%	Soro glicosado 50%
Soro polieletrólítico balanceado	Sucralfato	Sulfadiazina de prata	Sulfametoxazol + Trimetoprima
Sulfato de magnésio	Surfactante pulmonar (porcino/bovino)	Suxametônio (succinilcolina)	Teicoplanina
Teofilina	Terbinafina	Terbutalina	Tetraciclina
Tioconazol	Tirotricina	Tobramicina	Tolnaftato
Topiramato	Tramadol	Triancinolona	Trimetoprima + Sulfadiazina
Urapidil	Ureia	Valproato sódico (Ácido valproico)	Vancomicina
Vigabatrina	Vitamina A	Vitamina B1 (Tiamina)	Vitamina B12
Vitamina B5 (Dexpantenol)	Vitamina B6 (Piridoxina)	Vitamina C	Vitamina E
Zafirlucaste			

ANEXO D - INVENTÁRIO FARMACOLÓGICO INTEGRAL

Todas as 577 linhas cadastradas. “Dose não automatizada” significa que a apresentação, idade, indicação e protocolo precisam ser validados antes da receita.

001. Acebrofilina - Broncoespasmo — terapia adjuvante selecionada, não de primeira linha

Via	VO ou EV conforme fármaco/produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Janela terapêutica estreita para xantinas; revisar interações, arritmia, convulsão e níveis quando aplicável
Status	Referência documental; benefício-risco e papel atual devem ser confirmados	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

002. Acetilcisteína - Intoxicação por paracetamol — antídoto

Via	EV ou VO	Apresentação	Apresentação EV/VO variável; confirmar concentração do produto
Dose	Regime de ataque e manutenção específico; usar nomograma/protocolo toxicológico	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Esquema contínuo por etapas; duração guiada por paracetamol, AST/ALT, INR e evolução	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Risco de reação anafilactoide EV; não atrasar quando indicação definida; consultar CIATox
Status	Esquema depende de protocolo, tempo e via; selecionar o regime antes de calcular	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

003. Acetilcisteína - Secreção respiratória espessa — uso mucolítico apenas quando individualmente indicado

Via	VO ou inalatória conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Pode aumentar volume de secreções/broncoespasmo; contraindicações e idade mínima variam por produto
Status	Não usar rotineiramente em IVAS/bronquiolite; resposta depende da idade e apresentação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

004. Aciclovir - Encefalite por HSV — tratamento hospitalar

Via	EV	Apresentação	Frasco-ampola; concentração reconstituída varia por produto
Dose	Selecionar faixa neonatal versus criança/adolescente e protocolo de SNC	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Ajustar função renal; hidratação e infusão adequada reduzem risco de nefrotoxicidade
Status	Dose varia por idade e pode usar mg/kg ou mg/m²; selecionar a faixa etária	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

005. Aciclovir - Infecção disseminada por HSV — tratamento hospitalar

Via	EV	Apresentação	Frasco-ampola; concentração reconstituída varia por produto
Dose	Selecionar faixa neonatal versus criança/adolescente e protocolo de SNC	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Ajustar função renal; hidratação e infusão adequada reduzem risco de nefrotoxicidade

Status	Dose varia por idade e pode usar mg/kg ou mg/m ² ; selecionar a faixa etária	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label
---------------	---	--------------------------	---

006. Aciclovir - Infecção por HSV — tratamento conforme idade, gravidade e imunidade

Via	VO ou EV conforme cenário	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Ajustar função renal; hidratação e monitorização renal na via EV
Status	Dose e unidade podem ser mg/kg ou mg/m ² ; selecionar síndrome e faixa etária antes de calcular	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

007. Aciclovir - Varicela — tratamento conforme idade, gravidade e imunidade

Via	VO ou EV conforme cenário	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Ajustar função renal; hidratação e monitorização renal na via EV
Status	Dose e unidade podem ser mg/kg ou mg/m ² ; selecionar síndrome e faixa etária antes de calcular	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

008. Ácido acetilsalicílico (Aspirina) - Antiagregação após fase aguda da doença de Kawasaki

Via	VO	Apresentação	Apresentação brasileira variável; confirmar produto e concentração com registro vigente na Anvisa
Dose	Dose antiagregante depende do protocolo; não automatizada nesta linha	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Risco de sangramento e síndrome de Reye; suspender/ajustar conforme infecção viral e orientação especializada
Status	Uso pediátrico específico sob protocolo/cardiopediatria	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

009. Ácido acetilsalicílico (Aspirina) - Doença de Kawasaki — antiagregação plaquetária

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Risco de sangramento e síndrome de Reye; dose varia entre fase inflamatória e antiagregante
Status	Uso pediátrico específico; não usar como antitérmico em virose	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

010. Ácido acetilsalicílico (Aspirina) - Doença de Kawasaki — fase inflamatória aguda

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Risco de sangramento e síndrome de Reye; dose varia entre fase inflamatória e antiagregante
Status	Uso pediátrico específico; não usar como antitérmico em virose	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

011. Ácido fusídico - Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto

Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Status	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

012. Ácido fusídico - Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto

Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Status	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

013. Ácido mefenâmico - Dor/inflamação ou indicação especializada — uso condicionado à idade e ao diagnóstico

Via	VO, retal ou tópica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Evitar em desidratação, doença renal, sangramento GI e dengue; AAS não usar em virose salvo indicação específica
Status	Resposta condicionada às restrições etárias e à indicação específica	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

014. Ácido nalidíxico - Uso anti-infeccioso histórico — avaliar alternativa contemporânea

Via	Conforme produto histórico	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Não utilizar com base apenas em manual antigo; confirmar registro, disponibilidade e protocolo especializado
Status	Mantido no inventário solicitado; sem cálculo por obsolescência ou ausência de papel atual rotineiro	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

015. Adenosina - Taquicardia supraventricular regular com pulso — 1ª dose

Via	EV/IO, push ultrarrápido seguido de flush	Apresentação	3 mg/mL
Dose	0,1 mg/kg	Máximo	máximo 6 mg
Intervalo	dose inicial; repetir com 0,2 mg/kg se necessário	Preparo	Usar acesso o mais proximal possível; administrar em push imediato e flush
Monitorização	ECG contínuo, PA, perfusão; registrar ritmo antes/durante/depois	Cautelas	Alta vigilância; sincronizar equipe e flush; considerar QRS e diagnóstico diferencial
Status	Diretriz PALS 2025	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

016. Adenosina - Taquicardia supraventricular regular com pulso — 2ª dose

Via	EV/IO, push ultrarrápido seguido de flush	Apresentação	3 mg/mL
Dose	0,2 mg/kg	Máximo	máximo 12 mg
Intervalo	após falha da 1ª dose	Preparo	Usar acesso o mais proximal possível; administrar em push imediato e flush
Monitorização	ECG contínuo, PA, perfusão; registrar ritmo antes/durante/depois	Cautelas	Alta vigilância; confirmar dose escalonada e diagnóstico de TSV regular
Status	Diretriz PALS 2025	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

017. Adrenalina (epinefrina) - Anafilaxia

Via	IM, coxa ântero-lateral	Apresentação	1 mg/mL
Dose	0,01 mg/kg	Máximo	0,5 mg/dose; alguns protocolos limitam criança a 0,3 mg
Intervalo	repetir após 5 min se necessário	Preparo	Pura; seringa de 1 mL
Monitorização	ABCDE, PA, FC, SpO ₂ ; observar resposta	Cautelas	Sem contraindicação absoluta na anafilaxia; confirmar limite institucional 0,3 vs 0,5 mg
Status	Diretriz pediátrica	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

018. Adrenalina (epinefrina) - Anafilaxia refratária após 2 doses IM

Via	EV em BIC	Apresentação	Padrões de infusão: 10 ou 20 mcg/mL
Dose	iniciar 0,05 mcg/kg/min; titular em ambiente monitorizado	Máximo	confirmar protocolo institucional
Intervalo	contínuo	Preparo	10 mcg/mL: 0,5 mg (0,5 mL de 1 mg/mL) e completar para 50 mL. 20 mcg/mL: 1 mg e completar para 50 mL. Bomba com biblioteca e dupla checagem.
Monitorização	PA contínua se possível, ECG, perfusão	Cautelas	Manter adrenalina IM enquanto prepara infusão; considerar UTI
Status	Off-label: infusão em anafilaxia refratária	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

019. Adrenalina (epinefrina) - Choque com disfunção miocárdica/baixo débito

Via	EV/IO em BIC	Apresentação	Padrões de infusão: 10 ou 20 mcg/mL
Dose	iniciar 0,05 mcg/kg/min; usual 0,05–0,3 mcg/kg/min	Máximo	máx. de referência 1 mcg/kg/min; titular ao efeito
Intervalo	contínuo	Preparo	10 mcg/mL: 0,5 mg em volume final de 50 mL. 20 mcg/mL: 1 mg em volume final de 50 mL. Bomba/biblioteca; central preferível.
Monitorização	PA, perfusão, lactato, diurese, ECG, sítio periférico	Cautelas	Alta vigilância; dupla checagem de mcg versus mg
Status	Diretriz pediátrica	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

020. Adrenalina (epinefrina) - Crupe moderado/grave com estridor em repouso

Via	Nebulização	Apresentação	1 mg/mL
Dose	0,5 mL/kg = 0,5 mg/kg	Máximo	5 mL = 5 mg
Intervalo	dose; repetir conforme resposta e suporte disponível	Preparo	Nebulizar volume calculado; completar volume apenas se o nebulizador exigir
Monitorização	FC, SpO ₂ , estridor; observar ≥3 h após última dose	Cautelas	Associar dexametasona; preparar via aérea se resposta inadequada
Status	Diretriz pediátrica; uso por nebulização	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

021. Adrenalina (epinefrina) - PCR

Via	EV/IO	Apresentação	1 mg/10 mL = 0,1 mg/mL
Dose	0,01 mg/kg = 10 mcg/kg	Máximo	1 mg/dose
Intervalo	a cada 3–5 min	Preparo	Solução 0,1 mg/mL; flush após dose
Monitorização	ECG, ETCO ₂ , qualidade da RCP	Cautelas	Não usar solução 1 mg/mL por engano na via EV/IO
Status	Diretriz pediátrica	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

022. Albendazol - Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via	VO ou tópica conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Status	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

023. Alizaprida - Náuseas/vômitos — uso selecionado após tratar a causa e avaliar risco de QT

Via	VO ou EV conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar QT, distonia/efeitos extrapiramidais, interações e distúrbios eletrolíticos
Status	Não usar rotineiramente; dose/idade dependem do produto e da indicação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

024. Amantadina - Indicação neurológica/sedativa especializada

Via	VO ou via hospitalar conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar depressão do SNC, QT, efeitos extrapiramidais e necessidade de monitorização cardiorrespiratória
Status	Uso restrito/off-label conforme cenário; selecionar protocolo especializado	Risco / off-label	Risco padrão; Off-label

025. Amicacina - Bacteremia ou sepse por bactéria Gram-negativa sensível — opção IM

Via	IM profunda	Apresentação	Ampola brasileira 500 mg/2 mL = 250 mg/mL
Dose	5 mg/kg/dose 8/8 h ou 7,5 mg/kg/dose 12/12 h	Máximo	máximo 1,5 g/dia; ajustar pelo nível sérico e função renal
Intervalo	8/8 h no esquema de 5 mg/kg ou 12/12 h no esquema de 7,5 mg/kg	Preparo	Aspirar diretamente da ampola de 250 mg/mL; não diluir para uso IM. Administrar profundamente em grande massa muscular.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos quando indicados, audição e função vestibular	Cautelas	Não misturar com outros fármacos. Ajustar dose/intervalo na disfunção renal; em doença grave, choque ou baixa massa muscular, preferir EV.
Status	Apresentação brasileira IM/EV; esquema convencional da bula brasileira	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

026. Amicacina - Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-negativa sensível — opção IM

Via	IM profunda	Apresentação	Ampola brasileira 500 mg/2 mL = 250 mg/mL
Dose	5 mg/kg/dose 8/8 h ou 7,5 mg/kg/dose 12/12 h	Máximo	máximo 1,5 g/dia; ajustar pelo nível sérico e função renal
Intervalo	8/8 h no esquema de 5 mg/kg ou 12/12 h no esquema de 7,5 mg/kg	Preparo	Aspirar diretamente da ampola de 250 mg/mL; não diluir para uso IM. Administrar profundamente em grande massa muscular.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos quando indicados, audição e função vestibular	Cautelas	Não misturar com outros fármacos. Ajustar dose/intervalo na disfunção renal; em doença grave, choque ou baixa massa muscular, preferir EV.
Status	Apresentação brasileira IM/EV; esquema convencional da bula brasileira	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

027. Amicacina - Infecção de queimadura por bactéria Gram-negativa sensível — opção IM

Via	IM profunda	Apresentação	Ampola brasileira 500 mg/2 mL = 250 mg/mL
Dose	5 mg/kg/dose 8/8 h ou 7,5 mg/kg/dose 12/12 h	Máximo	máximo 1,5 g/dia; ajustar pelo nível sérico e função renal
Intervalo	8/8 h no esquema de 5 mg/kg ou 12/12 h no esquema de 7,5 mg/kg	Preparo	Aspirar diretamente da ampola de 250 mg/mL; não diluir para uso IM. Administrar profundamente em grande massa muscular.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos quando indicados, audição e função vestibular	Cautelas	Não misturar com outros fármacos. Ajustar dose/intervalo na disfunção renal; em doença grave, choque ou baixa massa muscular, preferir EV.
Status	Apresentação brasileira IM/EV; esquema convencional da bula brasileira	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

028. Amicacina - Infecção grave por Gram-negativo

Via	EV	Apresentação	250 mg/mL
Dose	15–20 mg/kg/dose	Máximo	1,5 g/dose
Intervalo	a cada 24 h	Preparo	Diluir em SF 0,9% ou SG 5%; infundir em 30–60 min
Monitorização	Creatinina, diurese; níveis quando indicado	Cautelas	Ajustar intervalo na disfunção renal; antibiograma/protocolo local
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

029. Amicacina - Infecção intra-abdominal ou peritonite por bactéria Gram-negativa sensível — opção IM

Via	IM profunda	Apresentação	Ampola brasileira 500 mg/2 mL = 250 mg/mL
Dose	5 mg/kg/dose 8/8 h ou 7,5 mg/kg/dose 12/12 h	Máximo	máximo 1,5 g/dia; ajustar pelo nível sérico e função renal
Intervalo	8/8 h no esquema de 5 mg/kg ou 12/12 h no esquema de 7,5 mg/kg	Preparo	Aspirar diretamente da ampola de 250 mg/mL; não diluir para uso IM. Administrar profundamente em grande massa muscular.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos quando indicados, audição e função vestibular	Cautelas	Não misturar com outros fármacos. Ajustar dose/intervalo na disfunção renal; em doença grave, choque ou baixa massa muscular, preferir EV.
Status	Apresentação brasileira IM/EV; esquema convencional da bula brasileira	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

030. Amicacina - Infecção osteoarticular por bactéria Gram-negativa sensível — opção IM

Via	IM profunda	Apresentação	Ampola brasileira 500 mg/2 mL = 250 mg/mL
Dose	5 mg/kg/dose 8/8 h ou 7,5 mg/kg/dose 12/12 h	Máximo	máximo 1,5 g/dia; ajustar pelo nível sérico e função renal
Intervalo	8/8 h no esquema de 5 mg/kg ou 12/12 h no esquema de 7,5 mg/kg	Preparo	Aspirar diretamente da ampola de 250 mg/mL; não diluir para uso IM. Administrar profundamente em grande massa muscular.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos quando indicados, audição e função vestibular	Cautelas	Não misturar com outros fármacos. Ajustar dose/intervalo na disfunção renal; em doença grave, choque ou baixa massa muscular, preferir EV.
Status	Apresentação brasileira IM/EV; esquema convencional da bula brasileira	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

031. Amicacina - Infecção pós-operatória por bactéria Gram-negativa sensível — opção IM

Via	IM profunda	Apresentação	Ampola brasileira 500 mg/2 mL = 250 mg/mL
Dose	5 mg/kg/dose 8/8 h ou 7,5 mg/kg/dose 12/12 h	Máximo	máximo 1,5 g/dia; ajustar pelo nível sérico e função renal
Intervalo	8/8 h no esquema de 5 mg/kg ou 12/12 h no esquema de 7,5 mg/kg	Preparo	Aspirar diretamente da ampola de 250 mg/mL; não diluir para uso IM. Administrar profundamente em grande massa muscular.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos quando indicados, audição e função vestibular	Cautelas	Não misturar com outros fármacos. Ajustar dose/intervalo na disfunção renal; em doença grave, choque ou baixa massa muscular, preferir EV.
Status	Apresentação brasileira IM/EV; esquema convencional da bula brasileira	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

032. Amicacina - Infecção respiratória grave por bactéria Gram-negativa sensível — opção IM

Via	IM profunda	Apresentação	Ampola brasileira 500 mg/2 mL = 250 mg/mL
Dose	5 mg/kg/dose 8/8 h ou 7,5 mg/kg/dose 12/12 h	Máximo	máximo 1,5 g/dia; ajustar pelo nível sérico e função renal
Intervalo	8/8 h no esquema de 5 mg/kg ou 12/12 h no esquema de 7,5 mg/kg	Preparo	Aspirar diretamente da ampola de 250 mg/mL; não diluir para uso IM. Administrar profundamente em grande massa muscular.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos quando indicados, audição e função vestibular	Cautelas	Não misturar com outros fármacos. Ajustar dose/intervalo na disfunção renal; em doença grave, choque ou baixa massa muscular, preferir EV.
Status	Apresentação brasileira IM/EV; esquema convencional da bula brasileira	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

033. Amicacina - Infecção urinária recorrente, complicada ou grave por bactéria sensível — opção IM

Via	IM profunda	Apresentação	Ampola brasileira 500 mg/2 mL = 250 mg/mL
Dose	5 mg/kg/dose 8/8 h ou 7,5 mg/kg/dose 12/12 h	Máximo	máximo 1,5 g/dia; ajustar pelo nível sérico e função renal
Intervalo	8/8 h no esquema de 5 mg/kg ou 12/12 h no esquema de 7,5 mg/kg	Preparo	Aspirar diretamente da ampola de 250 mg/mL; não diluir para uso IM. Administrar profundamente em grande massa muscular.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos quando indicados, audição e função vestibular	Cautelas	Não misturar com outros fármacos. Ajustar dose/intervalo na disfunção renal; em doença grave, choque ou baixa massa muscular, preferir EV.
Status	Apresentação brasileira IM/EV; esquema convencional da bula brasileira	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

034. Amicacina - Seps neonatal por bactéria Gram-negativa sensível — ataque IM

Via	IM profunda	Apresentação	Ampola brasileira 100 mg/2 mL = 50 mg/mL
Dose	10 mg/kg, dose de ataque	Máximo	prosseguir com a linha de manutenção neonatal e ajustar por função renal/níveis
Intervalo	dose inicial única	Preparo	Aspirar diretamente da ampola de 50 mg/mL; não diluir para uso IM.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular	Cautelas	Prematuros podem iniciar diretamente com 7,5 mg/kg 12/12 h; validar idade gestacional e protocolo neonatal.
Status	Apresentação brasileira IM/EV; dose de ataque neonatal da bula brasileira	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

035. Amicacina - Seps neonatal por bactéria Gram-negativa sensível — manutenção IM

Via	IM profunda	Apresentação	Ampola brasileira 100 mg/2 mL = 50 mg/mL
Dose	7,5 mg/kg/dose	Máximo	ajustar por função renal, idade gestacional e níveis séricos
Intervalo	12/12 h	Preparo	Aspirar diretamente da ampola de 50 mg/mL; não diluir para uso IM.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular	Cautelas	Validar idade gestacional e protocolo neonatal; evitar associação com outros nefro/ototóxicos quando possível.
Status	Apresentação brasileira IM/EV; manutenção neonatal da bula brasileira	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

036. Amilorida - Doença cardiovascular/renal específica — tratamento especializado

Via	VO ou EV conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Monitorar PA, ECG, eletrólitos e função renal conforme fármaco; digoxina exige atenção à unidade mcg
Status	Dose depende de idade, função renal, alvo e co-medicações; não automatizada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

037. Aminofilina - Broncoespasmo — terapia adjuvante selecionada, não de primeira linha

Via	VO ou EV conforme fármaco/produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Janela terapêutica estreita para xantinas; revisar interações, arritmia, convulsão e níveis quando aplicável
Status	Referência documental; benefício-risco e papel atual devem ser confirmados	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

038. Amoxicilina - Otite média aguda — dose alta quando antibiótico indicado

Via	VO	Apresentação	Suspensão 400 mg/5 mL = 80 mg/mL
Dose	80–90 mg/kg/dia divididos 12/12 h = 40–45 mg/kg/dose	Máximo	máximo diário conforme protocolo/indicação; arquivo-base usa 4 g/dia
Intervalo	12/12 h; duração conforme foco e evolução	Preparo	Agitar; medir com seringa oral; confirmar concentração 400 mg/5 mL
Monitorização	Resposta em 48–72 h, tolerância GI, reação alérgica	Cautelas	Ajustar na disfunção renal; confirmar alergia a betalactâmicos
Status	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

039. Amoxicilina - Pneumonia adquirida na comunidade — tratamento oral de pneumococo suspeito

Via	VO	Apresentação	Suspensão 400 mg/5 mL = 80 mg/mL
Dose	80–90 mg/kg/dia divididos 12/12 h = 40–45 mg/kg/dose	Máximo	máximo diário conforme protocolo/indicação; arquivo-base usa 4 g/dia
Intervalo	12/12 h; duração conforme foco e evolução	Preparo	Agitar; medir com seringa oral; confirmar concentração 400 mg/5 mL
Monitorização	Resposta em 48–72 h, tolerância GI, reação alérgica	Cautelas	Ajustar na disfunção renal; confirmar alergia a betalactâmicos
Status	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

040. Amoxicilina - Rinossinusite bacteriana aguda — dose alta quando indicada

Via	VO	Apresentação	Suspensão 400 mg/5 mL = 80 mg/mL
Dose	80–90 mg/kg/dia divididos 12/12 h = 40–45 mg/kg/dose	Máximo	máximo diário conforme protocolo/indicação; arquivo-base usa 4 g/dia
Intervalo	12/12 h; duração conforme foco e evolução	Preparo	Agitar; medir com seringa oral; confirmar concentração 400 mg/5 mL
Monitorização	Resposta em 48–72 h, tolerância GI, reação alérgica	Cautelas	Ajustar na disfunção renal; confirmar alergia a betalactâmicos
Status	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

041. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Aborto séptico por agente sensível — adolescente >12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato	Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

042. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Amigdalite bacteriana por agente sensível — >12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato	Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

043. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Amigdalite bacteriana por agente sensível — 0 a <3 meses

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

044. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Amigdalite bacteriana por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

045. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Broncopneumonia por agente sensível — >12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato	Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

046. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Broncopneumonia por agente sensível — 0 a <3 meses

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

047. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Broncopneumonia por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

048. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Bronquite bacteriana aguda por agente sensível — >12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato	Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

049. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Bronquite bacteriana aguda por agente sensível — 0 a <3 meses

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

050. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Bronquite bacteriana aguda por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

051. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Bronquite bacteriana crônica exacerbada por agente sensível — >12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato	Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

052. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Bronquite bacteriana crônica exacerbada por agente sensível — 0 a <3 meses

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

053. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Bronquite bacteriana crônica exacerbada por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

054. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Celulite bacteriana por agente sensível — >12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato	Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

055. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Celulite bacteriana por agente sensível — 0 a <3 meses

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

056. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Celulite bacteriana por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

057. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Cistite por agente sensível — >12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato	Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

058. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Cistite por agente sensível — 0 a <3 meses

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

059. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Cistite por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

060. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Ferimento infectado por agente sensível — >12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato	Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

061. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Ferimento infectado por agente sensível — 0 a <3 meses

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

062. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Ferimento infectado por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

063. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Furúnculo ou abscesso por agente sensível — >12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato	Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

064. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Furúnculo ou abscesso por agente sensível — 0 a <3 meses

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

065. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Furúnculo ou abscesso por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

066. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Infecção genital feminina por agente sensível — >12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato	Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

067. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Infecção genital feminina por agente sensível — 0 a <3 meses

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

068. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Infecção genital feminina por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

069. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Infecção pós-cirúrgica por agente sensível — >12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato	Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

070. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Infecção pós-cirúrgica por agente sensível — 0 a <3 meses

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

071. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Infecção pós-cirúrgica por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

072. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Osteomielite por agente sensível — >12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato	Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

073. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Osteomielite por agente sensível — 0 a <3 meses

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

074. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Osteomielite por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/ictéria associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

075. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Otite média aguda com risco de beta-lactamase ou falha à amoxicilina

Via	VO	Apresentação	Suspensão 400 mg + 57 mg/5 mL; 80 mg/mL de amoxicilina
Dose	80–90 mg/kg/dia de amoxicilina divididos 12/12 h	Máximo	máximo pela amoxicilina conforme foco; minimizar clavulanato excessivo
Intervalo	12/12 h; duração conforme foco	Preparo	Calcular pela amoxicilina; agitar e refrigerar conforme bula do produto
Monitorização	Resposta clínica, diarreia, reação alérgica e hepatotoxicidade rara	Cautelas	Confirmar razão amoxicilina:clavulanato; ajustar função renal; alergia a betalactâmicos
Status	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

076. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Otite média bacteriana por agente sensível — >12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato	Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

077. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Otite média bacteriana por agente sensível — 0 a <3 meses

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

078. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Otite média bacteriana por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

079. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Peritonite por agente sensível — >12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato	Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

080. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Peritonite por agente sensível — 0 a <3 meses

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

081. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Peritonite por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

082. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Pielonefrite por agente sensível — >12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato	Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

083. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Pielonefrite por agente sensível — 0 a <3 meses

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

084. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Pielonefrite por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.

Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label
---------------	---	--------------------------	---

085. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Pneumonia lobar por agente sensível — >12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato	Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

086. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Pneumonia lobar por agente sensível — 0 a <3 meses

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

087. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Pneumonia lobar por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

088. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Rinossinusite bacteriana com risco de beta-lactamase ou falha à amoxicilina

Via	VO	Apresentação	Suspensão 400 mg + 57 mg/5 mL; 80 mg/mL de amoxicilina
Dose	80–90 mg/kg/dia de amoxicilina divididos 12/12 h	Máximo	máximo pela amoxicilina conforme foco; minimizar clavulanato excessivo
Intervalo	12/12 h; duração conforme foco	Preparo	Calcular pela amoxicilina; agitar e refrigerar conforme bula do produto
Monitorização	Resposta clínica, diarreia, reação alérgica e hepatotoxicidade rara	Cautelas	Confirmar razão amoxicilina:clavulanato; ajustar função renal; alergia a betalactâmicos
Status	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

089. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Sepse intra-abdominal por agente sensível — >12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato	Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

090. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Sepse intra-abdominal por agente sensível — 0 a <3 meses

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

091. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Sepse intra-abdominal por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal

Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

092. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Sepse por agente sensível — >12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato	Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

093. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Sepse por agente sensível — 0 a <3 meses

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

094. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Sepse por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.

Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

095. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Sepse puerperal por agente sensível — adolescente >12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato	Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

096. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Sinusite bacteriana por agente sensível — >12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato	Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

097. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Sinusite bacteriana por agente sensível — 0 a <3 meses

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

098. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Sinusite bacteriana por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

099. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Uretrite por agente sensível — >12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	1,2 g/dose = 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato	Máximo	1 frasco-ampola por dose; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

100. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Uretrite por agente sensível — 0 a <3 meses

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	12/12 h em prematuros e recém-nascidos; no período perinatal, pode passar a 8/8 h conforme evolução e protocolo	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

101. Amoxicilina + clavulanato de potássio - Uretrite por agente sensível — 3 meses a 12 anos

Via	EV — injeção lenta em 3–4 min ou infusão em 30–40 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1.000 mg de amoxicilina + 200 mg de clavulanato; adicionar 20 mL de água para injetáveis; volume final aproximado 20,9 mL = 47,85 mg/mL de amoxicilina + 9,57 mg/mL de clavulanato (50 + 10 mg/mL são valores nominais pelo diluente adicionado)
Dose	30 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de amoxicilina + 5 mg/kg de clavulanato	Máximo	a bula não explicita máximo pediátrico absoluto; se a dose exceder 1 frasco-ampola, confirmar estratégia de peso/obesidade e protocolo; ajustar na disfunção renal
Intervalo	8/8 h; em infecção grave, 6/6 h	Preparo	Uso exclusivamente EV. Injeção lenta: reconstituir com 20 mL de água para injetáveis, aspirar o volume calculado e administrar em 3–4 min. Infusão: o frasco completo pode ser diluído para 100 mL com diluente compatível e administrado em 30–40 min; para dose parcial, seguir farmácia/bula institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação de hipersensibilidade	Cautelas	Nunca IM. Não misturar na mesma seringa, frasco ou equipo com aminoglicosídeo. Confirmar alergia a betalactâmicos e antecedente de disfunção hepática/icterícia associada.
Status	Bula profissional brasileira; uso adulto e pediátrico; apresentação EV com registro no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

102. Amoxicilina + Sulbactam - Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Status	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

103. Ampicilina - Infecção grave sem acometimento do SNC

Via	EV	Apresentação	Frasco-ampola 500 mg ou 1 g; padrão operacional 100 mg/mL
Dose	50 mg/kg/dose	Máximo	2 g/dose
Intervalo	a cada 6 h	Preparo	Padrão operacional: 500 mg + 5 mL ou 1 g + 10 mL = 100 mg/mL. Confirmar volume de reconstituição na bula da marca; diluir depois se necessário.
Monitorização	Resposta clínica, culturas	Cautelas	Ajustar em insuficiência renal; alergia beta-lactâmico
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

104. Ampicilina - Meningite/infecção do SNC

Via	EV	Apresentação	Frasco-ampola 500 mg ou 1 g; padrão operacional 100 mg/mL
Dose	50 mg/kg/dose a cada 4 h OU 75 mg/kg/dose a cada 6 h	Máximo	2 g/dose; 300 mg/kg/dia
Intervalo	a cada 4–6 h	Preparo	Padrão operacional: 500 mg + 5 mL ou 1 g + 10 mL = 100 mg/mL. Confirmar bula da marca; usar o volume correspondente a 50 ou 75 mg/kg.
Monitorização	Culturas, LCR, função renal	Cautelas	RN: intervalo depende de IG e idade pós-natal
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

105. Ampicilina + sulbactam - Epiglottite bacteriana por agente sensível — opção IM após a primeira semana

Via	IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam
Dose	37,5 mg/kg/dose do produto 6/6 h ou 50 mg/kg/dose do produto 8/8 h = 25–33,33 mg/kg de ampicilina/dose	Máximo	máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes

Intervalo	6/6 h no esquema de 37,5 mg/kg/dose ou 8/8 h no esquema de 50 mg/kg/dose	Preparo	Reconstituir com água para injetáveis; lidocaína 0,5% pode reduzir dor somente quando não contraindicada. Usar a solução IM em até 1 hora e dividir volumes grandes entre sítios.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade	Cautelas	Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite, infecção intra-abdominal/pélvica grave ou necessidade de dose alta, preferir via EV.
Status	Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

106. Ampicilina + sulbactam - Epigloteite bacteriana por agente sensível — opção IM na primeira semana de vida

Via	IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam
Dose	37,5 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de ampicilina + 12,5 mg/kg de sulbactam	Máximo	máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes
Intervalo	12/12 h na primeira semana, especialmente em prematuros	Preparo	Reconstituir com água para injetáveis; usar a solução IM em até 1 hora. A lidocaína 0,5% não deve ser usada no recém-nascido.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade	Cautelas	Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite ou infecção grave, preferir via EV e protocolo neonatal.
Status	Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

107. Ampicilina + sulbactam - Infecção de pele ou tecidos moles por agente sensível — opção IM após a primeira semana

Via	IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam
Dose	37,5 mg/kg/dose do produto 6/6 h ou 50 mg/kg/dose do produto 8/8 h = 25–33,33 mg/kg de ampicilina/dose	Máximo	máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes
Intervalo	6/6 h no esquema de 37,5 mg/kg/dose ou 8/8 h no esquema de 50 mg/kg/dose	Preparo	Reconstituir com água para injetáveis; lidocaína 0,5% pode reduzir dor somente quando não contraindicada. Usar a solução IM em até 1 hora e dividir volumes grandes entre sítios.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade	Cautelas	Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite, infecção intra-abdominal/pélvica grave ou necessidade de dose alta, preferir via EV.
Status	Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

108. Ampicilina + sulbactam - Infecção de pele ou tecidos moles por agente sensível — opção IM na primeira semana de vida

Via	IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam
Dose	37,5 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de ampicilina + 12,5 mg/kg de sulbactam	Máximo	máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes
Intervalo	12/12 h na primeira semana, especialmente em prematuros	Preparo	Reconstituir com água para injetáveis; usar a solução IM em até 1 hora. A lidocaína 0,5% não deve ser usada no recém-nascido.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade	Cautelas	Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite ou infecção grave, preferir via EV e protocolo neonatal.
Status	Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

109. Ampicilina + sulbactam - Otite média bacteriana por agente sensível — opção IM após a primeira semana

Via	IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam
Dose	37,5 mg/kg/dose do produto 6/6 h ou 50 mg/kg/dose do produto 8/8 h = 25–33,33 mg/kg de ampicilina/dose	Máximo	máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes

Intervalo	6/6 h no esquema de 37,5 mg/kg/dose ou 8/8 h no esquema de 50 mg/kg/dose	Preparo	Reconstituir com água para injetáveis; lidocaína 0,5% pode reduzir dor somente quando não contraindicada. Usar a solução IM em até 1 hora e dividir volumes grandes entre sítios.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade	Cautelas	Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite, infecção intra-abdominal/pélvica grave ou necessidade de dose alta, preferir via EV.
Status	Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

110. Ampicilina + sulbactam - Otite média bacteriana por agente sensível — opção IM na primeira semana de vida

Via	IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam
Dose	37,5 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de ampicilina + 12,5 mg/kg de sulbactam	Máximo	máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes
Intervalo	12/12 h na primeira semana, especialmente em prematuros	Preparo	Reconstituir com água para injetáveis; usar a solução IM em até 1 hora. A lidocaína 0,5% não deve ser usada no recém-nascido.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade	Cautelas	Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite ou infecção grave, preferir via EV e protocolo neonatal.
Status	Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

111. Ampicilina + sulbactam - Pneumonia bacteriana por agente sensível — opção IM após a primeira semana

Via	IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam
Dose	37,5 mg/kg/dose do produto 6/6 h ou 50 mg/kg/dose do produto 8/8 h = 25–33,33 mg/kg de ampicilina/dose	Máximo	máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes
Intervalo	6/6 h no esquema de 37,5 mg/kg/dose ou 8/8 h no esquema de 50 mg/kg/dose	Preparo	Reconstituir com água para injetáveis; lidocaína 0,5% pode reduzir dor somente quando não contraindicada. Usar a solução IM em até 1 hora e dividir volumes grandes entre sítios.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade	Cautelas	Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite, infecção intra-abdominal/pélvica grave ou necessidade de dose alta, preferir via EV.
Status	Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

112. Ampicilina + sulbactam - Pneumonia bacteriana por agente sensível — opção IM na primeira semana de vida

Via	IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam
Dose	37,5 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de ampicilina + 12,5 mg/kg de sulbactam	Máximo	máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes
Intervalo	12/12 h na primeira semana, especialmente em prematuros	Preparo	Reconstituir com água para injetáveis; usar a solução IM em até 1 hora. A lidocaína 0,5% não deve ser usada no recém-nascido.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade	Cautelas	Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite ou infecção grave, preferir via EV e protocolo neonatal.
Status	Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

113. Ampicilina + sulbactam - Sinusite bacteriana por agente sensível — opção IM após a primeira semana

Via	IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam
Dose	37,5 mg/kg/dose do produto 6/6 h ou 50 mg/kg/dose do produto 8/8 h = 25–33,33 mg/kg de ampicilina/dose	Máximo	máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes

Intervalo	6/6 h no esquema de 37,5 mg/kg/dose ou 8/8 h no esquema de 50 mg/kg/dose	Preparo	Reconstituir com água para injetáveis; lidocaína 0,5% pode reduzir dor somente quando não contraindicada. Usar a solução IM em até 1 hora e dividir volumes grandes entre sítios.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade	Cautelas	Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite, infecção intra-abdominal/pélvica grave ou necessidade de dose alta, preferir via EV.
Status	Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

114. Ampicilina + sulbactam - Sinusite bacteriana por agente sensível — opção IM na primeira semana de vida

Via	IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g + 0,5 g (adicionar 3,2 mL) ou 2 g + 1 g (adicionar 6,4 mL) → 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam
Dose	37,5 mg/kg/dose do produto = 25 mg/kg de ampicilina + 12,5 mg/kg de sulbactam	Máximo	máximo operacional 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose; dividir volumes IM grandes
Intervalo	12/12 h na primeira semana, especialmente em prematuros	Preparo	Reconstituir com água para injetáveis; usar a solução IM em até 1 hora. A lidocaína 0,5% não deve ser usada no recém-nascido.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e hipersensibilidade	Cautelas	Não misturar com aminoglicosídeos. Em sepse, choque, meningite ou infecção grave, preferir via EV e protocolo neonatal.
Status	Bula profissional brasileira; apresentação IM/EV 1 g + 0,5 g ou 2 g + 1 g	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

115. Ampicilina-sulbactam - Infecção de pele e tecidos moles

Via	EV	Apresentação	1,5 g ou 3 g; 250 mg/mL de ampicilina após reconstituição
Dose	50 mg/kg/dose de ampicilina (= 75 mg/kg/dose do produto)	Máximo	2 g de ampicilina/dose
Intervalo	a cada 6 h	Preparo	Reconstituir conforme bula para 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam; para EV, diluir até 30 mg/mL de ampicilina (faixa de bula: 2–30 mg/mL).
Monitorização	Resposta, culturas, função hepática/renal	Cautelas	Ajustar em insuficiência renal; sempre declarar base ampicilina
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

116. Ampicilina-sulbactam - Infecção intra-abdominal bacteriana

Via	EV	Apresentação	1,5 g ou 3 g; 250 mg/mL de ampicilina após reconstituição
Dose	50 mg/kg/dose de ampicilina (= 75 mg/kg/dose do produto)	Máximo	2 g de ampicilina/dose
Intervalo	a cada 6 h	Preparo	Reconstituir conforme bula para 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam; para EV, diluir até 30 mg/mL de ampicilina (faixa de bula: 2–30 mg/mL).
Monitorização	Resposta, culturas, função hepática/renal	Cautelas	Ajustar em insuficiência renal; sempre declarar base ampicilina
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

117. Ampicilina-sulbactam - Infecção polimicrobiana grave

Via	EV	Apresentação	1,5 g ou 3 g; 250 mg/mL de ampicilina após reconstituição
Dose	50 mg/kg/dose de ampicilina	Máximo	2 g de ampicilina/dose
Intervalo	a cada 6 h	Preparo	Reconstituir conforme bula para 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam; para EV, diluir até 30 mg/mL de ampicilina.
Monitorização	Ferida, culturas quando indicadas	Cautelas	Avaliar profilaxia antirrábica/antitetânica conforme exposição
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

118. Ampicilina-sulbactam - Infecção respiratória bacteriana

Via	EV	Apresentação	1,5 g ou 3 g; 250 mg/mL de ampicilina após reconstituição
Dose	50 mg/kg/dose de ampicilina (= 75 mg/kg/dose do produto)	Máximo	2 g de ampicilina/dose
Intervalo	a cada 6 h	Preparo	Reconstituir conforme bula para 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam; para EV, diluir até 30 mg/mL de ampicilina (faixa de bula: 2–30 mg/mL).
Monitorização	Resposta, culturas, função hepática/renal	Cautelas	Ajustar em insuficiência renal; sempre declarar base ampicilina
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

119. Ampicilina-sulbactam - Mordedura animal

Via	EV	Apresentação	1,5 g ou 3 g; 250 mg/mL de ampicilina após reconstituição
Dose	50 mg/kg/dose de ampicilina	Máximo	2 g de ampicilina/dose
Intervalo	a cada 6 h	Preparo	Reconstituir conforme bula para 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam; para EV, diluir até 30 mg/mL de ampicilina.
Monitorização	Ferida, culturas quando indicadas	Cautelas	Avaliar profilaxia antirrábica/antitetânica conforme exposição
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

120. Ampicilina-sulbactam - Mordedura humana

Via	EV	Apresentação	1,5 g ou 3 g; 250 mg/mL de ampicilina após reconstituição
Dose	50 mg/kg/dose de ampicilina	Máximo	2 g de ampicilina/dose
Intervalo	a cada 6 h	Preparo	Reconstituir conforme bula para 250 mg/mL de ampicilina + 125 mg/mL de sulbactam; para EV, diluir até 30 mg/mL de ampicilina.
Monitorização	Ferida, culturas quando indicadas	Cautelas	Avaliar profilaxia antirrábica/antitetânica conforme exposição
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

121. Anfotericina B - Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente

Via	Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância
Status	Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

122. Azelastina - Conjuntivite alérgica — formulação ocular conforme produto

Via	Nasal ou oftálmica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Status	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

123. Azelastina - Rinite alérgica — formulação nasal conforme produto

Via	Nasal ou oftálmica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Status	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

124. Azitromicina - Pneumonia atípica — continuidade VO

Via	VO	Apresentação	Suspensão oral 200 mg/5 mL = 40 mg/mL
Dose	10 mg/kg no dia 1; 5 mg/kg/dia nos dias 2–5	Máximo	500 mg no dia 1; 250 mg/dia depois
Intervalo	a cada 24 h	Preparo	Reconstituir o frasco até o volume indicado pelo fabricante; concentração de referência 200 mg/5 mL. Agitar antes de cada retirada.
Monitorização	Resposta clínica	Cautelas	Uso deve seguir epidemiologia e protocolo antimicrobiano
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

125. Azitromicina - Pneumonia atípica com necessidade de via EV

Via	EV	Apresentação	Frasco-ampola 500 mg; solução final 1–2 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose	Máximo	500 mg/dose
Intervalo	a cada 24 h	Preparo	Reconstituir conforme bula e diluir a concentração final de 2 mg/mL (preferida para menor volume) ou 1 mg/mL; infundir por pelo menos 1 hora.
Monitorização	ECG se risco de QT, função hepática	Cautelas	Evitar associação com outros prolongadores de QT quando possível
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

126. Aztreonam - Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Status	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

127. Bacitracina - Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto

Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Status	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

128. Bacitracina - Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto

Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Status	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

129. Bamifilina - Broncoespasmo — terapia adjuvante selecionada, não de primeira linha

Via	VO ou EV conforme fármaco/produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Janela terapêutica estreita para xantinas; revisar interações, arritmia, convulsão e níveis quando aplicável
Status	Referência documental; benefício-risco e papel atual devem ser confirmados	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

130. Beclometasona - Controle de asma persistente

Via	Inalatória	Apresentação	Inalador 50 mcg/jato
Dose	100–400 mcg/dia, divididos	Máximo	definido pelo degrau terapêutico
Intervalo	1–2 vezes/dia	Preparo	Usar o dispositivo e espaçador; a unidade operacional é jato, não mL.
Monitorização	Controle de sintomas, técnica, crescimento em uso prolongado	Cautelas	Não é medicação de resgate
Status	Uso pediátrico em bula; dose depende da idade/dispositivo	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

131. Benzidamina - Dor/inflamação local — uso tópico conforme produto e idade

Via	Tópica/oromucosa/retal conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Evitar ingestão, uso em mucosa lesada extensa e formulação inadequada para a idade
Status	Posologia por aplicação depende da formulação; não converter em mL	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

132. Benzilpenicilina - Infecção por agente sensível — selecionar sal/formulação conforme síndrome

Via	VO, IM ou EV conforme sal	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar alergia, sal, concentração e via; penicilina benzatina nunca EV
Status	Não intercambiar benzatina, procaína, cristalina ou penicilina V; linhas específicas originais foram preservadas	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

133. Benzoato de benzila - Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via	VO ou tópica conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Status	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

134. Betametasona - Doença inflamatória/alérgica específica — corticoide sistêmico ou tópico

Via	VO, IM, tópica ou intra-articular conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Não usar rotineiramente em IVAS/bronquiolite; avaliar duração, desmame e imunossupressão
Status	Potência e equivalência variam; selecionar indicação e formulação antes de calcular	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

135. Brometo de N-butilescopolamina - Dor abdominal espasmódica — uso sintomático selecionado após excluir causa cirúrgica

Via	VO, IM ou EV conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Efeitos anticolinérgicos; evitar em glaucoma, retenção urinária, íleo e suspeita de obstrução
Status	Dose e idade mínima variam por sal/apresentação; não intercambiar sais	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

136. Bromexina - Secreção respiratória espessa — uso mucolítico apenas quando individualmente indicado

Via	VO ou inalatória conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Pode aumentar volume de secreções/broncoespasmo; contraindicações e idade mínima variam por produto
Status	Não usar rotineiramente em IVAS/bronquiolite; resposta depende da idade e apresentação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

137. Bromoprida - Náuseas/vômitos — uso selecionado após tratar a causa e avaliar risco de QT

Via	VO ou EV conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar QT, distonia/efeitos extrapiramidais, interações e distúrbios eletrolíticos
Status	Não usar rotineiramente; dose/idade dependem do produto e da indicação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

138. Budesonida - Controle de asma quando nebulização é necessária

Via	Nebulização	Apresentação	Suspensão 0,25 ou 0,5 mg/mL
Dose	0,25–0,5 mg/dose	Máximo	máximo depende da idade/degrau; usual até 1 mg/dia
Intervalo	1–2 vezes/dia	Preparo	Pura ou completar volume conforme nebulizador
Monitorização	Controle, candidíase oral, crescimento	Cautelas	Não é broncodilatador de resgate; não usar rotineiramente na bronquiolite
Status	Uso pediátrico em bula; ajustar por idade	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

139. Budesonida - Crupe quando dexametasona não é viável

Via	Nebulização	Apresentação	Suspensão para nebulização
Dose	2 mg, dose única	Máximo	2 mg
Intervalo	dose única	Preparo	Nebulizar; não misturar sem compatibilidade confirmada
Monitorização	Estridor, esforço respiratório	Cautelas	Dexametasona sistêmica continua preferida na maioria dos protocolos
Status	Off-label/alternativa em protocolo	Risco / off-label	Risco padrão; Off-label

140. Bumetanida - Doença cardiovascular/renal específica — tratamento especializado

Via	VO ou EV conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Monitorar PA, ECG, eletrólitos e função renal conforme fármaco; digoxina exige atenção à unidade mcg
Status	Dose depende de idade, função renal, alvo e co-medicações; não automatizada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

141. Buprenorfina - Dor moderada/intensa — opção opioide selecionada por protocolo e idade

Via	VO, EV, IM ou transmucosa conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Monitorar ventilação/sedação; codeína e tramadol têm restrições importantes em menores de 12 anos e após adenoamigdalectomia
Status	Uso restrito; resposta condicionada às contraindicações etárias e à variabilidade metabólica	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

142. Cambendazol - Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via	VO ou tópica conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Status	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

143. Captopril - Doença cardiovascular/renal específica — tratamento especializado

Via	VO ou EV conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Monitorar PA, ECG, eletrólitos e função renal conforme fármaco; digoxina exige atenção à unidade mcg
Status	Dose depende de idade, função renal, alvo e co-medicações; não automatizada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

144. Carbamazepina - Epilepsia — manutenção conforme tipo de crise e avaliação neuropediátrica

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Não iniciar/suspender abruptamente; revisar interações, teratogenicidade em adolescentes e monitorização específica
Status	Titulação gradual e dose dependem de idade, co-medicações e síndrome; não automatizada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

145. Carbocisteína - Secreção respiratória espessa — uso mucolítico apenas quando individualmente indicado

Via	VO ou inalatória conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Pode aumentar volume de secreções/broncoespasmo; contraindicações e idade mínima variam por produto
Status	Não usar rotineiramente em IVAS/bronquiolite; resposta depende da idade e apresentação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

146. Cefaclor - Otite média aguda por agente sensível — alternativa

Via	VO	Apresentação	Suspensão 250 mg/5 mL = 50 mg/mL
Dose	40 mg/kg/dia divididos 8/8 h = 13,33 mg/kg/dose	Máximo	máximo 1 g/dia no arquivo-base
Intervalo	8/8 h	Preparo	Reconstituir conforme bula; agitar antes de usar
Monitorização	Resposta clínica, alergia, diarreia	Cautelas	Ajustar função renal; confirmar alergia a cefalosporinas/betalactâmicos
Status	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

147. Cefaclor - Rinossinusite bacteriana por agente sensível — alternativa

Via	VO	Apresentação	Suspensão 250 mg/5 mL = 50 mg/mL
Dose	40 mg/kg/dia divididos 8/8 h = 13,33 mg/kg/dose	Máximo	máximo 1 g/dia no arquivo-base
Intervalo	8/8 h	Preparo	Reconstituir conforme bula; agitar antes de usar
Monitorização	Resposta clínica, alergia, diarreia	Cautelas	Ajustar função renal; confirmar alergia a cefalosporinas/betalactâmicos
Status	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

148. Cefadroxila - Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Status	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

149. Cefalexina - Infecção de pele/partes moles por agente sensível

Via	VO	Apresentação	Suspensão 250 mg/5 mL = 50 mg/mL
Dose	12,5 mg/kg/dose; o intervalo define 25 mg/kg/dia (12/12 h) ou 50 mg/kg/dia (6/6 h)	Máximo	máximo 4 g/dia no arquivo-base; confirmar indicação
Intervalo	dividir em 2–4 doses	Preparo	Reconstituir conforme bula; agitar; medir com seringa oral
Monitorização	Resposta clínica, tolerância GI, alergia	Cautelas	Ajustar na disfunção renal; confirmar alergia imediata grave a betalactâmicos
Status	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

150. Cefalexina - Infecção urinária afebril por agente sensível

Via	VO	Apresentação	Suspensão 250 mg/5 mL = 50 mg/mL
Dose	12,5 mg/kg/dose; o intervalo define 25 mg/kg/dia (12/12 h) ou 50 mg/kg/dia (6/6 h)	Máximo	máximo 4 g/dia no arquivo-base; confirmar indicação
Intervalo	dividir em 2–4 doses	Preparo	Reconstituir conforme bula; agitar; medir com seringa oral
Monitorização	Resposta clínica, tolerância GI, alergia	Cautelas	Ajustar na disfunção renal; confirmar alergia imediata grave a betalactâmicos
Status	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

151. Cefalotina - Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Status	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

152. Cefazolina - Infecção grave por MSSA

Via	EV	Apresentação	Frasco-ampola 1 g; solução de referência 100 mg/mL
Dose	50 mg/kg/dose	Máximo	2 g/dose
Intervalo	a cada 8 h	Preparo	Reconstituir 1 g para concentração de 100 mg/mL; para infusão, diluir adicionalmente conforme bula/protocolo e compatibilidade.
Monitorização	Culturas, função renal	Cautelas	Ajustar em insuficiência renal
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

153. Cefazolina - Infecção leve/moderada por MSSA/estreptococos

Via	EV	Apresentação	Frasco-ampola 1 g; solução de referência 100 mg/mL
Dose	25 mg/kg/dose	Máximo	1 g/dose
Intervalo	a cada 8 h	Preparo	Reconstituir 1 g para concentração de 100 mg/mL; para infusão, diluir adicionalmente conforme bula/protocolo e compatibilidade.
Monitorização	Culturas, resposta	Cautelas	Ajustar em insuficiência renal
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

154. Cefazolina - Profilaxia perioperatória

Via	EV	Apresentação	Frasco-ampola 1 g; solução de referência 100 mg/mL
Dose	30 mg/kg/dose	Máximo	2 g; 3 g se protocolo adulto/peso elevado
Intervalo	30–60 min antes da incisão; redose conforme duração/perda	Preparo	Reconstituir 1 g para concentração de 100 mg/mL; para infusão, diluir adicionalmente conforme bula/protocolo e compatibilidade.
Monitorização	Tempo da dose	Cautelas	Ajustar ao protocolo e tipo de cirurgia
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

155. Cefepima - Infecção de pele e estruturas cutâneas leve a moderada — opção IM — >2 meses e ≤40 kg

Via	IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g; adicionar 3 mL de água para injetáveis, SF 0,9% ou SG 5% → volume final aproximado 4,2 mL = 238 mg/mL
Dose	50 mg/kg/dose	Máximo	máximo 1 g/dose e 1 g por glúteo; acima de 40 kg usar dose fixa da linha correspondente
Intervalo	12/12 h por 10 dias; reavaliar foco, cultura e resposta	Preparo	Reconstituir o frasco de 1 g com 3 mL; aspirar o volume calculado. Administrar profundamente em grande massa muscular; não exceder 1 g por glúteo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal, neurotoxicidade e reação local	Cautelas	Via EV é preferencial em infecção grave, risco de morte, choque, sepse, meningite ou neutropenia febril. Ajustar na disfunção renal.
Status	Bula profissional brasileira; experiência pediátrica IM limitada; reservar a infecção leve/moderada selecionada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

156. Cefepima - Infecção de pele e estruturas cutâneas leve a moderada — opção IM — >40 kg

Via	IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g; adicionar 3 mL de água para injetáveis, SF 0,9% ou SG 5% → volume final aproximado 4,2 mL = 238 mg/mL
Dose	1 g/dose	Máximo	máximo 1 g por glúteo nesta linha
Intervalo	12/12 h; duração conforme foco e evolução	Preparo	Reconstituir o frasco de 1 g com 3 mL e administrar todo o volume final aproximado de 4,2 mL por IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal, neurotoxicidade e reação local	Cautelas	Via EV é preferencial em infecção grave, risco de morte, choque, sepse, meningite ou neutropenia febril. Ajustar na disfunção renal.
Status	Bula profissional brasileira; experiência pediátrica IM limitada; reservar a infecção leve/moderada selecionada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

157. Cefepima - Infecção do trato urinário leve a moderada — opção IM — >2 meses e ≤40 kg

Via	IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g; adicionar 3 mL de água para injetáveis, SF 0,9% ou SG 5% → volume final aproximado 4,2 mL = 238 mg/mL
Dose	50 mg/kg/dose	Máximo	máximo 1 g/dose e 1 g por glúteo; acima de 40 kg usar dose fixa da linha correspondente
Intervalo	12/12 h por 10 dias; reavaliar foco, cultura e resposta	Preparo	Reconstituir o frasco de 1 g com 3 mL; aspirar o volume calculado. Administrar profundamente em grande massa muscular; não exceder 1 g por glúteo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal, neurotoxicidade e reação local	Cautelas	Via EV é preferencial em infecção grave, risco de morte, choque, sepse, meningite ou neutropenia febril. Ajustar na disfunção renal.
Status	Bula profissional brasileira; experiência pediátrica IM limitada; reservar a infecção leve/moderada selecionada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

158. Cefepima - Infecção do trato urinário leve a moderada — opção IM — >40 kg

Via	IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g; adicionar 3 mL de água para injetáveis, SF 0,9% ou SG 5% → volume final aproximado 4,2 mL = 238 mg/mL
Dose	1 g/dose	Máximo	máximo 1 g por glúteo nesta linha
Intervalo	12/12 h; duração conforme foco e evolução	Preparo	Reconstituir o frasco de 1 g com 3 mL e administrar todo o volume final aproximado de 4,2 mL por IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal, neurotoxicidade e reação local	Cautelas	Via EV é preferencial em infecção grave, risco de morte, choque, sepse, meningite ou neutropenia febril. Ajustar na disfunção renal.
Status	Bula profissional brasileira; experiência pediátrica IM limitada; reservar a infecção leve/moderada selecionada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

159. Cefepima - Neutropenia febril

Via	EV	Apresentação	Frasco-ampola 1 g ou 2 g; 100 mg/mL reconstituído
Dose	50 mg/kg/dose	Máximo	2 g/dose
Intervalo	a cada 8 h	Preparo	Reconstituir para 100 mg/mL; aspirar o volume calculado e diluir para concentração final de 40 mg/mL (dentro da faixa de compatibilidade de bula).
Monitorização	Culturas, função renal	Cautelas	Ajustar em insuficiência renal

Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label
--------	-----------------------------	-------------------	--

160. Cefepima - Pneumonia bacteriana leve a moderada — opção IM — >2 meses e ≤40 kg

Via	IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g; adicionar 3 mL de água para injetáveis, SF 0,9% ou SG 5% → volume final aproximado 4,2 mL = 238 mg/mL
Dose	50 mg/kg/dose	Máximo	máximo 1 g/dose e 1 g por glúteo; acima de 40 kg usar dose fixa da linha correspondente
Intervalo	12/12 h por 10 dias; reavaliar foco, cultura e resposta	Preparo	Reconstituir o frasco de 1 g com 3 mL; aspirar o volume calculado. Administrar profundamente em grande massa muscular; não exceder 1 g por glúteo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal, neurotoxicidade e reação local	Cautelas	Via EV é preferencial em infecção grave, risco de morte, choque, sepse, meningite ou neutropenia febril. Ajustar na disfunção renal.
Status	Bula profissional brasileira; experiência pediátrica IM limitada; reservar a infecção leve/moderada selecionada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

161. Cefepima - Pneumonia bacteriana leve a moderada — opção IM — >40 kg

Via	IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g; adicionar 3 mL de água para injetáveis, SF 0,9% ou SG 5% → volume final aproximado 4,2 mL = 238 mg/mL
Dose	1 g/dose	Máximo	máximo 1 g por glúteo nesta linha
Intervalo	12/12 h; duração conforme foco e evolução	Preparo	Reconstituir o frasco de 1 g com 3 mL e administrar todo o volume final aproximado de 4,2 mL por IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal, neurotoxicidade e reação local	Cautelas	Via EV é preferencial em infecção grave, risco de morte, choque, sepse, meningite ou neutropenia febril. Ajustar na disfunção renal.
Status	Bula profissional brasileira; experiência pediátrica IM limitada; reservar a infecção leve/moderada selecionada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

162. Cefepima - Sepse/infecção grave com risco de Gram-negativo resistente

Via	EV	Apresentação	Frasco-ampola 1 g ou 2 g; 100 mg/mL reconstituído
Dose	50 mg/kg/dose	Máximo	2 g/dose
Intervalo	a cada 8 h	Preparo	Reconstituir para 100 mg/mL; aspirar o volume calculado e diluir para concentração final de 40 mg/mL (dentro da faixa de compatibilidade de bula).
Monitorização	Culturas, função renal, neurotoxicidade	Cautelas	Ajustar em insuficiência renal
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

163. Cefotaxima - Infecção com risco de vida por agente sensível — esquema EV

Via	EV	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 500 mg ou 1 g; solução reconstituída aproximadamente 215–216 mg/mL
Dose	50 mg/kg/dose = 200 mg/kg/dia	Máximo	máximo operacional 3 g/dose (12 g/dia); confirmar protocolo e infectologia
Intervalo	6/6 h	Preparo	Reconstituir conforme o frasco e administrar por infusão nas doses altas, conforme bula/protocolo institucional.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e neurotoxicidade	Cautelas	Alta vigilância; ajustar na disfunção renal e reavaliar diariamente descalonamento/antibiograma.
Status	Bula profissional brasileira; extremo superior de 200 mg/kg/dia reservado a risco de vida	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

164. Cefotaxima - Infecção por agente sensível — esquema EV usual

Via	EV	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 500 mg ou 1 g; adicionar 2 mL ou 4 mL, respectivamente → aproximadamente 215–216 mg/mL
Dose	25 mg/kg/dose = 50 mg/kg/dia	Máximo	máximo operacional 1 g/dose nesta linha; aumentar somente conforme gravidade/protocolo
Intervalo	12/12 h	Preparo	Reconstituir conforme o frasco; administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão conforme bula/protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e neurotoxicidade	Cautelas	Ajustar na disfunção renal. Não misturar com bicarbonato de sódio.
Status	Bula profissional brasileira; esquema usual selecionado dentro da faixa de 50–100 mg/kg/dia	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

165. Cefotaxima - Infecção por agente sensível — esquema IM usual

Via	IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 500 mg ou 1 g; adicionar 2 mL ou 4 mL, respectivamente → aproximadamente 215–216 mg/mL
Dose	25 mg/kg/dose = 50 mg/kg/dia	Máximo	máximo 1 g/dose e 2 g/dia por IM; dividir volume >4 mL entre sítios
Intervalo	12/12 h	Preparo	Reconstituir com água para injetáveis e aplicar profundamente. Lidocaína 1% pode ser usada apenas por IM, nunca EV, e é contraindicada abaixo de 30 meses ou nas demais contraindicações da lidocaína.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação local	Cautelas	Preferir EV em infecção grave, risco de vida ou dose diária >2 g. Não usar lidocaína em criança <30 meses.
Status	Bula profissional brasileira; IM somente em paciente estável e quando a dose diária não exceder 2 g	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

166. Cefotaxima - Infecção por agente sensível — EV no prematuro/RN com até 1 semana

Via	EV	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 500 mg ou 1 g; adicionar 2 mL ou 4 mL, respectivamente → aproximadamente 215–216 mg/mL
Dose	25–50 mg/kg/dose = 50–100 mg/kg/dia	Máximo	ajustar por idade gestacional, gravidade, função renal e protocolo neonatal
Intervalo	12/12 h	Preparo	Reconstituir conforme o frasco; administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão conforme bula/protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e neurotoxicidade	Cautelas	Não usar IM no prematuro/RN desta faixa. Não usar lidocaína por via EV.
Status	Bula profissional brasileira; somente EV nesta faixa neonatal	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

167. Cefotaxima - Infecção por agente sensível — EV no prematuro/RN de >1 a 4 semanas

Via	EV	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 500 mg ou 1 g; adicionar 2 mL ou 4 mL, respectivamente → aproximadamente 215–216 mg/mL
Dose	25–50 mg/kg/dose = 75–150 mg/kg/dia	Máximo	ajustar por idade gestacional, gravidade, função renal e protocolo neonatal
Intervalo	8/8 h	Preparo	Reconstituir conforme o frasco; administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão conforme bula/protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e neurotoxicidade	Cautelas	Não usar IM no prematuro/RN desta faixa. Não usar lidocaína por via EV.
Status	Bula profissional brasileira; somente EV nesta faixa neonatal	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

168. Cefotaxima - Infecção típica por agente sensível — adolescente >12 anos

Via	EV ou IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g; adicionar 4 mL → volume final aproximado 4,63 mL = 216 mg/mL
Dose	1 g/dose	Máximo	por IM, não exceder 2 g/dia e dividir volume >4 mL entre sítios; doses maiores devem ser EV
Intervalo	12/12 h	Preparo	Reconstituir com 4 mL. Para IM, aplicar profundamente e dividir entre sítios; para EV, administrar em 3–5 min ou infundir conforme bula.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação local	Cautelas	Lidocaína somente IM e se não houver contraindicação. Doses diárias >2 g devem ser EV.
Status	Bula profissional brasileira; posologia de adulto/adolescente >12 anos	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

169. Cefotaxima - Infecção típica por agente sensível — criança ≤12 anos com ≥50 kg

Via	EV ou IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 1 g; adicionar 4 mL → volume final aproximado 4,63 mL = 216 mg/mL
Dose	1 g/dose	Máximo	por IM, não exceder 2 g/dia e dividir volume >4 mL entre sítios; doses maiores devem ser EV
Intervalo	12/12 h	Preparo	Reconstituir com 4 mL. Para IM, aplicar profundamente e dividir entre sítios; para EV, administrar em 3–5 min ou infundir conforme bula.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal/hepática, hemograma e reação local	Cautelas	Lidocaína somente IM e se não houver contraindicação. Doses diárias >2 g devem ser EV.

Status	Bula profissional brasileira; posologia de adulto/adolescente >12 anos	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label
--------	--	-------------------	--

170. Cefprozila - Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Status	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

171. Ceftazidima - Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Status	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

172. Ceftriaxona - Meningite bacteriana

Via	EV	Apresentação	Frasco-ampola 1 g; 100 mg/mL reconstituído
Dose	50 mg/kg/dose	Máximo	2 g/dose; 4 g/dia
Intervalo	a cada 12 h	Preparo	EV: reconstituir 1 g conforme bula para 100 mg/mL; diluir o volume aspirado até 40 mg/mL. Aplicar restrições neonatais e incompatibilidade com cálcio.
Monitorização	LCR/culturas, resposta, função hepática	Cautelas	Não coadministrar com cálcio em RN ≤28 d; evitar em RN hiperbilirrubinêmico/prematuro
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

173. Ceftriaxona - Otite média aguda — resgate

Via	IM/EV	Apresentação	Frasco-ampola 1 g; IM 250 mg/mL ou EV final 40 mg/mL
Dose	50 mg/kg/dose	Máximo	1 g/dose
Intervalo	a cada 24 h por 1–3 dias conforme cenário	Preparo	IM: reconstituir conforme bula para 250 mg/mL. EV: reconstituir e diluir até 40 mg/mL. Não usar diluente com lidocaína por via EV.
Monitorização	Resposta em 48–72 h	Cautelas	Indicação depende de falha/intolerância e diagnóstico
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

174. Ceftriaxona - Sepse, pneumonia ou outra infecção grave sem meningite

Via	EV/IM	Apresentação	Frasco-ampola 1 g; 100 mg/mL reconstituído
Dose	50 mg/kg/dose	Máximo	2 g/dose
Intervalo	a cada 24 h	Preparo	EV: reconstituir conforme bula para 100 mg/mL e diluir até 40 mg/mL; não misturar/coadministrar com cálcio quando contraindicado.
Monitorização	Culturas, função hepática/biliar	Cautelas	RN: contraindicações específicas para prematuridade, hiperbilirrubinemia e cálcio EV
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

175. Cefuroxima - Infecção de pele e tecidos moles por agente sensível — opção EV

Via	EV	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro Keroxime® 750 mg; EV: adicionar 8 mL de água para injetáveis → volume final aproximado 8,6 mL = 87,21 mg/mL
Dose	20 mg/kg/dose = 60 mg/kg/dia divididos 8/8 h	Máximo	máximo 750 mg/dose nesta linha; doses maiores dependem da gravidade e protocolo
Intervalo	8/8 h; duração conforme foco, cultura e resposta	Preparo	Adicionar 8 mL de água para injetáveis ao frasco de 750 mg; o volume final aproximado é 8,6 mL. Aspirar o volume calculado; administrar EV direta em 3–5 min ou diluir para infusão conforme bula/protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal e hipersensibilidade	Cautelas	Não usar esta linha para meningite. Ajustar na disfunção renal e confirmar alergia a betalactâmicos.
Status	Apresentação brasileira IM/EV; regime usual de 60 mg/kg/dia para a maioria das infecções, fora de meningite	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

176. Cefuroxima - Infecção de pele e tecidos moles por agente sensível — opção IM

Via	IM	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 750 mg; IM: adicionar 3 mL de água para injetáveis → volume final aproximado 3,5 mL = 214,29 mg/mL
Dose	20 mg/kg/dose = 60 mg/kg/dia divididos 8/8 h	Máximo	máximo 750 mg/dose nesta linha; doses maiores dependem da gravidade e protocolo
Intervalo	8/8 h; duração conforme foco, cultura e resposta	Preparo	Adicionar 3 mL de água para injetáveis ao frasco de 750 mg e agitar delicadamente até formar suspensão opaca; o volume final aproximado é 3,5 mL. Aspirar o volume calculado.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal e hipersensibilidade	Cautelas	Não usar esta linha para meningite. Ajustar na disfunção renal e confirmar alergia a betalactâmicos.
Status	Apresentação brasileira IM/EV; regime usual de 60 mg/kg/dia para a maioria das infecções, fora de meningite	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

177. Cefuroxima - Infecção do trato urinário por agente sensível — opção EV

Via	EV	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro Keroxime® 750 mg; EV: adicionar 8 mL de água para injetáveis → volume final aproximado 8,6 mL = 87,21 mg/mL
Dose	20 mg/kg/dose = 60 mg/kg/dia divididos 8/8 h	Máximo	máximo 750 mg/dose nesta linha; doses maiores dependem da gravidade e protocolo
Intervalo	8/8 h; duração conforme foco, cultura e resposta	Preparo	Adicionar 8 mL de água para injetáveis ao frasco de 750 mg; o volume final aproximado é 8,6 mL. Aspirar o volume calculado; administrar EV direta em 3–5 min ou diluir para infusão conforme bula/protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal e hipersensibilidade	Cautelas	Não usar esta linha para meningite. Ajustar na disfunção renal e confirmar alergia a betalactâmicos.
Status	Apresentação brasileira IM/EV; regime usual de 60 mg/kg/dia para a maioria das infecções, fora de meningite	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

178. Cefuroxima - Infecção do trato urinário por agente sensível — opção IM

Via	IM	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 750 mg; IM: adicionar 3 mL de água para injetáveis → volume final aproximado 3,5 mL = 214,29 mg/mL
Dose	20 mg/kg/dose = 60 mg/kg/dia divididos 8/8 h	Máximo	máximo 750 mg/dose nesta linha; doses maiores dependem da gravidade e protocolo
Intervalo	8/8 h; duração conforme foco, cultura e resposta	Preparo	Adicionar 3 mL de água para injetáveis ao frasco de 750 mg e agitar delicadamente até formar suspensão opaca; o volume final aproximado é 3,5 mL. Aspirar o volume calculado.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal e hipersensibilidade	Cautelas	Não usar esta linha para meningite. Ajustar na disfunção renal e confirmar alergia a betalactâmicos.
Status	Apresentação brasileira IM/EV; regime usual de 60 mg/kg/dia para a maioria das infecções, fora de meningite	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

179. Cefuroxima - Otite média aguda por agente sensível — alternativa oral

Via	VO	Apresentação	Suspensão 250 mg/5 mL = 50 mg/mL
Dose	30 mg/kg/dia divididos 12/12 h = 15 mg/kg/dose	Máximo	máximo 1 g/dia no arquivo-base para OMA/sinusite/piodermite
Intervalo	12/12 h	Preparo	Reconstituir conforme bula; administrar após alimento quando indicado pelo produto
Monitorização	Resposta clínica, alergia e tolerância GI	Cautelas	Ajustar na disfunção renal; confirmar alergia a betalactâmicos
Status	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

180. Cefuroxima - Pneumonia adquirida na comunidade por agente sensível — alternativa oral

Via	VO	Apresentação	Suspensão 250 mg/5 mL = 50 mg/mL
Dose	30 mg/kg/dia divididos 12/12 h = 15 mg/kg/dose	Máximo	máximo 1 g/dia no arquivo-base para OMA/sinusite/piodermite
Intervalo	12/12 h	Preparo	Reconstituir conforme bula; administrar após alimento quando indicado pelo produto
Monitorização	Resposta clínica, alergia e tolerância GI	Cautelas	Ajustar na disfunção renal; confirmar alergia a betalactâmicos
Status	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

181. Cefuroxima - Pneumonia bacteriana por agente sensível — opção EV

Via	EV	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro Keroxime® 750 mg; EV: adicionar 8 mL de água para injetáveis → volume final aproximado 8,6 mL = 87,21 mg/mL
Dose	20 mg/kg/dose = 60 mg/kg/dia divididos 8/8 h	Máximo	máximo 750 mg/dose nesta linha; doses maiores dependem da gravidade e protocolo
Intervalo	8/8 h; duração conforme foco, cultura e resposta	Preparo	Adicionar 8 mL de água para injetáveis ao frasco de 750 mg; o volume final aproximado é 8,6 mL. Aspirar o volume calculado; administrar EV direta em 3–5 min ou diluir para infusão conforme bula/protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal e hipersensibilidade	Cautelas	Não usar esta linha para meningite. Ajustar na disfunção renal e confirmar alergia a betalactâmicos.
Status	Apresentação brasileira IM/EV; regime usual de 60 mg/kg/dia para a maioria das infecções, fora de meningite	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

182. Cefuroxima - Pneumonia bacteriana por agente sensível — opção IM

Via	IM	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 750 mg; IM: adicionar 3 mL de água para injetáveis → volume final aproximado 3,5 mL = 214,29 mg/mL
Dose	20 mg/kg/dose = 60 mg/kg/dia divididos 8/8 h	Máximo	máximo 750 mg/dose nesta linha; doses maiores dependem da gravidade e protocolo
Intervalo	8/8 h; duração conforme foco, cultura e resposta	Preparo	Adicionar 3 mL de água para injetáveis ao frasco de 750 mg e agitar delicadamente até formar suspensão opaca; o volume final aproximado é 3,5 mL. Aspirar o volume calculado.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função renal e hipersensibilidade	Cautelas	Não usar esta linha para meningite. Ajustar na disfunção renal e confirmar alergia a betalactâmicos.
Status	Apresentação brasileira IM/EV; regime usual de 60 mg/kg/dia para a maioria das infecções, fora de meningite	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

183. Cefuroxima - Rinossinusite bacteriana por agente sensível — alternativa oral

Via	VO	Apresentação	Suspensão 250 mg/5 mL = 50 mg/mL
Dose	30 mg/kg/dia divididos 12/12 h = 15 mg/kg/dose	Máximo	máximo 1 g/dia no arquivo-base para OMA/sinusite/piodermite
Intervalo	12/12 h	Preparo	Reconstituir conforme bula; administrar após alimento quando indicado pelo produto
Monitorização	Resposta clínica, alergia e tolerância GI	Cautelas	Ajustar na disfunção renal; confirmar alergia a betalactâmicos
Status	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

184. Celulose natural - Constipação funcional — desimpactação

Via	VO ou retal conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Excluir obstrução/sinais de alarme; óleo mineral tem risco de aspiração e restrições etárias
Status	Dose depende de idade, objetivo e resposta; não automatizada sem apresentação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

185. Celulose natural - Constipação funcional — manutenção

Via	VO ou retal conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Excluir obstrução/sinais de alarme; óleo mineral tem risco de aspiração e restrições etárias
Status	Dose depende de idade, objetivo e resposta; não automatizada sem apresentação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

186. Cetamina - Analgesia subdissociativa/infusão de dor aguda

Via	EV em BIC	Apresentação	50 mg/mL; preferir diluição padronizada
Dose	0,1–0,2 mg/kg bolus; 0,1–0,4 mg/kg/h	Máximo	máximo do protocolo especializado
Intervalo	contínuo	Preparo	Ex.: 50 mg/50 mL = 1 mg/mL; calcular mL/h pela dose
Monitorização	Dor, sedação, PA, FC, efeitos psicomiméticos	Cautelas	Prescrição por dor/anestesia/UTI; dupla checagem
Status	Off-label: analgesia subdissociativa	Risco / off-label	Risco padrão; Off-label

187. Cetamina - Indução em sequência rápida de intubação

Via	EV	Apresentação	50 mg/mL
Dose	1–2 mg/kg	Máximo	titular ao cenário; dose única
Intervalo	bolus lento	Preparo	Pode usar pura; diluir para volumes muito pequenos conforme protocolo
Monitorização	PA, FC, SpO ₂ , ETCO ₂ ; prontidão para via aérea	Cautelas	Não garante reflexos protetores; pode causar apneia/laringoespasma
Status	Uso anestésico estabelecido	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

188. Cetamina - Sedação dissociativa para procedimento

Via	EV	Apresentação	50 mg/mL
Dose	1–1,5 mg/kg inicial; 0,25–0,5 mg/kg de reforço	Máximo	4,5 mg/kg total; >2,5 mg/kg aumenta eventos
Intervalo	reforços a cada 10 min	Preparo	EV em 1–2 min; equipe e material de via aérea
Monitorização	Oximetria, ECG, observação contínua de via aérea	Cautelas	Considerar abortar se requerer >2,5 mg/kg
Status	Uso consolidado; pode ser off-label conforme produto	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

189. Cetamina - Sedação dissociativa sem acesso venoso

Via	IM	Apresentação	50 mg/mL
Dose	4 mg/kg inicial; reforço 2 mg/kg	Máximo	6 mg/kg total
Intervalo	reforço após 10 min	Preparo	IM profunda
Monitorização	Oximetria, ECG, observação de via aérea	Cautelas	Recuperação mais longa; risco de vômito/laringoespasma
Status	Uso consolidado; pode ser off-label conforme produto	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

190. Cetirizina - Rinite alérgica — tratamento sintomático conforme idade

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Status	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

191. Cetirizina - Urticária — tratamento sintomático conforme idade

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Status	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

192. Cetoconazol - Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente

Via	Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância
Status	Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

193. Cetoprofeno - Dor inflamatória — uso selecionado conforme idade/bula

Via	VO	Apresentação	Solução oral 20 mg/mL
Dose	1 mg/kg/dose	Máximo	máximo diário conforme idade e bula; arquivo-base cita 300 mg/dia
Intervalo	8/8–12/12 h conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar concentração 20 mg/mL; medir com seringa
Monitorização	Dor, tolerância GI, hidratação e função renal quando pertinente	Cautelas	Evitar em desidratação, disfunção renal, sangramento GI, dengue e alergia a AINE
Status	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

194. Ciclesonida - Asma persistente — controle de manutenção conforme fenótipo e idade

Via	Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão
Status	Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

195. Ciclesonida - Rinite alérgica — controle de manutenção conforme fenótipo e idade

Via	Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão
Status	Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

196. Ciclopiroxolamina - Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente

Via	Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância
Status	Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

197. Cimetidina - Doença ácido-péptica — uso selecionado

Via	VO ou EV conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar interações e função renal; não usar ranitidina disponível de origem não autorizada
Status	Ranitidina permanece suspensa/retirada por risco de NDMA; não gerar dose	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

198. Cimetidina - Refluxo gastroesofágico — uso selecionado

Via	VO ou EV conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar interações e função renal; não usar ranitidina disponível de origem não autorizada
Status	Ranitidina permanece suspensa/retirada por risco de NDMA; não gerar dose	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

199. Cinchocaína - Dor/inflamação local — uso tópico conforme produto e idade

Via	Tópica/oromucosa/retal conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Evitar ingestão, uso em mucosa lesada extensa e formulação inadequada para a idade
Status	Posologia por aplicação depende da formulação; não converter em mL	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

200. Ciprofloxacina - Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Status	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

201. Claritromicina - Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Status	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

202. Clemastina - Rinite alérgica — tratamento sintomático conforme idade

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Status	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

203. Clemastina - Urticária — tratamento sintomático conforme idade

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Status	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

204. Clindamicina - Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria sensível — gravidade moderada — opção IM

Via	IM profunda	Apresentação	Ampola brasileira 600 mg/4 mL = 150 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose = 30 mg/kg/dia	Máximo	máximo 600 mg (4 mL) por dose IM
Intervalo	8/8 h	Preparo	Usar sem diluição para administração IM; aplicar profundamente em grande massa muscular.
Monitorização	Resposta clínica, diarreia/colite por C. difficile, hemograma e função hepática em curso prolongado	Cautelas	Não usar para meningite. Em sepse, infecção necrosante, intra-abdominal/pélvica grave ou instabilidade, preferir EV e cobertura combinada apropriada.
Status	Apresentação brasileira IM/EV; dose parenteral pediátrica dentro da faixa de bula	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

205. Clindamicina - Infecção dentária por bactéria sensível — gravidade moderada — opção IM

Via	IM profunda	Apresentação	Ampola brasileira 600 mg/4 mL = 150 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose = 30 mg/kg/dia	Máximo	máximo 600 mg (4 mL) por dose IM
Intervalo	8/8 h	Preparo	Usar sem diluição para administração IM; aplicar profundamente em grande massa muscular.
Monitorização	Resposta clínica, diarreia/colite por C. difficile, hemograma e função hepática em curso prolongado	Cautelas	Não usar para meningite. Em sepse, infecção necrosante, intra-abdominal/pélvica grave ou instabilidade, preferir EV e cobertura combinada apropriada.
Status	Apresentação brasileira IM/EV; dose parenteral pediátrica dentro da faixa de bula	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

206. Clindamicina - Infecção osteoarticular ou toxina/necrosante

Via	EV	Apresentação	150 mg/mL
Dose	13 mg/kg/dose	Máximo	900 mg/dose
Intervalo	a cada 8 h	Preparo	Diluir; associar ao antimicrobiano definitivo quando supressão de toxina
Monitorização	Culturas, CK conforme síndrome, colite	Cautelas	Não usar monoterapia em choque toxigênico sem cobertura adequada
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

207. Clindamicina - Infecção respiratória por bactéria sensível — gravidade moderada — opção IM

Via	IM profunda	Apresentação	Ampola brasileira 600 mg/4 mL = 150 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose = 30 mg/kg/dia	Máximo	máximo 600 mg (4 mL) por dose IM
Intervalo	8/8 h	Preparo	Usar sem diluição para administração IM; aplicar profundamente em grande massa muscular.
Monitorização	Resposta clínica, diarreia/colite por C. difficile, hemograma e função hepática em curso prolongado	Cautelas	Não usar para meningite. Em sepse, infecção necrosante, intra-abdominal/pélvica grave ou instabilidade, preferir EV e cobertura combinada apropriada.
Status	Apresentação brasileira IM/EV; dose parenteral pediátrica dentro da faixa de bula	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

208. Clindamicina - Pele/tecidos moles, anaeróbios, infecção dentária

Via	EV	Apresentação	600 mg/4 mL = 150 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose	Máximo	600 mg/dose
Intervalo	a cada 8 h	Preparo	Diluir e respeitar velocidade da bula
Monitorização	Diarreia/colite, função hepática	Cautelas	Sem ajuste renal rotineiro; ajustar contexto hepático
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

209. Clotrimazol - Uso anti-fúngico intestinal/tópico histórico — confirmar papel atual

Via	VO ou tópica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar registro, formulação e alternativa com melhor evidência
Status	Mantido no inventário solicitado; sem cálculo por baixa padronização atual	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

210. Clobazam - Epilepsia — manutenção conforme tipo de crise e avaliação neuropediátrica

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Não iniciar/suspender abruptamente; revisar interações, teratogenicidade em adolescentes e monitorização específica
Status	Titulação gradual e dose dependem de idade, co-medicações e síndrome; não automatizada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

211. Clonazepam - Epilepsia — manutenção conforme tipo de crise e avaliação neuropediátrica

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Não iniciar/suspender abruptamente; revisar interações, teratogenicidade em adolescentes e monitorização específica
Status	Titulação gradual e dose dependem de idade, co-medicações e síndrome; não automatizada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

212. Clonidina - Abstinência de opioide/sedativo — prevenção ou tratamento

Via	VO/enteral	Apresentação	Comprimido 0,1 mg = 100 mcg; solução oral 10 mcg/mL somente se padronizada pela farmácia
Dose	inicial 0,5–1 mcg/kg/dose a cada 6 h; usual 0,5–4 mcg/kg/dose a cada 4–6 h	Máximo	4 mcg/kg/dose a cada 4 h
Intervalo	a cada 4–6 h; usar a menor dose eficaz	Preparo	Usar solução 10 mcg/mL preparada/validada pela farmácia. Não improvisar solução à beira-leito sem dados de homogeneidade e estabilidade
Monitorização	PA, FC, sedação e escore de abstinência	Cautelas	Reter/reduzir se bradicardia ou hipotensão; retirar gradualmente em 1–2 semanas para evitar hipertensão rebote
Status	Off-label pediátrico	Risco / off-label	Risco padrão; Off-label

213. Clonidina - Transição/desmame de dexmedetomidina prolongada

Via	VO/enteral	Apresentação	Comprimido 0,1 mg = 100 mcg; solução oral 10 mcg/mL somente se padronizada pela farmácia
Dose	1 mcg/kg/dose a cada 6 h foi o regime inicial mais frequente em protocolo publicado; individualizar	Máximo	não há conversão universal dexmedetomidina→clonidina
Intervalo	a cada 6 h durante a transição; desmame posterior protocolizado	Preparo	Usar solução 10 mcg/mL validada; reduzir a dexmedetomidina somente conforme protocolo e resposta hemodinâmica
Monitorização	PA, FC, WAT-1/sinais de abstinência de agonista α_2	Cautelas	Bradicardia/hipotensão; não suspender clonidina abruptamente; maior evidência observacional
Status	Off-label; protocolo institucional	Risco / off-label	Risco padrão; Off-label

214. Cloperastina - Tosse seca intensa — uso excepcional após excluir causa tratável

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Não usar em lactentes; revisar sedação, interação serotoninérgica e contraindicações específicas
Status	Antitussígeno não rotineiro; resposta depende das restrições etárias e do benefício esperado	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

215. Cloranfenicol - Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Status	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

216. Cloreto de potássio (KCl) - Aditivo em manutenção após diurese estabelecida

Via	EV em solução de manutenção	Apresentação	19,1% = 2,5 mEq/mL
Dose	20 mEq/L usual; individualizar 0–40 mEq/L	Máximo	não adicionar se oligúria/IR/hipercalcemia
Intervalo	contínuo	Preparo	Retirar 4 mL da bolsa de 500 mL e adicionar 4 mL de KCl 19,1%
Monitorização	K, creatinina, diurese	Cautelas	Homogeneizar e rotular; bomba; dupla checagem
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

217. Cloreto de potássio (KCl) - Reposição EV de hipocalemia

Via	EV em BIC	Apresentação	19,1% = 2,5 mEq/mL
Dose	0,5–1 mEq/kg conforme gravidade	Máximo	velocidade usual <0,25 mEq/kg/h; nunca >0,5 mEq/kg/h; máx. 30 mEq/h
Intervalo	contínuo; reavaliar por ciclos	Preparo	SEMPRE diluir; usual 20–40 mEq/L periférico; concentrações maiores só em protocolo
Monitorização	ECG, K seriado, função renal, acesso	Cautelas	Nunca IV direto; dupla checagem independente
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

218. Cloreto de sódio 0,9% - Choque/hipoperfusão — bolus

Via	EV/IO	Apresentação	Bolsa 100–500 mL
Dose	10–20 mL/kg	Máximo	reavaliar antes de repetir
Intervalo	bolus em 5–20 min conforme choque	Preparo	Solução pronta, aquecer se grande volume
Monitorização	Perfusão, PA, crepitações, hepatomegalia, diurese	Cautelas	Em sepse, reavaliar a cada bolus e interromper se sobrecarga
Status	Diretriz pediátrica	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

219. Cloreto de sódio 0,9% - Manutenção pediátrica isotônica

Via	EV	Apresentação	Bolsa; preferir com dextrose e K apropriados
Dose	100%: regra 4–2–1 mL/kg/h	Máximo	individualizar; frequentemente reduzir em risco de ADH
Intervalo	contínuo	Preparo	Combinar com dextrose e KCl apropriados; ver aba Soroterapia 100%
Monitorização	Na, glicemia, balanço, peso	Cautelas	Não usar fórmula automática em RN <28 d, DKA, IR, IC ou distúrbios do Na
Status	Diretriz pediátrica ≥28 dias	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

220. Cloroquina - Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via	VO ou tópica conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Status	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

221. Clorpromazina - Indicação neurológica/sedativa especializada

Via	VO ou via hospitalar conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar depressão do SNC, QT, efeitos extrapiramidais e necessidade de monitorização cardiorrespiratória
Status	Uso restrito/off-label conforme cenário; selecionar protocolo especializado	Risco / off-label	Risco padrão; Off-label

222. Clotrimazol - Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente

Via	Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância
Status	Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

223. Codeína - Dor moderada/intensa — opção opioide selecionada por protocolo e idade

Via	VO, EV, IM ou transmucosa conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Monitorar ventilação/sedação; codeína e tramadol têm restrições importantes em menores de 12 anos e após adenoamigdalectomia
Status	Uso restrito; resposta condicionada às contraindicações etárias e à variabilidade metabólica	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

224. Colagenase - Desbridamento enzimático de lesão selecionada

Via	Tópica	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Proteger pele íntegra; confirmar indicação e curativo/protocolo de feridas
Status	Aplicação depende da concentração, área e tipo de lesão; não calcular por peso	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

225. Colagenase - Hidratação cutânea de lesão selecionada

Via	Tópica	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Proteger pele íntegra; confirmar indicação e curativo/protocolo de feridas
Status	Aplicação depende da concentração, área e tipo de lesão; não calcular por peso	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

226. Colchicina - Doença inflamatória/metabólica específica — uso especializado

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Janela terapêutica/interações relevantes; monitorar hemograma, função renal/hepática conforme fármaco
Status	Dose e titulação dependem da doença e idade; não automatizada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

227. Cromoglicato dissódico - Conjuntivite alérgica — formulação ocular conforme produto

Via	Nasal ou oftálmica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Status	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

228. Cromoglicato dissódico - Rinite alérgica — formulação nasal conforme produto

Via	Nasal ou oftálmica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Status	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

229. Deflazacorte - Doença inflamatória/alérgica específica — corticoide sistêmico ou tópico

Via	VO, IM, tópica ou intra-articular conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Não usar rotineiramente em IVAS/bronquiolite; avaliar duração, desmame e imunossupressão
Status	Potência e equivalência variam; selecionar indicação e formulação antes de calcular	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

230. Deltametrina - Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via	VO ou tópica conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Status	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

231. Desloratadina - Rinite alérgica — tratamento sintomático conforme idade

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Status	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

232. Desloratadina - Urticária — tratamento sintomático conforme idade

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Status	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

233. Dexametasona - Crupe

Via	VO/IM/EV	Apresentação	4 mg/mL
Dose	0,6 mg/kg, dose única	Máximo	12 mg no protocolo RCH; até 16 mg em outros protocolos
Intervalo	dose única	Preparo	VO preferida se tolerada; EV/IM conforme gravidade
Monitorização	Estridor e esforço respiratório	Cautelas	Observar após adrenalina nebulizada; não atrasar manejo de via aérea
Status	Diretriz pediátrica	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

234. Dexametasona - Exacerbação aguda de asma

Via	VO/EV/IM	Apresentação	4 mg/mL
Dose	0,6 mg/kg/dose	Máximo	16 mg/dose
Intervalo	a cada 24 h por 1–2 doses	Preparo	VO se possível
Monitorização	Resposta clínica, glicemia em risco	Cautelas	Não substitui broncodilatador; esquema local pode usar prednisolona
Status	Diretriz pediátrica	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

235. Dexametasona - Meningite bacteriana — adjuvante selecionado

Via	EV	Apresentação	4 mg/mL
Dose	0,15 mg/kg/dose	Máximo	10 mg/dose
Intervalo	a cada 6 h por 4 dias	Preparo	Administrar antes ou com a primeira dose do antibiótico
Monitorização	Audição, evolução neurológica	Cautelas	Benefício depende de agente/epidemiologia; não iniciar tardiamente sem indicação
Status	Uso por indicação específica; confirmar protocolo	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

236. Dexmedetomidina - Sedação contínua em VM/pós-IOT

Via	EV em BIC	Apresentação	200 mcg/2 mL = 100 mcg/mL; solução final padrão 4 mcg/mL
Dose	0,2–1 mcg/kg/h; titular pela meta de sedação; evitar bolus em instabilidade	Máximo	até 2 mcg/kg/h apenas em protocolo especializado; usar a menor dose eficaz
Intervalo	contínuo; titular em incrementos conforme protocolo	Preparo	Aspirar 2 mL (200 mcg) + 48 mL de SF 0,9% = 50 mL a 4 mcg/mL. mL/h = dose×peso÷4
Monitorização	ECG, PA, SpO ₂ , perfusão e escala COMFORT-B/SBS; avaliar delirium/abstinência	Cautelas	Reduzir/titular cautelosamente na disfunção hepática; bradicardia, bloqueio AV, disfunção ventricular e hipovolemia; desmame após uso prolongado
Status	Off-label pediátrico no Brasil; diretriz/uso em CTI	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

237. Dexmedetomidina - Sedação de procedimento não invasivo — 1 mês a <2 anos

Via	EV em bomba	Apresentação	200 mcg/2 mL = 100 mcg/mL; solução final 4 mcg/mL
Dose	carga 1,5 mcg/kg em 10 min; manutenção 0,5–1,5 mcg/kg/h (iniciar 1,5 e titular)	Máximo	1,5 mcg/kg/h; não administrar carga rápida
Intervalo	carga em 10 min, seguida de infusão	Preparo	2 mL + 48 mL de SF 0,9% = 50 mL a 4 mcg/mL. Para a carga, programar mL/h = volume calculado×6 durante 10 min
Monitorização	ECG, PA, SpO ₂ e ventilação contínuas; capnografia conforme sedação; equipe de resgate de via aérea	Cautelas	Procedimento não doloroso; analgesia adicional se houver dor. Maior risco de bradicardia/hipotensão; reduzir na disfunção hepática

Status	Aprovado nos EUA (bula 05/2026); off-label pediátrico no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label
--------	---	-------------------	----------------------------

238. Dexmedetomidina - Sedação de procedimento não invasivo — 2 a <18 anos

Via	EV em bomba	Apresentação	200 mcg/2 mL = 100 mcg/mL; solução final 4 mcg/mL
Dose	carga 2 mcg/kg em 10 min; manutenção 0,5–1,5 mcg/kg/h (iniciar 1,5 e titular)	Máximo	1,5 mcg/kg/h; não administrar carga rápida
Intervalo	carga em 10 min, seguida de infusão	Preparo	2 mL + 48 mL de SF 0,9% = 50 mL a 4 mcg/mL. Para a carga, programar mL/h = volume calculado×6 durante 10 min
Monitorização	ECG, PA, SpO ₂ e ventilação contínuas; capnografia conforme sedação; equipe de resgate de via aérea	Cautelas	Procedimento não doloroso; analgesia adicional se houver dor. Maior risco de bradicardia/hipotensão; reduzir na disfunção hepática
Status	Aprovado nos EUA (bula 05/2026); off-label pediátrico no Brasil	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

239. Dexmedetomidina - Sedação para exame de imagem não doloroso (RM ou TC) sem acesso venoso — 1 mês a 10 anos

Via	IM profunda — off-label	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 200 mcg/2 mL = 100 mcg/mL; bula nacional aprova somente uso EV em adultos
Dose	1–4 mcg/kg por aplicação IM no estudo; foram usadas aplicações únicas ou repetidas e a dose total média foi 2,4 mcg/kg para TC e 2,9 mcg/kg para RM	Máximo	sem máximo absoluto pediátrico validado; não repetir automaticamente e não extrapolar fora de protocolo formal de sedação
Intervalo	aplicação inicial; reavaliar sedação e hemodinâmica após 10–15 min (início médio no estudo: 13 min); qualquer nova aplicação exige protocolo institucional	Preparo	Solução 100 mcg/mL sem diluição: 0,01–0,04 mL/kg/dose. Administrar profundamente em massa muscular adequada; documentar dose cumulativa.
Monitorização	Sedação formal: ECG, PA seriada, SpO ₂ contínua e capnografia conforme profundidade; equipe e material de resgate de via aérea disponíveis	Cautelas	Não usar como analgesia exclusiva em procedimento doloroso. No estudo, 14% tiveram hipotensão transitória; cautela em hipovolemia, bradicardia, bloqueio AV e disfunção ventricular. Reduzir/titular com cautela na disfunção hepática.
Status	Off-label pediátrico e off-label por via no Brasil; evidência observacional limitada (coorte retrospectiva de 65 crianças)	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

240. Dexmedetomidina - Sedação/premedicação para procedimento não doloroso — via intranasal off-label, de 1 mês a <18 anos

Via	Intranasal com atomizador — off-label	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 200 mcg/2 mL = 100 mcg/mL; uso intranasal da solução injetável é off-label
Dose	2–3 mcg/kg/dose IN; administrar 30–45 min antes quando usado como premedicação	Máximo	sem máximo absoluto pediátrico universal; volume preferencial ≤0,3 mL por narina por aplicação; não repetir automaticamente
Intervalo	dose única; reavaliar após 30 min conforme protocolo de sedação	Preparo	Solução 100 mcg/mL sem diluição: 0,02–0,03 mL/kg. Dividir o volume entre as narinas; se exceder 0,3 mL por narina, fracionar conforme protocolo/dispositivo.
Monitorização	Sedação formal: ECG, PA seriada, SpO ₂ contínua e capnografia conforme profundidade; equipe e material de resgate de via aérea disponíveis	Cautelas	Início mais lento e resposta variável; estímulo pode despertar o paciente. Bradicardia/hipotensão; cautela em hipovolemia, distúrbio de condução e disfunção ventricular/hepática. Analgesia adicional se o procedimento for doloroso.
Status	Off-label pediátrico e off-label por via no Brasil; sustentado por revisão sistemática pediátrica e protocolos especializados	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

241. Dextroclorfeniramina - Rinite alérgica — tratamento sintomático conforme idade

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Status	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

242. Dextroclorofeniramina - Urticária — tratamento sintomático conforme idade

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Status	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

243. Dextrometorfano - Tosse seca intensa — uso excepcional após excluir causa tratável

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Não usar em lactentes; revisar sedação, interação serotoninérgica e contraindicações específicas
Status	Antitussígeno não rotineiro; resposta depende das restrições etárias e do benefício esperado	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

244. Diazepam - Estado de mal epilético com acesso EV

Via	EV	Apresentação	5 mg/mL
Dose	0,15–0,2 mg/kg	Máximo	10 mg/dose
Intervalo	pode repetir uma vez conforme protocolo; máximo 2 benzodiazepínicos	Preparo	EV lento; não misturar sem compatibilidade
Monitorização	FR, SpO ₂ , PA; ventilação disponível	Cautelas	Risco de depressão respiratória e hipotensão
Status	Diretriz pediátrica	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

245. Diazepam - Estado de mal sem acesso venoso

Via	Retal	Apresentação	Solução retal padronizada 5 mg/mL ou aplicador comercial
Dose	0,5 mg/kg	Máximo	20 mg/dose
Intervalo	dose de resgate; respeitar total de benzodiazepínicos	Preparo	Cálculo válido apenas para solução retal 5 mg/mL. Se gel/aplicador pré-cheio, selecionar a dose comercial mais próxima conforme protocolo; não extrapolar ampola EV para via retal sem validação.
Monitorização	FR, SpO ₂ , nível de consciência	Cautelas	Via intranasal com ampola não deve ser presumida; usar produto/protocolo específico
Status	Diretriz pediátrica; formulação retal apropriada	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

246. Diclóverina - Dor abdominal espasmódica — uso sintomático selecionado após excluir causa cirúrgica

Via	VO, IM ou EV conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Efeitos anticolinérgicos; evitar em glaucoma, retenção urinária, íleo e suspeita de obstrução
Status	Dose e idade mínima variam por sal/apresentação; não intercambiar sais	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

247. Diclofenaco (dietilamônio, potássico, sódico) - Dor/inflamação ou indicação especializada — uso condicionado à idade e ao diagnóstico

Via	VO, retal ou tópica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo

Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Evitar em desidratação, doença renal, sangramento GI e dengue; AAS não usar em virose salvo indicação específica
Status	Resposta condicionada às restrições etárias e à indicação específica	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

248. Didanosina - Uso anti-infeccioso histórico — avaliar alternativa contemporânea

Via	Conforme produto histórico	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Não utilizar com base apenas em manual antigo; confirmar registro, disponibilidade e protocolo especializado
Status	Mantido no inventário solicitado; sem cálculo por obsolescência ou ausência de papel atual rotineiro	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

249. Digoxina - Doença cardiovascular/renal específica — tratamento especializado

Via	VO ou EV conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Monitorar PA, ECG, eletrólitos e função renal conforme fármaco; digoxina exige atenção à unidade mcg
Status	Dose depende de idade, função renal, alvo e co-medicações; não automatizada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

250. Digoxina - Taquiarritmia supraventricular — controle/manutenção selecionada

Via	VO ou EV	Apresentação	Elixir 50 mcg/mL; confirmar produto e unidade
Dose	Selecionar regime por idade e cardiopediatria; diferenciar mcg de mg	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Monitorar ECG, K, Mg, função renal e nível quando indicado; múltiplas interações
Status	Dose de ataque/manutenção varia por idade; selecionar o regime cardiopediátrico	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

251. Dimenidrinato - Náuseas/vômitos — uso selecionado após tratar a causa e avaliar risco de QT

Via	VO ou EV conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar QT, distonia/efeitos extrapiramidais, interações e distúrbios eletrolíticos
Status	Não usar rotineiramente; dose/idade dependem do produto e da indicação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

252. Dimeticona - Distensão/gases — alívio sintomático quando indicado

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Benefício variável; não mascara sinais de abdome agudo

Status	Dose fixa por faixa etária e concentração do produto; não converter sem selecionar apresentação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label
--------	---	-------------------	--

253. Dipirona (metamizol) - Dor aguda

Via	VO/EV/IM	Apresentação	500 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose	Máximo	respeitar máximo por peso/idade e bula do produto
Intervalo	a cada 6 h se necessário	Preparo	EV lenta; diluir se protocolo exigir
Monitorização	PA na via EV; reação alérgica	Cautelas	Evitar em hipersensibilidade a pirazonas ou discrasia prévia
Status	Uso pediátrico conforme protocolo brasileiro	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

254. Dipirona (metamizol) - Febre com desconforto

Via	VO/EV/IM	Apresentação	500 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose	Máximo	respeitar máximo por peso/idade e bula do produto
Intervalo	a cada 6 h se necessário	Preparo	EV lenta; diluir se protocolo exigir
Monitorização	PA na via EV; reação alérgica	Cautelas	Evitar em hipersensibilidade a pirazonas ou discrasia prévia
Status	Uso pediátrico conforme protocolo brasileiro	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

255. Dobutamina - Choque com baixo débito/disfunção miocárdica

Via	EV/IO em BIC	Apresentação	Concentração padrão 1.000 mcg/mL (1 mg/mL)
Dose	5–20 mcg/kg/min	Máximo	titular à perfusão e débito; máximo conforme protocolo
Intervalo	contínuo	Preparo	Preparar concentração final de 1 mg/mL conforme farmácia/protocolo; bomba e linha dedicada quando indicada
Monitorização	PA, ECG, perfusão, diurese, lactato e sítio do acesso	Cautelas	Alta vigilância; corrigir hipovolemia quando pertinente; pode causar taquiarritmia/hipotensão
Status	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

256. Domperidona - Náuseas/vômitos — uso selecionado após tratar a causa e avaliar risco de QT

Via	VO ou EV conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar QT, distonia/efeitos extrapiramidais, interações e distúrbios eletrolíticos
Status	Não usar rotineiramente; dose/idade dependem do produto e da indicação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

257. Dopamina - Choque com necessidade de suporte inotrópico/vasopressor — alternativa selecionada

Via	EV/IO em BIC	Apresentação	Concentração padrão 1.600 mcg/mL
Dose	5–20 mcg/kg/min	Máximo	titular ao efeito; preferir agentes orientados pelo fenótipo do choque
Intervalo	contínuo	Preparo	Preparar 400 mg em volume final de 250 mL = 1.600 mcg/mL; confirmar protocolo/biblioteca
Monitorização	PA, ECG, perfusão, lactato, diurese e sítio periférico	Cautelas	Alta vigilância; arritmogênica; não usar 'dose renal'
Status	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

258. Dornase alfa - Fibrose cística com secreção viscosa — manutenção inalatória

Via	Inalatória	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Não misturar com outros fármacos no nebulizador; seguir equipe de fibrose cística
Status	Dose fixa por ampola/dispositivo; uso especializado	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

259. Doxiciclina - Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Status	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

260. Dropropizina - Tosse seca intensa — uso excepcional após excluir causa tratável

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Não usar em lactentes; revisar sedação, interação serotoninérgica e contraindicações específicas
Status	Antitussígeno não rotineiro; resposta depende das restrições etárias e do benefício esperado	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

261. Ebastina - Rinite alérgica — tratamento sintomático conforme idade

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Status	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

262. Ebastina - Urticária — tratamento sintomático conforme idade

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Status	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

263. Emedastina - Conjuntivite alérgica — formulação ocular conforme produto

Via	Nasal ou oftálmica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Status	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

264. Emedastina - Rinite alérgica — formulação nasal conforme produto

Via	Nasal ou oftálmica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Status	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

265. Epinastina - Conjuntivite alérgica — formulação ocular conforme produto

Via	Nasal ou oftálmica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Status	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

266. Epinastina - Rinite alérgica — formulação nasal conforme produto

Via	Nasal ou oftálmica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Status	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

267. Erdosteína - Secreção respiratória espessa — uso mucolítico apenas quando individualmente indicado

Via	VO ou inalatória conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Pode aumentar volume de secreções/broncoespasmo; contraindicações e idade mínima variam por produto
Status	Não usar rotineiramente em IVAS/bronquiolite; resposta depende da idade e apresentação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

268. Eritromicina - Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Status	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

269. Escopolamina - Dor abdominal espasmódica — uso sintomático selecionado após excluir causa cirúrgica

Via	VO, IM ou EV conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Efeitos anticolinérgicos; evitar em glaucoma, retenção urinária, íleo e suspeita de obstrução
Status	Dose e idade mínima variam por sal/apresentação; não intercambiar sais	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

270. Esmolol - Emergência hipertensiva com indicação de beta-bloqueio

Via	EV em BIC	Apresentação	10 mg/mL
Dose	bolus 100–500 mcg/kg; depois 100–500 mcg/kg/min	Máximo	1.000 mcg/kg/min
Intervalo	contínuo	Preparo	Bomba e monitorização contínua
Monitorização	PA e ECG	Cautelas	Escolha depende da etiologia; evitar em asma/IC descompensada
Status	Off-label pediátrico	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

271. Esmolol - Taquiarritmia supraventricular/controle de frequência

Via	EV em BIC	Apresentação	10 mg/mL
Dose	bolus 100–500 mcg/kg; depois 100–500 mcg/kg/min	Máximo	1.000 mcg/kg/min
Intervalo	contínuo	Preparo	Diluição padronizada; bomba
Monitorização	ECG, PA contínua, perfusão	Cautelas	Evitar em choque, BAV, IC descompensada e broncoespasmo grave
Status	Off-label pediátrico	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

272. Espiramicina - Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Status	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

273. Espironolactona - Doença cardiovascular/renal específica — tratamento especializado

Via	VO ou EV conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Monitorar PA, ECG, eletrólitos e função renal conforme fármaco; digoxina exige atenção à unidade mcg
Status	Dose depende de idade, função renal, alvo e co-medicações; não automatizada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

274. Etofamida - Uso anti-infeccioso intestinal/tópico histórico — confirmar papel atual

Via	VO ou tópica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar registro, formulação e alternativa com melhor evidência
Status	Mantido no inventário solicitado; sem cálculo por baixa padronização atual	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

275. Etomidato - Indução para intubação

Via	EV	Apresentação	2 mg/mL
Dose	0,2–0,3 mg/kg	Máximo	dose única
Intervalo	bolus	Preparo	Puro ou diluição mínima conforme protocolo
Monitorização	PA, mioclonias, ventilação	Cautelas	Evitar em sepse/choque séptico pediátrico quando houver alternativa
Status	Uso anestésico; pediatria depende da bula	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

276. Fenitoína - Estado de mal epilético — carga

Via	EV	Apresentação	50 mg/mL
Dose	20 mg/kg	Máximo	1,5 g
Intervalo	dose de carga	Preparo	Somente SF 0,9%; infundir em 20 min; filtro conforme protocolo
Monitorização	ECG e PA contínuos	Cautelas	Não diluir em glicose; máx. 1 mg/kg/min e 50 mg/min
Status	Diretriz pediátrica	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

277. Fenitoína - Manutenção após carga

Via	EV/VO	Apresentação	Solução injetável/oral de referência 50 mg/mL
Dose	5–8 mg/kg/dia divididos	Máximo	300–400 mg/dia usual adulto
Intervalo	a cada 8–12 h	Preparo	Volume diário calculado a 50 mg/mL. Dividir em 2–3 tomadas conforme intervalo e via; para EV, usar somente diluente/linha compatíveis e monitorização.
Monitorização	Nível sérico, albumina, ECG se EV	Cautelas	Interações múltiplas; ajustar hepático e níveis
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

278. Fenobarbital - Convulsão neonatal — carga

Via	EV	Apresentação	100 mg/mL
Dose	20 mg/kg; adicionais 10 mg/kg	Máximo	40 mg/kg total em muitos protocolos
Intervalo	conforme resposta	Preparo	Aplicar protocolo neonatal; infusão lenta
Monitorização	EEG se disponível, FR, PA	Cautelas	Intervalo e manutenção dependem de IG/idade pós-natal
Status	Uso neonatal estabelecido	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

279. Fenobarbital - Estado de mal epilético — segunda linha

Via	EV	Apresentação	200 mg/2 mL = 100 mg/mL
Dose	20 mg/kg	Máximo	1 g
Intervalo	dose de carga	Preparo	Diluir/infundir conforme bula; máx. 1 mg/kg/min
Monitorização	FR, SpO ₂ , PA, sedação	Cautelas	Ventilação disponível; somar sedação de benzodiazepínicos
Status	Diretriz pediátrica	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

280. Fenobarbital - Manutenção anticonvulsivante

Via	EV/VO	Apresentação	Ampola 100 mg/mL; diluição operacional 10 mg/mL
Dose	3–5 mg/kg/dia	Máximo	individualizar por nível
Intervalo	1–2 vezes/dia	Preparo	Diluição operacional 1:10: 1 mL (100 mg) + 9 mL de diluente compatível = 10 mg/mL. Preparar/usar segundo farmácia, bula e protocolo de estabilidade.
Monitorização	Nível sérico, sedação, função hepática	Cautelas	Ajustar por níveis e função hepática/renal
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

281. Fenoterol - Broncoespasmo agudo — alternativa beta-2 agonista conforme protocolo

Via	Inalatória ou EV conforme cenário	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Monitorar FC, K, glicemia e lactato em doses repetidas/infusão; preferir protocolo de asma
Status	Selecionar formulação, via e faixa etária antes do cálculo	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

282. Fentanila - Analgesia aguda EV

Via	EV	Apresentação	50 mcg/mL
Dose	0,5–2 mcg/kg/dose	Máximo	100 mcg/dose de referência; titular
Intervalo	a cada 30–60 min conforme resposta	Preparo	EV lento em 3–5 min
Monitorização	FR, SpO ₂ , PA, sedação	Cautelas	Bolus rápido/dose alta pode causar rigidez torácica
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

283. Fentanila - Analgesia intranasal sem acesso venoso (≥12 meses)

Via	Intranasal	Apresentação	Ideal 300 mcg/mL; ampola 50 mcg/mL limita volume
Dose	1,5 mcg/kg inicial; 0,75–1,5 mcg/kg de resgate	Máximo	100 mcg; usual 75 mcg se solução diluída
Intervalo	reavaliar em 5–10 min	Preparo	Atomizador; dividir entre narinas
Monitorização	FR, SpO ₂ , sedação e dor	Cautelas	Evitar <12 meses, alteração de consciência ou obstrução/epistaxe bilateral
Status	Off-label: via intranasal	Risco / off-label	Risco padrão; Off-label

284. Fentanila - Analgesia/sedação contínua pós-IOT

Via	EV em BIC	Apresentação	50 mcg/mL; concentração padronizada
Dose	0,5–4 mcg/kg/h; titular	Máximo	até 10 mcg/kg/h em protocolos especializados
Intervalo	contínuo	Preparo	Ex.: 500 mcg em 50 mL = 10 mcg/mL; mL/h = dose×peso/10
Monitorização	Sedação, dor, FR, PA; abstinência em uso prolongado	Cautelas	Dupla checagem de mcg e bomba
Status	Off-label pediátrico conforme produto	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

285. Fentanila - Sequência rápida de intubação/atenuação de resposta

Via	EV	Apresentação	50 mcg/mL
Dose	1–2 mcg/kg	Máximo	individualizar
Intervalo	dose única, lenta	Preparo	Administrar lentamente antes da laringoscopia se hemodinamicamente adequado
Monitorização	PA, FC, FR, rigidez torácica	Cautelas	Não é agente de indução isolado; risco de hipotensão/bradicardia
Status	Off-label por contexto	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

286. Fexofenadina - Rinite alérgica — tratamento sintomático conforme idade

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Status	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

287. Fexofenadina - Urticária — tratamento sintomático conforme idade

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Status	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

288. Fitomenadiona (Vitamina K) - Profilaxia da deficiência de vitamina K no recém-nascido

Via	IM, VO ou EV conforme indicação/protocolo	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Via EV exige administração lenta e monitorização; confirmar produto e concentração
Status	Dose depende de profilaxia versus sangramento e faixa de peso; não automatizada nesta linha	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

289. Fitomenadiona (Vitamina K) - Tratamento da deficiência de vitamina K no recém-nascido

Via	IM, VO ou EV conforme indicação/protocolo	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Via EV exige administração lenta e monitorização; confirmar produto e concentração
Status	Dose depende de profilaxia versus sangramento e faixa de peso; não automatizada nesta linha	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

290. Fluconazol - Candidíase invasiva — tratamento

Via	VO ou EV	Apresentação	Solução oral 10 mg/mL ou solução EV 2 mg/mL
Dose	6–12 mg/kg/dose conforme foco e gravidade	Máximo	máximo 800 mg/dia no arquivo-base; confirmar protocolo
Intervalo	24/24 h	Preparo	A saída calcula para solução oral 10 mg/mL; para EV 2 mg/mL multiplicar o volume por 5
Monitorização	Função hepática, QT/interações, culturas e resposta	Cautelas	Ajustar na disfunção renal; confirmar espécie/sensibilidade
Status	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

291. Flumazenil - Reversão selecionada de sedação por benzodiazepínico

Via	EV	Apresentação	0,1 mg/mL
Dose	0,01 mg/kg	Máximo	máximo inicial 0,2 mg; redosagem e máximo cumulativo conforme protocolo
Intervalo	reavaliar após 1 min; efeito pode ser mais curto que o benzodiazepínico	Preparo	Administrar lentamente; manter suporte ventilatório
Monitorização	Ventilação, consciência, ECG e recorrência de sedação	Cautelas	Evitar em uso crônico de benzodiazepínico, epilepsia tratada ou intoxicação mista pró-convulsivante
Status	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

292. Fluticasona - Asma persistente — controle de manutenção conforme fenótipo e idade

Via	Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão
Status	Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

293. Fluticasona - Rinite alérgica — controle de manutenção conforme fenótipo e idade

Via	Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão
Status	Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

294. Formoterol - Asma persistente — controle de manutenção conforme fenótipo e idade

Via	Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão
Status	Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

295. Formoterol - Rinite alérgica — controle de manutenção conforme fenótipo e idade

Via	Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão
Status	Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

296. Furazolidona - Uso anti-infeccioso histórico — avaliar alternativa contemporânea

Via	Conforme produto histórico	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Não utilizar com base apenas em manual antigo; confirmar registro, disponibilidade e protocolo especializado
Status	Mantido no inventário solicitado; sem cálculo por obsolescência ou ausência de papel atual rotineiro	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

297. Furosemda - Infusão contínua em refratariedade

Via	EV em BIC	Apresentação	Padrão de infusão 2 mg/mL
Dose	0,05–0,4 mg/kg/h; iniciar 0,05 mg/kg/h e titular	Máximo	confirmar protocolo de UTI
Intervalo	contínuo	Preparo	Padrão 2 mg/mL: 10 mL de furosemda 10 mg/mL e completar para 50 mL com diluente compatível. Proteger compatibilidades e usar bomba.
Monitorização	Diurese horária, eletrólitos, PA	Cautelas	Avaliar resistência diurética e perfusão renal
Status	Off-label pediátrico	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

298. Furosemda - Sobrecarga volêmica/edema

Via	EV	Apresentação	10 mg/mL
Dose	1 mg/kg/dose; pode chegar a 2 mg/kg em refratariedade	Máximo	40 mg/dose inicial de referência; individualizar
Intervalo	a cada 12–24 h conforme resposta	Preparo	EV em ≥5 min; pode diluir
Monitorização	Diurese, PA, Na, K, Mg, creatinina	Cautelas	Corrigir hipovolemia; risco de ototoxicidade com administração rápida
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

299. Gentamicina - Bacteremia ou sepse por bactéria sensível — opção IM

Via	IM profunda	Apresentação	Ampola pediátrica brasileira 40 mg/mL (ou 80 mg/2 mL = 40 mg/mL)
Dose	2–2,5 mg/kg/dose	Máximo	individualizar por idade, função renal e níveis séricos
Intervalo	8/8 h	Preparo	Aspirar a dose da solução 40 mg/mL e administrar sem diluição por IM profunda.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular	Cautelas	Em septicemia, choque, queimadura grave, baixa massa muscular ou impossibilidade de IM, a bula recomenda via EV. Não misturar com outros fármacos.
Status	Bula profissional brasileira; dose IM e EV idêntica no esquema convencional	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

300. Gentamicina - Infecção de pele, osso ou tecidos moles por bactéria sensível — opção IM

Via	IM profunda	Apresentação	Ampola pediátrica brasileira 40 mg/mL (ou 80 mg/2 mL = 40 mg/mL)
Dose	2–2,5 mg/kg/dose	Máximo	individualizar por idade, função renal e níveis séricos
Intervalo	8/8 h	Preparo	Aspirar a dose da solução 40 mg/mL e administrar sem diluição por IM profunda.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular	Cautelas	Em septicemia, choque, queimadura grave, baixa massa muscular ou impossibilidade de IM, a bula recomenda via EV. Não misturar com outros fármacos.
Status	Bula profissional brasileira; dose IM e EV idêntica no esquema convencional	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

301. Gentamicina - Infecção do sistema nervoso central por bactéria sensível — em associação apropriada — opção IM

Via	IM profunda	Apresentação	Ampola pediátrica brasileira 40 mg/mL (ou 80 mg/2 mL = 40 mg/mL)
Dose	2–2,5 mg/kg/dose	Máximo	individualizar por idade, função renal e níveis séricos
Intervalo	8/8 h	Preparo	Aspirar a dose da solução 40 mg/mL e administrar sem diluição por IM profunda.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular	Cautelas	Em septicemia, choque, queimadura grave, baixa massa muscular ou impossibilidade de IM, a bula recomenda via EV. Não misturar com outros fármacos.
Status	Bula profissional brasileira; dose IM e EV idêntica no esquema convencional	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

302. Gentamicina - Infecção gastrointestinal por bactéria sensível — opção IM

Via	IM profunda	Apresentação	Ampola pediátrica brasileira 40 mg/mL (ou 80 mg/2 mL = 40 mg/mL)
Dose	2–2,5 mg/kg/dose	Máximo	individualizar por idade, função renal e níveis séricos
Intervalo	8/8 h	Preparo	Aspirar a dose da solução 40 mg/mL e administrar sem diluição por IM profunda.

Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular	Cautelas	Em septicemia, choque, queimadura grave, baixa massa muscular ou impossibilidade de IM, a bula recomenda via EV. Não misturar com outros fármacos.
Status	Bula profissional brasileira; dose IM e EV idêntica no esquema convencional	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

303. Gentamicina - Infecção grave por Gram-negativo — dose estendida

Via	EV	Apresentação	40 mg/mL
Dose	5–7,5 mg/kg/dose	Máximo	máximo e intervalo dependem de idade, função renal e protocolo de níveis
Intervalo	geralmente 24/24 h fora do período neonatal; individualizar	Preparo	Aspirar volume calculado e diluir conforme protocolo; infundir em 30–60 min
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis quando indicados, ototoxicidade	Cautelas	Ajustar intervalo na disfunção renal; neonatos exigem esquema específico
Status	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

304. Gentamicina - Infecção intra-abdominal ou peritonite por bactéria sensível — opção IM

Via	IM profunda	Apresentação	Ampola pediátrica brasileira 40 mg/mL (ou 80 mg/2 mL = 40 mg/mL)
Dose	2–2,5 mg/kg/dose	Máximo	individualizar por idade, função renal e níveis séricos
Intervalo	8/8 h	Preparo	Aspirar a dose da solução 40 mg/mL e administrar sem diluição por IM profunda.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular	Cautelas	Em septicemia, choque, queimadura grave, baixa massa muscular ou impossibilidade de IM, a bula recomenda via EV. Não misturar com outros fármacos.
Status	Bula profissional brasileira; dose IM e EV idêntica no esquema convencional	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

305. Gentamicina - Infecção renal ou geniturinária por bactéria sensível — opção IM

Via	IM profunda	Apresentação	Ampola pediátrica brasileira 40 mg/mL (ou 80 mg/2 mL = 40 mg/mL)
Dose	2–2,5 mg/kg/dose	Máximo	individualizar por idade, função renal e níveis séricos
Intervalo	8/8 h	Preparo	Aspirar a dose da solução 40 mg/mL e administrar sem diluição por IM profunda.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular	Cautelas	Em septicemia, choque, queimadura grave, baixa massa muscular ou impossibilidade de IM, a bula recomenda via EV. Não misturar com outros fármacos.
Status	Bula profissional brasileira; dose IM e EV idêntica no esquema convencional	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

306. Gentamicina - Infecção respiratória por bactéria sensível — opção IM

Via	IM profunda	Apresentação	Ampola pediátrica brasileira 40 mg/mL (ou 80 mg/2 mL = 40 mg/mL)
Dose	2–2,5 mg/kg/dose	Máximo	individualizar por idade, função renal e níveis séricos
Intervalo	8/8 h	Preparo	Aspirar a dose da solução 40 mg/mL e administrar sem diluição por IM profunda.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular	Cautelas	Em septicemia, choque, queimadura grave, baixa massa muscular ou impossibilidade de IM, a bula recomenda via EV. Não misturar com outros fármacos.
Status	Bula profissional brasileira; dose IM e EV idêntica no esquema convencional	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

307. Gentamicina - Seps neonatal por bactéria sensível — opção IM no recém-nascido com até 1 semana

Via	IM profunda	Apresentação	Ampola pediátrica brasileira 20 mg/mL ou 40 mg/mL; cálculo exibido para 20 mg/mL
Dose	2,5–3 mg/kg/dose	Máximo	ajustar por idade gestacional, função renal e níveis séricos
Intervalo	12/12 h	Preparo	Aspirar a dose da solução 20 mg/mL e administrar sem diluição por IM profunda.
Monitorização	Creatinina, diurese, níveis séricos, audição e função vestibular	Cautelas	Em seps/choque, a via EV costuma ser preferida. Confirmar apresentação 20 mg/mL antes de usar o volume calculado.

Status	Bula profissional brasileira; esquema para prematuro/RN com até 1 semana	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label
---------------	--	--------------------------	---

308. Glucametacina - Dor/inflamação ou indicação especializada — uso condicionado à idade e ao diagnóstico

Via	VO, retal ou tópica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Evitar em desidratação, doença renal, sangramento GI e dengue; AAS não usar em virose salvo indicação específica
Status	Resposta condicionada às restrições etárias e à indicação específica	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

309. Gluconato de cálcio - Hipercalcemia com alteração no ECG

Via	EV	Apresentação	10% = 100 mg/mL
Dose	50–100 mg/kg	Máximo	10–20 mL conforme protocolo; repetir se ECG persistir
Intervalo	em 5–10 min se instável	Preparo	Pode usar 10% não diluído em situação ameaçadora à vida
Monitorização	ECG contínuo, acesso e extravasamento	Cautelas	Não reduz K; estabiliza membrana. Não misturar com bicarbonato/fosfato
Status	Diretriz pediátrica	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

310. Gluconato de cálcio - Hipocalcemia sintomática

Via	EV	Apresentação	10% = 100 mg/mL
Dose	50–200 mg/kg	Máximo	conforme protocolo e cálcio iônico
Intervalo	em 10–20 min	Preparo	Diluir para 50 mg/mL quando estável
Monitorização	ECG, Ca iônico, sítio	Cautelas	Extravasamento causa necrose; acesso central preferível em alta concentração
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

311. Gluconato de cálcio - Intoxicação por bloqueador de canal de cálcio/hipermagnesemia

Via	EV	Apresentação	10%
Dose	0,6–1 mL/kg	Máximo	repetição depende de ECG/hemodinâmica e toxicologia
Intervalo	conforme resposta	Preparo	Consultar CIATox; bomba se infusão
Monitorização	ECG, Ca iônico, PA	Cautelas	Necessita protocolo toxicológico específico
Status	Off-label por indicação toxicológica	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

312. Gramicidina - Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto

Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Status	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

313. Gramicidina - Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto

Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Status	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

314. Granisetrona - Náuseas/vômitos — uso selecionado após tratar a causa e avaliar risco de QT

Via	VO ou EV conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar QT, distonia/efeitos extrapiramidais, interações e distúrbios eletrolíticos
Status	Não usar rotineiramente; dose/idade dependem do produto e da indicação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

315. Griseofulvina - Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente

Via	Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância
Status	Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

316. Haloperidol - Agitação psicomotora grave

Via	IM/VO	Apresentação	5 mg/mL
Dose	0,05–0,1 mg/kg/dose	Máximo	5 mg/dose
Intervalo	reavaliar; não repetir antes do intervalo do protocolo	Preparo	Desescalada é primeira linha; IM profunda; evitar EV
Monitorização	ECG/QT, PA, distonia, sedação	Cautelas	Evitar em QT longo e toxíndromes anticolinérgica/simpaticomimética; considerar agente preferido do protocolo local
Status	Off-label pediátrico	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

317. Haloperidol - Delirium hiperativo em UTI

Via	EV/IM/VO conforme protocolo	Apresentação	5 mg/mL; preferir diluição para dose pequena
Dose	0,01–0,05 mg/kg/dose	Máximo	2 mg inicialmente; limite institucional
Intervalo	a cada 6–8 h se necessário	Preparo	Usar concentração que permita medir; protocolo de delirium
Monitorização	ECG/QT, eletrólitos, sintomas extrapiramidais	Cautelas	Tratar causa do delirium; não usar rotineiramente sem avaliação especializada
Status	Off-label pediátrico; evidência limitada	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

318. Hidralazina - Emergência hipertensiva

Via	EV	Apresentação	20 mg/mL
Dose	0,1–0,2 mg/kg/dose	Máximo	0,6 mg/kg/dose
Intervalo	a cada 4–6 h conforme protocolo/resposta	Preparo	Administrar em 3–5 min ou infusão intermitente conforme protocolo
Monitorização	PA frequente, FC, sintomas neurológicos	Cautelas	Resposta imprevisível; evitar queda excessiva; preferir agente titulável quando possível
Status	Off-label pediátrico	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

319. Hidrato de cloral - Indicação neurológica/sedativa especializada

Via	VO ou via hospitalar conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar depressão do SNC, QT, efeitos extrapiramidais e necessidade de monitorização cardiorrespiratória
Status	Uso restrito/off-label conforme cenário; selecionar protocolo especializado	Risco / off-label	Risco padrão; Off-label

320. Hidroclorotiazida - Doença cardiovascular/renal específica — tratamento especializado

Via	VO ou EV conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Monitorar PA, ECG, eletrólitos e função renal conforme fármaco; digoxina exige atenção à unidade mcg
Status	Dose depende de idade, função renal, alvo e co-medicações; não automatizada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

321. Hidrocortisona - Asma grave sem tolerância VO

Via	EV	Apresentação	Frasco-ampola 100 mg; diluição de trabalho 10 mg/mL
Dose	4 mg/kg/dose	Máximo	100 mg/dose
Intervalo	a cada 6 h	Preparo	Reconstituir 100 mg conforme sistema/bula (solução 50 mg/mL). Para 10 mg/mL: 1 mL = 50 mg + 4 mL de SF 0,9%/SG 5%. Confirmar produto e estabilidade.
Monitorização	Glicemia, PA, resposta	Cautelas	Migrar para VO quando possível
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

322. Hidrocortisona - Choque refratário com suspeita de insuficiência adrenal

Via	EV	Apresentação	Frasco-ampola 100 mg; diluição de trabalho 10 mg/mL
Dose	1–2 mg/kg/dose inicial	Máximo	seguir protocolo de UTI
Intervalo	conforme protocolo	Preparo	Reconstituir 100 mg conforme sistema/bula (solução 50 mg/mL). Para 10 mg/mL: 1 mL = 50 mg + 4 mL de SF 0,9%/SG 5%. Confirmar produto e estabilidade.
Monitorização	PA, glicemia, eletrólitos	Cautelas	Usar se suspeita/documentação de insuficiência adrenal ou protocolo de choque refratário
Status	Uso selecionado em diretriz	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

323. Hidrocortisona - Crise adrenal

Via	EV/IM	Apresentação	Frasco-ampola 100 mg; diluição de trabalho 10 mg/mL
Dose	2 mg/kg IV/IM (máx. 100 mg) OU dose por faixa etária do protocolo	Máximo	100 mg inicial
Intervalo	seguido de reposição dividida/contínua	Preparo	Reconstituir 100 mg conforme sistema/bula (solução 50 mg/mL). Para 10 mg/mL: 1 mL = 50 mg + 4 mL de SF 0,9%/SG 5%. Confirmar produto e estabilidade.
Monitorização	PA, glicemia, Na, K	Cautelas	Superfície corporal exige altura; não estimar sem altura
Status	Diretriz pediátrica	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

324. Hidroxicloroquina - Doença reumatológica pediátrica — tratamento modificador

Via	VO	Apresentação	Comprimidos; manipulação pode ser necessária conforme peso
Dose	Não automatizada sem protocolo reumatológico e apresentação definida	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Monitorar retina, QT/interações e função renal/hepática conforme risco
Status	Uso especializado; dose e máximo dependem do peso real e diagnóstico	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

325. Hidroxicloroquina - Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via	VO ou tópica conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Status	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

326. Hidróxido de alumínio + magnésio - Dispepsia/refluxo — uso eventual

Via	VO	Apresentação	Suspensão oral — concentração varia por marca
Dose	NÃO padronizar em mL/kg sem produto e idade	Máximo	≥12 anos: seguir bula do produto; <12 anos: avaliação médica
Intervalo	uso curto	Preparo	Não há uma concentração universal segura para conversão automática. Registrar a concentração do produto antes de prescrever.
Monitorização	Sintomas, Mg/Al se uso repetido	Cautelas	Evitar em insuficiência renal; não usar 1–2 mL/kg como regra geral
Status	Dados pediátricos e formulações variáveis	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

327. Hidroxiquinolina - Uso anti-infeccioso intestinal/tópico histórico — confirmar papel atual

Via	VO ou tópica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar registro, formulação e alternativa com melhor evidência
Status	Mantido no inventário solicitado; sem cálculo por baixa padronização atual	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

328. Hidroxizina - Rinite alérgica — tratamento sintomático conforme idade

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Status	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

329. Hidroxizina - Urticária — tratamento sintomático conforme idade

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Status	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

330. Hioscina - Dor abdominal espasmódica — uso sintomático selecionado após excluir causa cirúrgica

Via	VO, IM ou EV conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Efeitos anticolinérgicos; evitar em glaucoma, retenção urinária, íleo e suspeita de obstrução
Status	Dose e idade mínima variam por sal/apresentação; não intercambiar sais	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

331. Ibuprofeno - Dor aguda — criança hidratada

Via	VO	Apresentação	Gotas 100 mg/mL
Dose	5–10 mg/kg/dose	Máximo	máximo 40 mg/kg/dia; máximo absoluto conforme idade/bula
Intervalo	6/6–8/8 h se necessário	Preparo	Confirmar que o frasco é 100 mg/mL; medir em mL com seringa
Monitorização	Dor/febre, hidratação, tolerância GI, diurese	Cautelas	Evitar em desidratação, disfunção renal, sangramento GI, suspeita de dengue e alergia a AINE
Status	Uso pediátrico; respeitar idade/peso mínimos da bula	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

332. Ibuprofeno - Febre com desconforto — criança hidratada

Via	VO	Apresentação	Gotas 100 mg/mL
Dose	5–10 mg/kg/dose	Máximo	máximo 40 mg/kg/dia; máximo absoluto conforme idade/bula
Intervalo	6/6–8/8 h se necessário	Preparo	Confirmar que o frasco é 100 mg/mL; medir em mL com seringa
Monitorização	Dor/febre, hidratação, tolerância GI, diurese	Cautelas	Evitar em desidratação, disfunção renal, sangramento GI, suspeita de dengue e alergia a AINE
Status	Uso pediátrico; respeitar idade/peso mínimos da bula	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

333. Idoxuridina - Uso anti-infeccioso histórico — avaliar alternativa contemporânea

Via	Conforme produto histórico	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Não utilizar com base apenas em manual antigo; confirmar registro, disponibilidade e protocolo especializado
Status	Mantido no inventário solicitado; sem cálculo por obsolescência ou ausência de papel atual rotineiro	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

334. Imipenem / cilastatina sódica - Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Status	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

335. Indometacina - Persistência do canal arterial em prematuros — fechamento farmacológico

Via	EV	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Avaliar função renal, plaquetas, perfusão intestinal/cerebral e contraindicações
Status	Dose depende de idade pós-natal e protocolo neonatal específico	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

336. Ipratrópio brometo - Crise asmática moderada/grave — primeiras doses

Via	Nebulização	Apresentação	0,25 mg/mL
Dose	<20 kg: 0,25 mg; ≥20 kg: 0,5 mg	Máximo	0,5 mg/dose
Intervalo	a cada 20 min por 3 doses; protocolos graves até 2 h	Preparo	Associar a salbutamol; completar volume conforme nebulizador
Monitorização	FC, esforço, SpO ₂	Cautelas	Sem benefício como monoterapia de manutenção
Status	Diretriz pediátrica	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

337. Isoniazida - Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Status	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

338. Ivermectina - Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via	VO ou tópica conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Status	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

339. Ketodex (cetamina + dexmedetomidina) - Sedoanalgesia procedural dolorosa — estratégia 1:1 protocolar

Via	EV lenta em bomba	Apresentação	Cetamina 50 mg/mL + dexmedetomidina 100 mcg/mL
Dose	cetamina 1 mg/kg + dexmedetomidina 1 mcg/kg em 10 min	Máximo	sem máximo universal; NÃO repetir automaticamente a combinação
Intervalo	dose inicial; reavaliar em 10–15 min	Preparo	Se premix institucional for validado: cetamina 100 mg (2 mL) + dexmedetomidina 100 mcg (1 mL) + SF 0,9% 17 mL = 20 mL; finais 5 mg/mL + 5 mcg/mL. Administrar 0,2 mL/kg em 10 min. Caso contrário, preparar separadamente
Monitorização	Sedação formal: ECG, PA a cada 5 min, SpO ₂ e capnografia contínuas; O ₂ , aspiração e material de via aérea disponíveis	Cautelas	Não existe formulação comercial/premix universal. Bradicardia/hipotensão, secreções, vômitos e laringoespasma; não presumir ausência de depressão respiratória
Status	Off-label; estratégia sem padronização universal	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

340. Labetalol - Emergência hipertensiva — bolus

Via	EV	Apresentação	5 mg/mL
Dose	0,2–1 mg/kg/dose	Máximo	40 mg/dose
Intervalo	a cada 10 min conforme resposta	Preparo	EV lento
Monitorização	PA contínua/frequente, FC, perfusão	Cautelas	Evitar em asma, bradicardia, BAV e IC descompensada
Status	Off-label pediátrico	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

341. Labetalol - Emergência hipertensiva — infusão

Via	EV em BIC	Apresentação	Solução 5 mg/mL; concentração usual de infusão 5 mg/mL
Dose	0,25–1 mg/kg/h; titular	Máximo	3 mg/kg/h
Intervalo	contínuo	Preparo	Usar 5 mg/mL sem diluição adicional quando compatível com protocolo/equipamento; bomba e monitorização contínua.
Monitorização	PA e ECG contínuos	Cautelas	Mesmas contraindicações do bolus
Status	Off-label pediátrico	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

342. Lactulose - Constipação funcional — desimpactação

Via	VO ou retal conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Excluir obstrução/sinais de alarme; óleo mineral tem risco de aspiração e restrições etárias
Status	Dose depende de idade, objetivo e resposta; não automatizada sem apresentação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

343. Lactulose - Constipação funcional — manutenção

Via	VO ou retal conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Excluir obstrução/sinais de alarme; óleo mineral tem risco de aspiração e restrições etárias
Status	Dose depende de idade, objetivo e resposta; não automatizada sem apresentação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

344. Lamotrigina - Epilepsia — manutenção conforme tipo de crise e avaliação neuropediátrica

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Não iniciar/suspender abruptamente; revisar interações, teratogenicidade em adolescentes e monitorização específica
Status	Titulação gradual e dose dependem de idade, co-medicações e síndrome; não automatizada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

345. Lanatosídeo C - Doença cardiovascular/renal específica — tratamento especializado

Via	VO ou EV conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Monitorar PA, ECG, eletrólitos e função renal conforme fármaco; digoxina exige atenção à unidade mcg
Status	Dose depende de idade, função renal, alvo e co-medicações; não automatizada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

346. Levocabastina - Conjuntivite alérgica — formulação ocular conforme produto

Via	Nasal ou oftálmica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Status	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

347. Levocabastina - Rinite alérgica — formulação nasal conforme produto

Via	Nasal ou oftálmica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Status	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

348. Levodropropizina - Tosse seca intensa — uso excepcional após excluir causa tratável

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Não usar em lactentes; revisar sedação, interação serotoninérgica e contraindicações específicas
Status	Antitussígeno não rotineiro; resposta depende das restrições etárias e do benefício esperado	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

349. Levofloxacin - Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Status	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

350. Levotiroxina sódica - Terapia endócrina de reposição — acompanhamento especializado

Via	VO ou SC conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Não calcular superfície corporal sem altura; monitorar crescimento e exames específicos
Status	Dose individualizada por idade, diagnóstico, alvo laboratorial e, às vezes, superfície corporal	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

351. Lidocaína - FV/TV sem pulso refratária — alternativa antiarrítmica

Via	EV/IO	Apresentação	20 mg/mL (2%) sem vasoconstritor
Dose	1 mg/kg	Máximo	máximo 100 mg no bolus inicial; manutenção conforme PALS/protocolo
Intervalo	bolus	Preparo	Confirmar concentração e ausência de vasoconstritor; administrar conforme algoritmo
Monitorização	ECG, pressão, perfusão e sinais de toxicidade neurológica	Cautelas	Alta vigilância; dose cumulativa e hepatopatia alteram risco de toxicidade
Status	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

352. Lincomicina - Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Status	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

353. Linezolida - Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Status	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

354. Lodoxamida - Conjuntivite alérgica — formulação ocular conforme produto

Via	Nasal ou oftálmica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Status	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

355. Lodoxamida - Rinite alérgica — formulação nasal conforme produto

Via	Nasal ou oftálmica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Status	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

356. Loratadina - Rinite alérgica — tratamento sintomático conforme idade

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Status	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

357. Loratadina - Urticária — tratamento sintomático conforme idade

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Status	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

358. Manitol - Hipertensão intracraniana/edema cerebral — terapia hiperosmolar selecionada

Via	EV	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Monitorar osmolaridade, Na, função renal, volemia e risco de hipotensão/rebote
Status	Dose e concentração dependem do cenário e de protocolo neurocrítico	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

359. Mebendazol - Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via	VO ou tópica conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Status	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

360. Meropenem - Infecção grave por Gram-negativo/ESBL sem meningite

Via	EV	Apresentação	Frasco-ampola 500 mg; solução de trabalho 50 mg/mL
Dose	20 mg/kg/dose	Máximo	máximo 1 g/dose nesta indicação; confirmar protocolo
Intervalo	8/8 h; infusão usual 15–30 min ou prolongada conforme protocolo	Preparo	Reconstituir e diluir conforme bula/farmácia; concentração exibida 50 mg/mL
Monitorização	Função renal, resposta clínica, culturas, neurotoxicidade	Cautelas	Ajustar função renal; reservar conforme epidemiologia/antibiograma
Status	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

361. Meropenem - Meningite bacteriana ou infecção do SNC por agente sensível

Via	EV	Apresentação	Frasco-ampola 500 mg; solução de trabalho 50 mg/mL
Dose	40 mg/kg/dose	Máximo	máximo 2 g/dose; confirmar faixa etária/protocolo
Intervalo	8/8 h	Preparo	Reconstituir e diluir conforme bula/farmácia; concentração exibida 50 mg/mL
Monitorização	Função renal, culturas, avaliação neurológica e resposta clínica	Cautelas	Ajustar função renal; risco de convulsões, sobretudo em predisposição
Status	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

362. Metoclopramida - Migrânea com náusea

Via	EV	Apresentação	5 mg/mL
Dose	0,1–0,15 mg/kg	Máximo	10 mg
Intervalo	dose única; reavaliar	Preparo	Diluir e infundir lentamente
Monitorização	Acatisia/distonia	Cautelas	Considerar tratamento de reação extrapiramidal; ≥1 ano
Status	Off-label pediátrico	Risco / off-label	Risco padrão; Off-label

363. Metoclopramida - Náusea/vômito — segunda linha em ≥1 ano

Via	EV/IM/VO	Apresentação	5 mg/mL
Dose	0,1–0,15 mg/kg/dose	Máximo	10 mg/dose; 0,5 mg/kg/dia
Intervalo	até 3 vezes/dia	Preparo	EV lento ≥3 min
Monitorização	Distonia/acatisia, sedação	Cautelas	Contraindicada <1 ano; uso curto; evitar em obstrução, Parkinsonismo e epilepsia descompensada
Status	Uso pediátrico restrito	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

364. Metronidazol - Infecção anaeróbia intra-abdominal grave

Via	EV	Apresentação	Bolsa 5 mg/mL
Dose	30 mg/kg/dia divididos 8/8 h = 10 mg/kg/dose	Máximo	máximo 4 g/dia no arquivo-base; confirmar foco
Intervalo	8/8 h	Preparo	Solução pronta 5 mg/mL; infundir conforme bula/protocolo
Monitorização	Resposta clínica, função hepática em curso prolongado, neurotoxicidade	Cautelas	Ajustar em hepatopatia grave; revisar interações
Status	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

365. Metronidazol - Infecção odontogênica com componente anaeróbio — adjuvante quando indicado

Via	EV	Apresentação	Bolsa 5 mg/mL
Dose	30 mg/kg/dia divididos 8/8 h = 10 mg/kg/dose	Máximo	máximo 4 g/dia no arquivo-base; confirmar foco
Intervalo	8/8 h	Preparo	Solução pronta 5 mg/mL; infundir conforme bula/protocolo
Monitorização	Resposta clínica, função hepática em curso prolongado, neurotoxicidade	Cautelas	Ajustar em hepatopatia grave; revisar interações
Status	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

366. Midazolam - Estado de mal com acesso EV/IO

Via	EV/IO	Apresentação	5 mg/mL
Dose	0,15 mg/kg	Máximo	10 mg/dose
Intervalo	pode repetir uma vez; máximo 2 doses de benzodiazepínico	Preparo	EV lento; ventilação disponível
Monitorização	FR, SpO ₂ , PA, nível de consciência	Cautelas	Somar doses pré-hospitalares
Status	Diretriz pediátrica	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

367. Midazolam - Estado de mal sem acesso — bucal/intranasal

Via	Bucal/IN	Apresentação	5 mg/mL
Dose	bucal 0,3 mg/kg; IN 0,2–0,3 mg/kg	Máximo	10 mg
Intervalo	dose de resgate; respeitar máximo de benzodiazepínicos	Preparo	Atomizador na IN; dividir narinas
Monitorização	FR, SpO ₂ , PA	Cautelas	Volume nasal pode limitar; preferir formulação concentrada
Status	Off-label: via com solução injetável; diretriz aceita	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

368. Midazolam - Estado de mal sem acesso — IM

Via	IM	Apresentação	5 mg/mL
Dose	0,2 mg/kg	Máximo	10 mg
Intervalo	dose de resgate	Preparo	IM profunda
Monitorização	FR, SpO ₂ , PA	Cautelas	Não atrasar segunda linha após 2 benzodiazepínicos
Status	Diretriz pediátrica	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

369. Midazolam - Sedação contínua pós-IOT

Via	EV em BIC	Apresentação	5 mg/mL; diluição padronizada
Dose	0,025–0,12 mg/kg/h; faixa ampliada até 0,5 mg/kg/h em UTI	Máximo	titular por escala de sedação
Intervalo	contínuo	Preparo	Ex.: 50 mg em 50 mL = 1 mg/mL; mL/h = dose×peso
Monitorização	Sedação, PA, FR; delirium/abstinência	Cautelas	Acúmulo em insuficiência hepática/renal; dupla checagem
Status	Off-label pediátrico conforme duração/contexto	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

370. Midazolam - Sedação de procedimento

Via	EV	Apresentação	5 mg/mL; preferir diluição 1 mg/mL
Dose	0,025–0,1 mg/kg inicial conforme idade; titular	Máximo	6 mg (6m–5a) ou 10 mg (6–12a) em referência CHEO
Intervalo	incrementos após ≥2–3 min	Preparo	Diluir para 1 mg/mL para titulação
Monitorização	FR, SpO ₂ , PA; capnografia se sedação moderada/profunda	Cautelas	Não fornece analgesia; combinar aumenta depressão respiratória
Status	Uso pediátrico em bula; faixa etária específica	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

371. Mometasona - Asma persistente — controle de manutenção conforme fenótipo e idade

Via	Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão
Status	Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

372. Mometasona - Rinite alérgica — controle de manutenção conforme fenótipo e idade

Via	Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão
Status	Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

373. Monossulfiram - Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via	VO ou tópica conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Status	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

374. Montelukaste sódico - Asma persistente — controle de manutenção conforme fenótipo e idade

Via	Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão
Status	Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

375. Montelukaste sódico - Rinite alérgica — controle de manutenção conforme fenótipo e idade

Via	Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão
Status	Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

376. Morfina - Analgesia contínua pós-operatória/CTI

Via	EV em BIC	Apresentação	10 mg/mL; concentração padronizada
Dose	0,01–0,04 mg/kg/h	Máximo	titular por dor/sedação
Intervalo	contínuo	Preparo	Ex.: 50 mg em 50 mL = 1 mg/mL
Monitorização	FR, PA, sedação, íleo, abstinência	Cautelas	Não usar como terapia rotineira do edema agudo de pulmão pediátrico
Status	Off-label pediátrico conforme contexto	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

377. Morfina - Dor intensa — bolus

Via	EV/IM/SC	Apresentação	10 mg/mL; diluir para 1 mg/mL
Dose	0,05–0,1 mg/kg/dose	Máximo	5 mg/dose inicial de referência
Intervalo	a cada 2–4 h; titular	Preparo	1 mL (10 mg) + 9 mL SF = 1 mg/mL
Monitorização	FR, SpO ₂ , PA, sedação, dor	Cautelas	Reduzir em hipovolemia; ajustar em disfunção renal
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

378. Moxifloxacina - Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Status	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

379. Mupirocina - Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto

Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Status	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

380. Mupirocina - Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto

Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Status	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

381. N-acetil aspartilglutamato de sódio - Conjuntivite alérgica — formulação ocular conforme produto

Via	Nasal ou oftálmica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Status	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

382. N-acetil aspartilglutamato de sódio - Rinite alérgica — formulação nasal conforme produto

Via	Nasal ou oftálmica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Status	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

383. Naloxona - Depressão respiratória iatrogênica por opioide — reversão titulada

Via	EV/IM	Apresentação	0,4 mg/mL
Dose	1–5 mcg/kg; escalar para 10 mcg/kg	Máximo	100–400 mcg conforme resposta
Intervalo	a cada 2–3 min	Preparo	Diluir 0,4 mg para 10 mL = 0,04 mg/mL para titulação
Monitorização	Ventilação, consciência, dor, abstinência	Cautelas	Objetivo é ventilação, não despertar completo em usuário crônico
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

384. Naloxona - Overdose aguda com apneia/coma

Via	EV/IM/IN conforme produto/protocolo	Apresentação	0,4 mg/mL
Dose	0,1 mg/kg	Máximo	2 mg/dose
Intervalo	repetir a cada 2–3 min	Preparo	Priorizar ventilação; solução pode ser usada pura
Monitorização	FR, SpO ₂ , consciência	Cautelas	Observar recorrência; meia-vida menor que muitos opioides
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

385. Naloxona - Recorrência de toxicidade — infusão

Via	EV em BIC	Apresentação	Infusão de referência 100 mcg/mL
Dose	usual 24–40 mcg/kg/h; alternativamente ≈2/3 do bolus efetivo de despertar por hora	Máximo	titular à ventilação
Intervalo	contínuo	Preparo	100 mcg/mL: 2 mg (5 mL de 0,4 mg/mL) + 15 mL de diluente = 20 mL. Titular à ventilação e ao menor grau de reversão necessário.
Monitorização	FR, consciência, abstinência	Cautelas	Consultar toxicologia; bolus de resgate pode ser necessário
Status	Off-label: infusão contínua	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

386. Naproxeno - Artrite em crianças ≥2 anos — uso selecionado

Via	VO	Apresentação	Suspensão 25 mg/mL
Dose	5–7 mg/kg/dose	Máximo	máximo 500 mg/dose no arquivo-base; confirmar indicação
Intervalo	12/12 h	Preparo	Confirmar apresentação 25 mg/mL; agitar e medir com seringa
Monitorização	Dor/inflamação, tolerância GI, função renal e hidratação	Cautelas	Evitar em desidratação, doença renal, sangramento GI, dengue e alergia a AINE
Status	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

387. Naproxeno - Dor inflamatória em crianças ≥2 anos — uso selecionado

Via	VO	Apresentação	Suspensão 25 mg/mL
Dose	5–7 mg/kg/dose	Máximo	máximo 500 mg/dose no arquivo-base; confirmar indicação
Intervalo	12/12 h	Preparo	Confirmar apresentação 25 mg/mL; agitar e medir com seringa
Monitorização	Dor/inflamação, tolerância GI, função renal e hidratação	Cautelas	Evitar em desidratação, doença renal, sangramento GI, dengue e alergia a AINE
Status	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

388. Nedocromil sódico - Conjuntivite alérgica — formulação ocular conforme produto

Via	Nasal ou oftálmica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Status	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

389. Nedocromil sódico - Rinite alérgica — formulação nasal conforme produto

Via	Nasal ou oftálmica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Status	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

390. Neomicina - Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto

Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Status	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

391. Neomicina - Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto

Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Status	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

392. Nifedipina - Doença cardiovascular/renal específica — tratamento especializado

Via	VO ou EV conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Monitorar PA, ECG, eletrólitos e função renal conforme fármaco; digoxina exige atenção à unidade mcg
Status	Dose depende de idade, função renal, alvo e co-medicações; não automatizada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

393. Nimesulida - Dor/inflamação ou indicação especializada — uso condicionado à idade e ao diagnóstico

Via	VO, retal ou tópica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Evitar em desidratação, doença renal, sangramento GI e dengue; AAS não usar em virose salvo indicação específica
Status	Resposta condicionada às restrições etárias e à indicação específica	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

394. Nimorazol - Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via	VO ou tópica conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Status	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

395. Nistatina - Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente

Via	Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância
Status	Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

396. Nitrofurantoína - Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Status	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

397. Nitroglicerina - Edema pulmonar cardiogênico/insuficiência cardíaca com hipertensão

Via	EV em BIC	Apresentação	Padrão de infusão 200 mcg/mL
Dose	0,25–0,5 mcg/kg/min inicial; titular até 5 mcg/kg/min	Máximo	20 mcg/kg/min
Intervalo	contínuo	Preparo	Preparar em concentração final de 200 mcg/mL conforme produto/protocolo; usar frasco/equipos compatíveis e bomba.
Monitorização	PA contínua, perfusão, metemoglobina em altas doses	Cautelas	Contraindicada com inibidor PDE5 recente e hipotensão
Status	Off-label pediátrico	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

398. Nitroglicerina - Isquemia miocárdica no adolescente com hipertensão

Via	EV em BIC	Apresentação	Padrão de infusão 200 mcg/mL
Dose	0,25–0,5 mcg/kg/min; titular	Máximo	20 mcg/kg/min; protocolo cardiologia
Intervalo	contínuo	Preparo	Preparar em concentração final de 200 mcg/mL conforme produto/protocolo; usar frasco/equipos compatível e bomba.
Monitorização	PA, ECG, dor	Cautelas	Excluir uso de PDE5 e infarto de VD
Status	Off-label pediátrico	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

399. Nitroprussiato de sódio - Emergência hipertensiva

Via	EV em BIC	Apresentação	Padrão de infusão 200 mcg/mL
Dose	0,3–0,5 mcg/kg/min inicial; titular 0,5–8 mcg/kg/min	Máximo	10 mcg/kg/min apenas por curto período em protocolos
Intervalo	contínuo	Preparo	200 mcg/mL: 10 mg (0,4 mL de 25 mg/mL) + 49,6 mL de SG 5% = 50 mL. Proteger da luz; linha dedicada.
Monitorização	PA invasiva se possível, lactato/acidose; tiocianato em uso prolongado	Cautelas	Risco de cianeto/tiocianato, maior em IR/IH e altas doses
Status	Uso pediátrico especializado	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

400. Nitroprussiato de sódio - Insuficiência cardíaca com pós-carga elevada

Via	EV em BIC	Apresentação	Padrão de infusão 200 mcg/mL
Dose	0,3–5 mcg/kg/min	Máximo	titular à hemodinâmica
Intervalo	contínuo	Preparo	200 mcg/mL: 10 mg + diluente SG 5% até 50 mL. Proteger da luz; linha dedicada e monitorização invasiva quando indicada.
Monitorização	PA, perfusão, lactato	Cautelas	UTI/cardiologia; monitorar toxicidade
Status	Off-label por contexto	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

401. Noradrenalina (norepinefrina) - Anafilaxia refratária com vasoplegia apesar de adrenalina

Via	EV em BIC	Apresentação	Padrão de infusão 16 mcg/mL
Dose	0,05 mcg/kg/min; titular	Máximo	protocolo de UTI
Intervalo	contínuo	Preparo	16 mcg/mL: 4 mg em volume final de 250 mL. Bomba; central preferível, acesso periférico apenas com vigilância do sítio.
Monitorização	PA contínua, ECG, perfusão	Cautelas	Especialista/UTI; tratar causas reversíveis
Status	Off-label; resgate especializado	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

402. Noradrenalina (norepinefrina) - Choque vasoplégico/distributivo

Via	EV/IO em BIC	Apresentação	Padrão de infusão 16 mcg/mL
Dose	iniciar 0,05 mcg/kg/min; faixa 0,01–0,4 mcg/kg/min	Máximo	1 mcg/kg/min de referência; maior só protocolo especializado
Intervalo	contínuo	Preparo	16 mcg/mL: 4 mg em volume final de 250 mL. Bomba/biblioteca; dupla checagem de mcg versus mg.
Monitorização	PA, perfusão, lactato, diurese, sítio	Cautelas	Dupla checagem de mcg/min e extravasamento
Status	Diretriz pediátrica	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

403. Óleo mineral - Constipação funcional — desimpactação

Via	VO ou retal conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Excluir obstrução/sinais de alarme; óleo mineral tem risco de aspiração e restrições etárias
Status	Dose depende de idade, objetivo e resposta; não automatizada sem apresentação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

404. Óleo mineral - Constipação funcional — manutenção

Via	VO ou retal conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Excluir obstrução/sinais de alarme; óleo mineral tem risco de aspiração e restrições etárias
Status	Dose depende de idade, objetivo e resposta; não automatizada sem apresentação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

405. Olopatadina - Conjuntivite alérgica — formulação ocular conforme produto

Via	Nasal ou oftálmica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Status	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

406. Olopatadina - Rinite alérgica — formulação nasal conforme produto

Via	Nasal ou oftálmica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar formulação nasal versus oftálmica; evitar contato da ponta do frasco e revisar idade mínima
Status	Posologia em jatos/gotas depende do produto e da idade; não converter em mL	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

407. Omeprazol - Úlcera péptica/erosiva sem hemorragia maciça

Via	EV	Apresentação	Frasco-ampola 40 mg; 4 mg/mL reconstituído; 0,4 mg/mL final
Dose	0,5 mg/kg/dose	Máximo	2 mg/kg/dia; limite institucional
Intervalo	a cada 12–24 h	Preparo	Reconstituir 40 mg com 10 mL de SF 0,9% = 4 mg/mL. Aspirar a dose e diluir para 0,4 mg/mL; infundir em 30 min.
Monitorização	Sintomas, Mg se prolongado	Cautelas	Migrar para VO assim que possível; experiência EV pediátrica limitada
Status	Off-label EV em pediatria conforme produto/local	Risco / off-label	Risco padrão; Off-label

408. Ondansetrona - Gastroenterite com vômitos — facilitar SRO

Via	VO	Apresentação	Solução 2 mg/mL; VO 4/8 mg
Dose	0,15 mg/kg, dose única; alternativa: 8–15 kg 2 mg, 15–30 kg 4 mg, >30 kg 8 mg	Máximo	8 mg
Intervalo	dose única	Preparo	Preferir comprimido/solução oral
Monitorização	Hidratação; QT se fatores de risco	Cautelas	Aplicável tipicamente 6 meses–12 anos; não prescrever rotineiramente múltiplas doses para casa
Status	Off-label para gastroenterite	Risco / off-label	Risco padrão; Off-label

409. Ondansetrona - Náusea por quimioterapia

Via	EV/VO	Apresentação	2 mg/mL
Dose	0,15–0,2 mg/kg/dose	Máximo	protocolo oncológico prevalece
Intervalo	primeira dose antes da quimioterapia; até 3 doses/24 h	Preparo	Infundir conforme bula
Monitorização	QT, função hepática	Cautelas	Seguir protocolo oncológico específico
Status	Uso pediátrico em bula/protocolo oncológico	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

410. Ondansetrona - Náusea/vômito pós-operatório

Via	EV	Apresentação	2 mg/mL
Dose	0,1 mg/kg	Máximo	4 mg
Intervalo	dose; repetir conforme protocolo	Preparo	EV lento
Monitorização	QT, eletrólitos em risco	Cautelas	Cautela em QT longo e hepatopatia grave
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

411. Oxacilina - Infecção grave por MSSA sem SNC

Via	EV	Apresentação	Frasco-ampola 1 g; padrão operacional 100 mg/mL
Dose	50 mg/kg/dose	Máximo	2 g/dose; 12 g/dia
Intervalo	a cada 6 h	Preparo	Reconstituir para 100 mg/mL; aspirar a dose e realizar diluição 1:5 para concentração final de 20 mg/mL, conforme protocolo/compatibilidade.
Monitorização	Culturas, função hepática/renal, neutropenia	Cautelas	Ajustar se disfunção hepática e renal concomitante
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

412. Oxacilina - Infecção leve a moderada de vias aéreas superiores por estafilococo sensível — opção IM, <40 kg

Via	IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 500 mg; adicionar 2,7 mL de água para injetáveis → cerca de 500 mg/3 mL = 166,7 mg/mL
Dose	12,5 mg/kg/dose = 50 mg/kg/dia	Máximo	máximo 500 mg (3 mL) por dose nesta linha
Intervalo	6/6 h	Preparo	Adicionar 2,7 mL de água para injetáveis, agitar até solução límpida e aplicar profundamente em grande massa muscular.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função hepática/renal e hemograma em curso prolongado	Cautelas	Não misturar com aminoglicosídeos. Infecção grave, disseminada, SNC, endocardite ou osteomielite exige avaliação para esquema EV.
Status	Apresentação brasileira IM/EV; linha IM restrita a infecção leve/moderada selecionada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

413. Oxacilina - Infecção leve a moderada de vias aéreas superiores por estafilococo sensível — opção IM, ≥40 kg

Via	IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 500 mg; adicionar 2,7 mL de água para injetáveis → cerca de 500 mg/3 mL = 166,7 mg/mL
Dose	250–500 mg/dose	Máximo	máximo 500 mg (3 mL) por dose nesta linha
Intervalo	4/4–6/6 h conforme gravidade	Preparo	Adicionar 2,7 mL de água para injetáveis, agitar até solução límpida e aspirar 1,5–3 mL.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função hepática/renal e hemograma em curso prolongado	Cautelas	Não misturar com aminoglicosídeos. Infecção grave, disseminada, SNC, endocardite ou osteomielite exige avaliação para esquema EV.
Status	Apresentação brasileira IM/EV; linha IM restrita a infecção leve/moderada selecionada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

414. Oxacilina - Infecção localizada de pele ou tecidos moles por estafilococo sensível — opção IM, <40 kg

Via	IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 500 mg; adicionar 2,7 mL de água para injetáveis → cerca de 500 mg/3 mL = 166,7 mg/mL
Dose	12,5 mg/kg/dose = 50 mg/kg/dia	Máximo	máximo 500 mg (3 mL) por dose nesta linha
Intervalo	6/6 h	Preparo	Adicionar 2,7 mL de água para injetáveis, agitar até solução límpida e aplicar profundamente em grande massa muscular.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função hepática/renal e hemograma em curso prolongado	Cautelas	Não misturar com aminoglicosídeos. Infecção grave, disseminada, SNC, endocardite ou osteomielite exige avaliação para esquema EV.
Status	Apresentação brasileira IM/EV; linha IM restrita a infecção leve/moderada selecionada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

415. Oxacilina - Infecção localizada de pele ou tecidos moles por estafilococo sensível — opção IM, ≥40 kg

Via	IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 500 mg; adicionar 2,7 mL de água para injetáveis → cerca de 500 mg/3 mL = 166,7 mg/mL
Dose	250–500 mg/dose	Máximo	máximo 500 mg (3 mL) por dose nesta linha
Intervalo	4/4–6/6 h conforme gravidade	Preparo	Adicionar 2,7 mL de água para injetáveis, agitar até solução límpida e aspirar 1,5–3 mL.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, função hepática/renal e hemograma em curso prolongado	Cautelas	Não misturar com aminoglicosídeos. Infecção grave, disseminada, SNC, endocardite ou osteomielite exige avaliação para esquema EV.
Status	Apresentação brasileira IM/EV; linha IM restrita a infecção leve/moderada selecionada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

416. Oxacilina - Meningite por MSSA

Via	EV	Apresentação	Frasco-ampola 1 g; padrão operacional 100 mg/mL
Dose	50 mg/kg/dose	Máximo	2 g/dose; 12 g/dia
Intervalo	a cada 4 h	Preparo	Reconstituir para 100 mg/mL; aspirar a dose e realizar diluição 1:5 para concentração final de 20 mg/mL, conforme protocolo/compatibilidade.
Monitorização	LCR/culturas, função hepática	Cautelas	Infectologia; ajustar conforme sensibilidade
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

417. Oxcarbazepina - Epilepsia — manutenção conforme tipo de crise e avaliação neuropediátrica

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Não iniciar/suspender abruptamente; revisar interações, teratogenicidade em adolescentes e monitorização específica
Status	Titulação gradual e dose dependem de idade, co-medicações e síndrome; não automatizada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

418. Oxiconazol - Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente

Via	Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância
Status	Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

419. Oxitetraciclina - Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto

Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Status	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

420. Oxitetraciclina - Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto

Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Status	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

421. Pantoprazol - Hemorragia digestiva alta — terapia acidossupressora inicial

Via	EV	Apresentação	Frasco-ampola 40 mg; 4 mg/mL reconstituído; 0,8 mg/mL final
Dose	1 mg/kg, dose inicial	Máximo	80 mg/dose
Intervalo	dose única inicial; sequência por gastro/protocolo	Preparo	Reconstituir 40 mg com 10 mL de SF 0,9% = 4 mg/mL. Para doses pediátricas/infusão, diluir a 0,8 mg/mL.
Monitorização	Hemodinâmica, Hb, endoscopia	Cautelas	Estabilização e controle da fonte são prioritários; acionar gastro/cirurgia
Status	Off-label pediátrico	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

422. Paracetamol (acetaminofeno) - Dor aguda

Via	VO	Apresentação	Solução 100 mg/mL
Dose	10–15 mg/kg/dose	Máximo	75 mg/kg/dia após termo; usar 60 mg/kg/dia como limite conservador institucional
Intervalo	a cada 4–6 h	Preparo	Sem diluição; seringa oral
Monitorização	Dose total de todas as associações	Cautelas	Reduzir em hepatopatia/desnutrição; não exceder máximo do produto
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

423. Paracetamol (acetaminofeno) - Febre com desconforto

Via	VO	Apresentação	Solução 100 mg/mL
Dose	10–15 mg/kg/dose	Máximo	75 mg/kg/dia após termo; usar 60 mg/kg/dia como limite conservador institucional
Intervalo	a cada 4–6 h	Preparo	Sem diluição; seringa oral
Monitorização	Dose total de todas as associações	Cautelas	Reduzir em hepatopatia/desnutrição; não exceder máximo do produto
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

424. Penicilamina - Doença inflamatória/metabólica específica — uso especializado

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Janela terapêutica/interações relevantes; monitorar hemograma, função renal/hepática conforme fármaco
Status	Dose e titulação dependem da doença e idade; não automatizada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

425. Penicilina (benzatina, G, V) - Infecção por agente sensível — selecionar sal/formulação conforme síndrome

Via	VO, IM ou EV conforme sal	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição

Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar alergia, sal, concentração e via; penicilina benzatina nunca EV
Status	Não intercambiar benzatina, procaína, cristalina ou penicilina V; linhas específicas originais foram preservadas	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

426. Penicilina G benzatina - Faringoamigdalite estreptocócica

Via	IM profunda	Apresentação	Benzilpenicilina benzatina 600.000 UI/4 mL ou 1.200.000 UI/4 mL
Dose	<27 kg: 600.000 UI; ≥27 kg: 1.200.000 UI	Máximo	1.200.000 UI
Intervalo	dose única	Preparo	IM profunda exclusivamente. Usar o frasco correspondente ao peso: <27 kg, 600.000 UI/4 mL; ≥27 kg, 1.200.000 UI/4 mL. A reconstituição varia por fabricante.
Monitorização	Anafilaxia, dor local	Cautelas	Não intercambiar com procaína ou cristalina
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

427. Penicilina G benzatina - Sífilis adquirida — esquema selecionado

Via	IM profunda	Apresentação	Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI/4 mL = 300.000 UI/mL
Dose	50.000 UI/kg/dose	Máximo	2.400.000 UI/dose
Intervalo	dose única ou semanal ×3 conforme estágio	Preparo	Usar apresentação final 1.200.000 UI/4 mL; IM profunda, nunca EV. Para 2.400.000 UI, dividir 8 mL em dois sítios conforme protocolo.
Monitorização	Sorologia e seguimento	Cautelas	Não usar combinações benzatina/procaína; excluir neurosífilis
Status	Uso pediátrico estabelecido; esquema depende do estágio	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

428. Penicilina G benzatina - Sífilis congênita — esquema selecionado

Via	IM profunda	Apresentação	Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI/4 mL = 300.000 UI/mL
Dose	50.000 UI/kg/dose	Máximo	2.400.000 UI/dose
Intervalo	dose única ou semanal ×3 conforme estágio	Preparo	Usar apresentação final 1.200.000 UI/4 mL; IM profunda, nunca EV. Para 2.400.000 UI, dividir 8 mL em dois sítios conforme protocolo.
Monitorização	Sorologia e seguimento	Cautelas	Não usar combinações benzatina/procaína; excluir neurosífilis
Status	Uso pediátrico estabelecido; esquema depende do estágio	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

429. Penicilina G cristalina - Endocardite por agente sensível

Via	EV	Apresentação	Frasco 5.000.000 UI; 1.000.000 UI/mL reconstituído
Dose	400.000 UI/kg/dia divididas a cada 4 h	Máximo	4 milhões UI/dose
Intervalo	a cada 4 h	Preparo	Reconstituir para 1.000.000 UI/mL conforme bula/protocolo; depois diluir 1:10 para solução de trabalho 100.000 UI/mL.
Monitorização	Culturas, LCR, eletrólitos, função renal	Cautelas	Ajustar em IR; infectologia
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

430. Penicilina G cristalina - Infecção grave sem meningite

Via	EV	Apresentação	Frasco 5.000.000 UI; 1.000.000 UI/mL reconstituído
Dose	200.000 UI/kg/dia divididas a cada 4 h	Máximo	4 milhões UI/dose
Intervalo	a cada 4 h	Preparo	Reconstituir 5.000.000 UI com 3,2 mL do diluente indicado para volume final aproximado de 5 mL = 1.000.000 UI/mL; depois diluir 1:10 para 100.000 UI/mL.
Monitorização	Culturas, função renal, Na/K conforme sal	Cautelas	Ajustar em insuficiência renal
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

431. Penicilina G cristalina - Meningite por agente sensível

Via	EV	Apresentação	Frasco 5.000.000 UI; 1.000.000 UI/mL reconstituído
Dose	400.000 UI/kg/dia divididas a cada 4 h	Máximo	4 milhões UI/dose
Intervalo	a cada 4 h	Preparo	Reconstituir para 1.000.000 UI/mL conforme bula/protocolo; depois diluir 1:10 para solução de trabalho 100.000 UI/mL.
Monitorização	Culturas, LCR, eletrólitos, função renal	Cautelas	Ajustar em IR; infectologia
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

432. Penicilina G cristalina - Sífilis congênita

Via	EV	Apresentação	Frasco 5.000.000 UI; 1.000.000 UI/mL reconstituído
Dose	50.000 UI/kg/dose	Máximo	—
Intervalo	RN: a cada 12 h nos 7 primeiros dias e 8 h depois; total 10 dias	Preparo	Reconstituir para 1.000.000 UI/mL conforme bula/protocolo; diluição de trabalho 1:10 = 100.000 UI/mL.
Monitorização	Clínica, LCR, sorologia	Cautelas	Intervalo neonatal é idade-dependente
Status	Diretriz pediátrica	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

433. Penicilina G procaína - Sífilis congênita — alternativa específica

Via	IM	Apresentação	Penicilina G procaína 600.000 UI/mL, suspensão IM
Dose	50.000 UI/kg/dose	Máximo	2.400.000 UI/dose
Intervalo	a cada 24 h por 10 dias	Preparo	Usar somente a apresentação específica 600.000 UI/mL, IM profunda; nunca EV. Não intercambiar com benzatina ou cristalina.
Monitorização	Sorologia, clínica	Cautelas	Não intercambiar com benzatina/cristalina; confirmar disponibilidade local
Status	Diretriz pediátrica	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

434. Permetrina - Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via	VO ou tópica conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Status	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

435. Petidina (Meperidina) - Dor moderada/intensa — opção opioide selecionada por protocolo e idade

Via	VO, EV, IM ou transmucosa conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Monitorar ventilação/sedação; codeína e tramadol têm restrições importantes em menores de 12 anos e após adenoamigdalectomia
Status	Uso restrito; resposta condicionada às contraindicações etárias e à variabilidade metabólica	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

436. Picossulfato sódico - Constipação funcional — desimpactação

Via	VO ou retal conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Excluir obstrução/sinais de alarme; óleo mineral tem risco de aspiração e restrições etárias

Status	Dose depende de idade, objetivo e resposta; não automatizada sem apresentação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label
---------------	---	--------------------------	--

437. Picossulfato sódico - Constipação funcional — manutenção

Via	VO ou retal conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Excluir obstrução/sinais de alarme; óleo mineral tem risco de aspiração e restrições etárias
Status	Dose depende de idade, objetivo e resposta; não automatizada sem apresentação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

438. Pimetixeno - Rinite alérgica — tratamento sintomático conforme idade

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Status	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

439. Pimetixeno - Urticária — tratamento sintomático conforme idade

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Preferir anti-histamínicos de 2ª geração quando apropriado; considerar sedação e QT/interações
Status	Dose geralmente etária e dependente da apresentação; não automatizada sem selecionar produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

440. Pipazetato - Tosse seca intensa — uso excepcional após excluir causa tratável

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Não usar em lactentes; revisar sedação, interação serotoninérgica e contraindicações específicas
Status	Antitussígeno não rotineiro; resposta depende das restrições etárias e do benefício esperado	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

441. Pirantel (Pamoato) - Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via	VO ou tópica conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Status	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

442. Pirimetamina - Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via	VO ou tópica conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Status	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

443. Pirvínio (Pamoato) - Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via	VO ou tópica conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Status	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

444. Polimixina B - Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto

Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Status	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

445. Polimixina B - Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto

Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Status	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

446. Prednisolona - Exacerbação de asma moderada/grave

Via	VO	Apresentação	Solução oral 3 mg/mL
Dose	1–2 mg/kg/dia	Máximo	máximo 40–50 mg/dia conforme diretriz/protocolo
Intervalo	1 vez/dia por curso curto conforme gravidade	Preparo	Medir com seringa oral; confirmar concentração 3 mg/mL
Monitorização	Resposta respiratória, glicemia/PA quando pertinente	Cautelas	Não usar rotineiramente em bronquiolite ou IVAS viral sem indicação
Status	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

447. Prednisona - Exacerbação de asma moderada/grave — alternativa à prednisolona

Via	VO	Apresentação	Comprimidos 5 ou 20 mg; cálculo exibido em mg, não mL
Dose	1–2 mg/kg/dia	Máximo	máximo 40–50 mg/dia conforme protocolo
Intervalo	1 vez/dia por curso curto	Preparo	Selecionar combinação de comprimidos compatível; não converter em mL sem suspensão definida
Monitorização	Resposta respiratória e eventos adversos	Cautelas	Linha calcula mg totais; confirmar formulação e capacidade de deglutição
Status	Uso pediátrico estabelecido; confirmar idade e protocolo da indicação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

448. Prometazina - Náusea/vômito — uso excepcional em ≥2 anos

Via	IM/VO	Apresentação	25 mg/mL
Dose	0,25–0,5 mg/kg/dose	Máximo	25 mg/dose
Intervalo	a cada 6–8 h	Preparo	Evitar EV pelo risco de lesão tecidual grave
Monitorização	Sedação e FR	Cautelas	Preferir antieméticos com melhor perfil; contraindicada <2 anos
Status	Uso pediátrico restrito	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

449. Prometazina - Reação alérgica/prurido — alternativa em ≥2 anos

Via	IM/VO	Apresentação	25 mg/mL
Dose	0,25 mg/kg/dose	Máximo	25 mg/dose
Intervalo	a cada 4–6 h se necessário	Preparo	Preferir VO; se injetável, seguir bula e protocolo de segurança
Monitorização	Sedação, FR, efeitos anticolinérgicos	Cautelas	Contraindicada <2 anos; risco de depressão respiratória; não substitui adrenalina na anafilaxia
Status	Uso pediátrico restrito	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

450. Propranolol - Sintomas adrenérgicos em tireotoxicose

Via	VO	Apresentação	Solução oral 20 mg/5 mL = 4 mg/mL
Dose	2 mg/kg/dia divididos	Máximo	individualizar com especialista
Intervalo	a cada 6–12 h	Preparo	Usar solução oral comercial 4 mg/mL; medir com seringa oral. Não substituir por Hemangeol sem recalcular a concentração.
Monitorização	FC, PA, glicemia	Cautelas	Evitar em asma/IC; tratar causa
Status	Off-label pediátrico	Risco / off-label	Risco padrão; Off-label

451. Propranolol - Taquiarritmia supraventricular — manutenção

Via	VO	Apresentação	Solução oral 20 mg/5 mL = 4 mg/mL
Dose	1–5 mg/kg/dia divididos	Máximo	5 mg/kg/dia
Intervalo	a cada 6–8 h	Preparo	Usar solução oral comercial 4 mg/mL; medir com seringa oral e titular com FC/PA/glicemia.
Monitorização	FC, PA, glicemia em lactentes	Cautelas	Evitar em asma, choque, BAV; não é tratamento inicial da TSV instável
Status	Off-label pediátrico conforme indicação	Risco / off-label	Risco padrão; Off-label

452. Ranitidina - Doença ácido-péptica — uso selecionado

Via	VO ou EV conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar interações e função renal; não usar ranitidina disponível de origem não autorizada
Status	Ranitidina permanece suspensa/retirada por risco de NDMA; não gerar dose	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

453. Ranitidina - Refluxo gastroesofágico — uso selecionado

Via	VO ou EV conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar interações e função renal; não usar ranitidina disponível de origem não autorizada
Status	Ranitidina permanece suspensa/retirada por risco de NDMA; não gerar dose	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

454. Rifampicina - Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Status	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

455. Roxitromicina - Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Status	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

456. Saccharomyces boulardii - Diarreia aguda — adjuvante cepa-específico, quando indicado

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Evitar em imunossupressão grave, paciente crítico ou com cateter venoso central pelo risco de fungemia
Status	Benefício depende de cepa/dose; não substitui reidratação oral	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

457. Salbutamol — inalador - Crise asmática leve/moderada

Via	Inalatória com espaçador	Apresentação	Inalador dosimetrado 100 mcg/jato
Dose	4–10 jatos por dose conforme gravidade/idade	Máximo	10 jatos por ciclo inicial em muitos protocolos
Intervalo	a cada 20 min na primeira hora; reavaliar	Preparo	Usar espaçador; a unidade operacional é jato, não mL.
Monitorização	FC, tremor, SpO ₂ , resposta	Cautelas	SABA não deve ser único tratamento crônico; associar corticoide conforme crise
Status	Diretriz pediátrica	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

458. Salbutamol — inalador - Resgate de broncoespasmo

Via	Inalatória	Apresentação	Inalador dosimetrado 100 mcg/jato
Dose	1–2 jatos	Máximo	avaliar controle se uso frequente
Intervalo	a cada 4 h se necessário por curto período	Preparo	Usar espaçador; a unidade operacional é jato, não mL.
Monitorização	Sintomas e uso de resgate	Cautelas	Uso repetido indica controle inadequado
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

459. Salbutamol — nebulização - Crise asmática moderada/grave

Via	Nebulização	Apresentação	5 mg/mL (0,5%)
Dose	0,15 mg/kg/dose; mínimo 2,5 mg	Máximo	5 mg/dose
Intervalo	a cada 20 min por 3 doses	Preparo	Completar com SF 0,9% até volume do nebulizador
Monitorização	FC, tremor, K, lactato em doses repetidas	Cautelas	Associar ipratrópio nas crises graves iniciais
Status	Diretriz pediátrica	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

460. Salbutamol — nebulização - Estado de mal asmático — nebulização contínua

Via	Nebulização contínua	Apresentação	5 mg/mL
Dose	0,3–0,5 mg/kg/h	Máximo	10–20 mg/h conforme peso/protocolo
Intervalo	contínuo, reavaliar frequentemente	Preparo	Preparar no sistema de nebulização contínua conforme protocolo
Monitorização	ECG, K, lactato, glicemia, resposta	Cautelas	UTI/sala vermelha; risco de taquiarritmia e hipocalcemia
Status	Off-label por regime contínuo	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

461. Salmeterol - Asma persistente — controle de manutenção conforme fenótipo e idade

Via	Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão
Status	Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

462. Salmeterol - Rinite alérgica — controle de manutenção conforme fenótipo e idade

Via	Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão
Status	Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

463. Secnidazol - Parasitose/ectoparasitose ou protozoose específica — selecionar pelo agente e faixa etária

Via	VO ou tópica conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar idade/peso mínimos, gestação em adolescentes, G6PD quando pertinente e resistências locais
Status	Não usar empiricamente em combinação; dose depende do agente, idade/peso e produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

464. Sertaconazol - Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente

Via	Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância
Status	Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

465. Simeticona - Distensão/gases — alívio sintomático quando indicado

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Benefício variável; não mascara sinais de abdome agudo
Status	Dose fixa por faixa etária e concentração do produto; não converter sem selecionar apresentação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

466. Sinvastatina - Doença cardiovascular/renal específica — tratamento especializado

Via	VO ou EV conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Monitorar PA, ECG, eletrólitos e função renal conforme fármaco; digoxina exige atenção à unidade mcg
Status	Dose depende de idade, função renal, alvo e co-medicações; não automatizada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

467. Sobrerol - Secreção respiratória espessa — uso mucolítico apenas quando individualmente indicado

Via	VO ou inalatória conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Pode aumentar volume de secreções/broncoespasmo; contraindicações e idade mínima variam por produto
Status	Não usar rotineiramente em IVAS/bronquiolite; resposta depende da idade e apresentação	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

468. Solução de reidratação oral (SRO) - Alguma desidratação — Plano B

Via	VO/SNG	Apresentação	SRO baixa osmolaridade pronta ou sachê corretamente diluído
Dose	75 mL/kg em 4 h	Máximo	guiar por resposta e perdas
Intervalo	fracionado continuamente	Preparo	Pequenos volumes frequentes; manter aleitamento
Monitorização	Perfusão, diurese, vômitos, peso	Cautelas	Desnutrição grave e choque exigem protocolo específico
Status	Diretriz OMS	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

469. Solução de reidratação oral (SRO) - Reposição de perdas contínuas

Via	VO	Apresentação	SRO baixa osmolaridade
Dose	<2 anos: 50–100 mL; 2–10 anos: 100–200 mL após cada evacuação; alternativa 10 mL/kg	Máximo	conforme sede/perdas
Intervalo	após cada evacuação/vômito	Preparo	Oferecer com copo/colher/seringa
Monitorização	Hidratação e aceitação	Cautelas	Não diluir incorretamente o sachê
Status	Diretriz pediátrica	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

470. Somatropina (Hormônio do crescimento) - Terapia endócrina de reposição — acompanhamento especializado

Via	VO ou SC conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Não calcular superfície corporal sem altura; monitorar crescimento e exames específicos
Status	Dose individualizada por idade, diagnóstico, alvo laboratorial e, às vezes, superfície corporal	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

471. Soro glicosado 10% - Hipoglicemia sintomática

Via	EV/IO	Apresentação	100 mg/mL
Dose	<6 meses: 2,5–5 mL/kg; ≥6 meses: 5 mL/kg	Máximo	25 g de glicose/dose
Intervalo	bolus em 2–5 min; reavaliar glicemia em 5–10 min	Preparo	Solução pronta; acesso seguro
Monitorização	Glicemia seriada, extravasamento	Cautelas	Tratar causa e iniciar GIR de manutenção se necessário
Status	Diretriz pediátrica	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

472. Soro glicosado 10% - Infusão para aporte de glicose

Via	EV em BIC	Apresentação	SG 10% = 100 mg/mL de glicose
Dose	GIR inicial de referência 4–8 mg/kg/min; individualizar por idade, glicemia e contexto	Máximo	titular à glicemia
Intervalo	contínuo	Preparo	Usar SG 10% pronta ou preparo validado. Fórmula: mL/h = GIR (mg/kg/min) × peso × 60 ÷ 100 mg/mL.
Monitorização	Glicemia, Na, balanço	Cautelas	RN/lactentes requerem protocolo específico; não confundir com manutenção isotônica
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

473. Soro glicosado 5% - Componente/diluyente de solução de manutenção

Via	EV	Apresentação	Solução isotônica de manutenção com dextrose/K quando indicados; SG 5% isolado não é padrão
Dose	Integrar a solução isotônica; ver aba Soroterapia 100%	Máximo	individualizar
Intervalo	contínuo	Preparo	A coluna H calcula a manutenção horária pela regra 4–2–1. O valor é da solução final prescrita, não de SG 5% isolado. Ajustar para doença renal/cardiaca, SIADH, neonatos e perdas.
Monitorização	Na, glicemia, balanço	Cautelas	Não usar isolado para manutenção em 28 d–18 a sem indicação específica
Status	Diretriz: não usar isoladamente como manutenção rotineira	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

474. Soro glicosado 50% - Preparo de soluções menos concentradas

Via	EV somente após diluição pediátrica	Apresentação	SG 50% = 500 mg/mL; usar somente para preparo/diluição validada
Dose	Não administrar em bolus direto rotineiro em criança	Máximo	—
Intervalo	conforme preparo	Preparo	Para 100 mL de SG 10%: retirar 20 mL de SG 50% e completar com 80 mL de diluente compatível. Homogeneizar e rotular; não administrar SG 50% em bolus pediátrico.
Monitorização	Conferir glicose final e osmolaridade	Cautelas	Risco elevado de flebite/necrose; farmácia/protocolo
Status	Uso como concentrado	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

475. Soro polieletrólítico balanceado - Choque/hipoperfusão — bolus

Via	EV/IO	Apresentação	Ringer lactato/Plasma-Lyte ou equivalente
Dose	10–20 mL/kg	Máximo	reavaliar antes de repetir
Intervalo	em 5–20 min	Preparo	Solução pronta; aquecer se grande volume
Monitorização	Perfusão, PA, sinais de sobrecarga	Cautelas	Ringer contém cálcio: não coadministrar ceftriaxona em RN; não é contraindicação automática na hipercalemia
Status	Diretriz pediátrica	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

476. Soro polieletrólítico balanceado - Reposição de desidratação/deficit

Via	EV	Apresentação	Cristaloide balanceado; volume depende da avaliação clínica
Dose	deficit estimado 50–100 mL/kg para desidratação de 5–10%; somar manutenção e perdas separadamente	Máximo	evitar automatizar sem clínica/laboratório
Intervalo	contínuo	Preparo	Estimativa: deficit (mL) = peso (kg) × % de desidratação × 10. A faixa H usa 5–10%; reavaliar e não infundir automaticamente como bolus único.
Monitorização	Na, K, glicemia, balanço	Cautelas	DKA, desnutrição grave, queimado e RN têm protocolos próprios
Status	Diretriz pediátrica	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

477. Sucralfato - Doença ácido-péptica — uso selecionado

Via	VO ou EV conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar interações e função renal; não usar ranitidina disponível de origem não autorizada
Status	Ranitidina permanece suspensa/retirada por risco de NDMA; não gerar dose	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

478. Sucralfato - Refluxo gastroesofágico — uso selecionado

Via	VO ou EV conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar interações e função renal; não usar ranitidina disponível de origem não autorizada
Status	Ranitidina permanece suspensa/retirada por risco de NDMA; não gerar dose	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

479. Sulfadiazina de prata - Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto

Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Status	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

480. Sulfadiazina de prata - Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto

Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Status	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

481. Sulfametoxazol + Trimetoprima - Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Status	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

482. Sulfato de magnésio - Asma grave refratária ao tratamento inicial

Via	EV	Apresentação	10% = 100 mg/mL
Dose	25–50 mg/kg	Máximo	2 g
Intervalo	dose única em 20–30 min	Preparo	Diluir em 50–100 mL conforme restrição hídrica
Monitorização	PA, FR, reflexos, diurese	Cautelas	Cautela em IR e bloqueio neuromuscular
Status	Diretriz pediátrica	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

483. Sulfato de magnésio - Eclâmpsia — adolescente/adulta

Via	EV em BIC	Apresentação	Sulfato de magnésio 10% ou 50%; ataque obstétrico 4–6 g
Dose	Seguir protocolo obstétrico	Máximo	4–6 g de ataque; 1–2 g/h
Intervalo	contínuo após ataque	Preparo	Aspirar 40–60 mL da solução 10% OU 8–12 mL da solução 50%; diluir e administrar conforme protocolo obstétrico. Linha destinada a adolescente/adulta.
Monitorização	FR, reflexos, diurese, Mg	Cautelas	Gluconato de cálcio disponível como antídoto
Status	Diretriz obstétrica; não é dose pediátrica por peso	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

484. Sulfato de magnésio - Torsades de pointes/hipomagnesemia com arritmia

Via	EV/IO	Apresentação	100 mg/mL
Dose	25–50 mg/kg	Máximo	2 g
Intervalo	em 10–20 min; mais rápido se PCR	Preparo	Diluir conforme urgência e protocolo
Monitorização	ECG, PA, reflexos	Cautelas	Ajustar em IR
Status	Diretriz pediátrica	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

485. Surfactante pulmonar (porcino/bovino) - Síndrome do desconforto respiratório neonatal — resgate

Via	Intratraqueal	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Administrar por equipe neonatal treinada; ajustar ventilação e monitorar bradicardia/dessaturação
Status	Dose depende do produto (poractanto/beractanto); selecionar marca e concentração	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

486. Suxametônio (succinilcolina) - Sequência rápida de intubação — bloqueio neuromuscular

Via	EV	Apresentação	20 mg/mL após reconstituição/preparo validado
Dose	<2 anos: 2 mg/kg; ≥2 anos: 1–1,5 mg/kg	Máximo	máximo conforme protocolo e peso
Intervalo	dose única; início rápido e curta duração	Preparo	A linha exibe a faixa 1–2 mg/kg; selecionar a dose pela idade antes de programar
Monitorização	ECG, SpO ₂ , ETCO ₂ , ventilação e temperatura	Cautelas	Evitar em hipercalemia/risco, miopatia, queimadura/denervação tardia, hipertermia maligna e após imobilização prolongada
Status	Uso pediátrico restrito; avaliar contraindicações antes da administração	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

487. Teicoplanina - Diarreia ou colite por Clostridioides difficile associada a antibiótico — adolescente >16 a 18 anos

Via	VO após reconstituição	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	200 mg/dose	Máximo	não extrapolar esta linha para ≤16 anos
Intervalo	12/12 h por 7–14 dias	Preparo	Reconstituir com todo o diluente e administrar 1,6 mL da solução de 125 mg/mL por via oral.
Monitorização	Resposta clínica, frequência das evacuações e recorrência	Cautelas	Uso oral específico desta indicação; não usar esta linha para infecção sistêmica.
Status	Indicação e esquema de adulto na bula profissional brasileira; confirmar infectologia e alternativa de primeira linha	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

488. Teicoplanina - Endocardite por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, ataque EV

Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose	Máximo	em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização de níveis
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

489. Teicoplanina - Endocardite por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, manutenção EV/IM

Via	EV ou IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose	Máximo	endocardite por S. aureus ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar por EV ou IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

490. Teicoplanina - Endocardite por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, ataque EV

Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	400 mg/dose	Máximo	se >85 kg, usar 6 mg/kg; em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV.

Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

491. Teicoplanina - Endocardite por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, manutenção EV/IM

Via	EV ou IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	400 mg/dose	Máximo	se >85 kg, usar 6 mg/kg; endocardite por S. aureus ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV ou IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

492. Teicoplanina - Endocardite por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, ataque EV

Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose	Máximo	usar o número de frascos necessário; confirmar protocolo e níveis séricos em infecção grave
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; criança acima de 2 meses até 16 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

493. Teicoplanina - Endocardite por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção grave/neutropenia EV/IM

Via	EV ou IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose	Máximo	monitorar níveis séricos e ajustar manutenção por função renal após o 4º dia
Intervalo	24/24 h, após as 3 doses de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; manutenção de infecção grave por Gram-positivo ou criança neutropênica, acima de 2 meses até 16 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

494. Teicoplanina - Endocardite por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção não grave EV/IM

Via	EV ou IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose	Máximo	ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados
Intervalo	24/24 h, após as 3 doses de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.

Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; manutenção de infecção por Gram-positivo em geral, acima de 2 meses até 16 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

495. Teicoplanina - Endocardite por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, ataque EV

Via	EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	16 mg/kg, dose única de ataque no primeiro dia	Máximo	confirmar idade gestacional, função renal, indicação e protocolo neonatal
Intervalo	dose inicial única no primeiro dia	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

496. Teicoplanina - Endocardite por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, manutenção EV

Via	EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	8 mg/kg/dose	Máximo	ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

497. Teicoplanina - Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, ataque EV

Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose	Máximo	em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização de níveis
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

498. Teicoplanina - Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, manutenção EV/IM

Via	EV ou IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose	Máximo	endocardite por <i>S. aureus</i> ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar por EV ou IM profunda.

Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

499. Teicoplanina - Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, ataque EV

Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	400 mg/dose	Máximo	se >85 kg, usar 6 mg/kg; em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

500. Teicoplanina - Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, manutenção EV/IM

Via	EV ou IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	400 mg/dose	Máximo	se >85 kg, usar 6 mg/kg; endocardite por S. aureus ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV ou IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

501. Teicoplanina - Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, ataque EV

Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose	Máximo	usar o número de frascos necessário; confirmar protocolo e níveis séricos em infecção grave
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; criança acima de 2 meses até 16 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

502. Teicoplanina - Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção grave/neutropenia EV/IM

Via	EV ou IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose	Máximo	monitorar níveis séricos e ajustar manutenção por função renal após o 4º dia
Intervalo	24/24 h, após as 3 doses de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.

Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; manutenção de infecção grave por Gram-positivo ou criança neutropênica, acima de 2 meses até 16 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

503. Teicoplanina - Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção não grave EV/IM

Via	EV ou IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose	Máximo	ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados
Intervalo	24/24 h, após as 3 doses de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; manutenção de infecção por Gram-positivo em geral, acima de 2 meses até 16 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

504. Teicoplanina - Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, ataque EV

Via	EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	16 mg/kg, dose única de ataque no primeiro dia	Máximo	confirmar idade gestacional, função renal, indicação e protocolo neonatal
Intervalo	dose inicial única no primeiro dia	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

505. Teicoplanina - Infecção de pele ou tecidos moles por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, manutenção EV

Via	EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	8 mg/kg/dose	Máximo	ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

506. Teicoplanina - Infecção do trato respiratório inferior por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, ataque EV

Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose	Máximo	em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização de níveis
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.

Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

507. Teicoplanina - Infecção do trato respiratório inferior por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, manutenção EV/IM

Via	EV ou IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose	Máximo	endocardite por <i>S. aureus</i> ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar por EV ou IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

508. Teicoplanina - Infecção do trato respiratório inferior por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, ataque EV

Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	400 mg/dose	Máximo	se >85 kg, usar 6 mg/kg; em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

509. Teicoplanina - Infecção do trato respiratório inferior por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, manutenção EV/IM

Via	EV ou IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	400 mg/dose	Máximo	se >85 kg, usar 6 mg/kg; endocardite por <i>S. aureus</i> ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV ou IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

510. Teicoplanina - Infecção do trato respiratório inferior por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, ataque EV

Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose	Máximo	usar o número de frascos necessário; confirmar protocolo e níveis séricos em infecção grave

Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; criança acima de 2 meses até 16 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

511. Teicoplanina - Infecção do trato respiratório inferior por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção grave/neutropenia EV/IM

Via	EV ou IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose	Máximo	monitorar níveis séricos e ajustar manutenção por função renal após o 4º dia
Intervalo	24/24 h, após as 3 doses de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; manutenção de infecção grave por Gram-positivo ou criança neutropênica, acima de 2 meses até 16 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

512. Teicoplanina - Infecção do trato respiratório inferior por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção não grave EV/IM

Via	EV ou IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose	Máximo	ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados
Intervalo	24/24 h, após as 3 doses de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; manutenção de infecção por Gram-positivo em geral, acima de 2 meses até 16 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

513. Teicoplanina - Infecção do trato respiratório inferior por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, ataque EV

Via	EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	16 mg/kg, dose única de ataque no primeiro dia	Máximo	confirmar idade gestacional, função renal, indicação e protocolo neonatal
Intervalo	dose inicial única no primeiro dia	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

514. Teicoplanina - Infecção do trato respiratório inferior por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, manutenção EV

Via	EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	8 mg/kg/dose	Máximo	ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados

Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

515. Teicoplanina - Infecção osteoarticular por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, ataque EV

Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose	Máximo	em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização de níveis
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

516. Teicoplanina - Infecção osteoarticular por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, manutenção EV/IM

Via	EV ou IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose	Máximo	endocardite por S. aureus ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar por EV ou IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

517. Teicoplanina - Infecção osteoarticular por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, ataque EV

Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	400 mg/dose	Máximo	se >85 kg, usar 6 mg/kg; em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

518. Teicoplanina - Infecção osteoarticular por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, manutenção EV/IM

Via	EV ou IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
------------	-------------------	---------------------	--

Dose	400 mg/dose	Máximo	se >85 kg, usar 6 mg/kg; endocardite por <i>S. aureus</i> ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV ou IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

519. Teicoplanina - Infecção osteoarticular por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, ataque EV

Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose	Máximo	usar o número de frascos necessário; confirmar protocolo e níveis séricos em infecção grave
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; criança acima de 2 meses até 16 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

520. Teicoplanina - Infecção osteoarticular por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção grave/neutropenia EV/IM

Via	EV ou IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose	Máximo	monitorar níveis séricos e ajustar manutenção por função renal após o 4º dia
Intervalo	24/24 h, após as 3 doses de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; manutenção de infecção grave por Gram-positivo ou criança neutropênica, acima de 2 meses até 16 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

521. Teicoplanina - Infecção osteoarticular por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção não grave EV/IM

Via	EV ou IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose	Máximo	ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados
Intervalo	24/24 h, após as 3 doses de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; manutenção de infecção por Gram-positivo em geral, acima de 2 meses até 16 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

522. Teicoplanina - Infecção osteoarticular por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, ataque EV

Via	EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	16 mg/kg, dose única de ataque no primeiro dia	Máximo	confirmar idade gestacional, função renal, indicação e protocolo neonatal
Intervalo	dose inicial única no primeiro dia	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

523. Teicoplanina - Infecção osteoarticular por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, manutenção EV

Via	EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	8 mg/kg/dose	Máximo	ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

524. Teicoplanina - Infecção urinária por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, ataque EV

Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose	Máximo	em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização de níveis
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

525. Teicoplanina - Infecção urinária por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, manutenção EV/IM

Via	EV ou IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose	Máximo	endocardite por <i>S. aureus</i> ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar por EV ou IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

526. Teicoplanina - Infecção urinária por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, ataque EV

Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	400 mg/dose	Máximo	se >85 kg, usar 6 mg/kg; em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

527. Teicoplanina - Infecção urinária por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, manutenção EV/IM

Via	EV ou IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	400 mg/dose	Máximo	se >85 kg, usar 6 mg/kg; endocardite por <i>S. aureus</i> ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV ou IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

528. Teicoplanina - Infecção urinária por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, ataque EV

Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose	Máximo	usar o número de frascos necessário; confirmar protocolo e níveis séricos em infecção grave
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; criança acima de 2 meses até 16 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

529. Teicoplanina - Infecção urinária por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção grave/neutropenia EV/IM

Via	EV ou IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose	Máximo	monitorar níveis séricos e ajustar manutenção por função renal após o 4º dia
Intervalo	24/24 h, após as 3 doses de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; manutenção de infecção grave por Gram-positivo ou criança neutropênica, acima de 2 meses até 16 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

530. Teicoplanina - Infecção urinária por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção não grave EV/IM

Via	EV ou IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose	Máximo	ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados
Intervalo	24/24 h, após as 3 doses de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; manutenção de infecção por Gram-positivo em geral, acima de 2 meses até 16 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

531. Teicoplanina - Infecção urinária por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, ataque EV

Via	EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	16 mg/kg, dose única de ataque no primeiro dia	Máximo	confirmar idade gestacional, função renal, indicação e protocolo neonatal
Intervalo	dose inicial única no primeiro dia	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

532. Teicoplanina - Infecção urinária por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, manutenção EV

Via	EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	8 mg/kg/dose	Máximo	ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

533. Teicoplanina - Peritonite associada à diálise peritoneal ambulatorial contínua — adolescente >16 a 18 anos

Via	Ataque EV seguido de administração intraperitoneal na bolsa de diálise	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	Ataque de 400 mg EV; depois 20 mg/L por bolsa na 1ª semana, 20 mg/L em bolsas alternadas na 2ª e 20 mg/L na bolsa noturna na 3ª	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	conforme cada bolsa e a semana do tratamento	Preparo	Preparação intraperitoneal exclusivamente pela equipe de diálise/farmácia, com técnica asséptica e protocolo institucional.
Monitorização	Efluente, culturas, resposta peritoneal, função renal residual e níveis quando indicados	Cautelas	Não converter automaticamente para mL sem conhecer o volume exato de cada bolsa e o protocolo nefrológico.
Status	Bula profissional brasileira; regime por volume da bolsa, não pelo peso corporal	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

534. Teicoplanina - Peritonite associada à diálise peritoneal ambulatorial contínua — criança/adolescente até 16 anos

Via	Via intraperitoneal sob protocolo de diálise	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	Definir concentração por litro e esquema com nefrologia pediátrica, infectologia e farmácia clínica	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	conforme cada bolsa e protocolo pediátrico institucional	Preparo	Preparação intraperitoneal exclusivamente pela equipe de diálise/farmácia, com técnica asséptica.
Monitorização	Efluente, culturas, resposta peritoneal, função renal residual e níveis quando indicados	Cautelas	Não aplicar automaticamente o regime fixo de adulto a crianças.
Status	A bula brasileira descreve o regime intraperitoneal sem estratificação pediátrica; cálculo não automatizado nesta faixa	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

535. Teicoplanina - Profilaxia de endocardite por Gram-positivo em cirurgia dental — adolescente >16 a 18 anos e >85 kg

Via	EV na indução anestésica	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg, dose única	Máximo	dose única; confirmar protocolo perioperatório
Intervalo	dose única no momento da indução anestésica	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e administrar por EV.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Indicação e esquema de adulto na bula profissional brasileira; confirmar cardiologia/infectologia	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

536. Teicoplanina - Profilaxia de endocardite por Gram-positivo em cirurgia dental — adolescente >16 a 18 anos e ≤85 kg

Via	EV na indução anestésica	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	400 mg, dose única	Máximo	se >85 kg, usar 6 mg/kg
Intervalo	dose única no momento da indução anestésica	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Indicação e esquema de adulto na bula profissional brasileira; confirmar cardiologia/infectologia	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

537. Teicoplanina - Profilaxia de infecção por Gram-positivo em cirurgia ortopédica ou vascular — adolescente >16 a 18 anos e >85 kg

Via	EV na indução anestésica	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg, dose única	Máximo	dose única; confirmar protocolo perioperatório
Intervalo	dose única no momento da indução anestésica	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e administrar por EV.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Indicação e esquema de adulto na bula profissional brasileira; confirmar protocolo cirúrgico	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

538. Teicoplanina - Profilaxia de infecção por Gram-positivo em cirurgia ortopédica ou vascular — adolescente >16 a 18 anos e ≤85 kg

Via	EV na indução anestésica	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	400 mg, dose única	Máximo	se >85 kg, usar 6 mg/kg
Intervalo	dose única no momento da indução anestésica	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Indicação e esquema de adulto na bula profissional brasileira; confirmar protocolo cirúrgico	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

539. Teicoplanina - Sepse por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, ataque EV

Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose	Máximo	em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização de níveis
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

540. Teicoplanina - Sepse por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e >85 kg, manutenção EV/IM

Via	EV ou IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose	Máximo	endocardite por S. aureus ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar por EV ou IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; esquema de adulto por peso acima de 85 kg	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

541. Teicoplanina - Sepse por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, ataque EV

Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	400 mg/dose	Máximo	se >85 kg, usar 6 mg/kg; em situações selecionadas pode ser necessário esquema maior sob monitorização
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses; em infecção grave, a carga pode se estender até 8 doses	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

542. Teicoplanina - Sepse por bactéria Gram-positiva sensível — >16 a 18 anos e ≤85 kg, manutenção EV/IM

Via	EV ou IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	400 mg/dose	Máximo	se >85 kg, usar 6 mg/kg; endocardite por <i>S. aureus</i> ou queimadura grave infectada pode exigir até 12 mg/kg EV sob monitorização
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma e administrar todo o volume final aproximado de 3,2 mL por EV ou IM profunda.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; esquema de adulto aplicado ao adolescente acima de 16 até 18 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

543. Teicoplanina - Sepse por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, ataque EV

Via	EV — injeção em 3–5 min ou infusão em 30 min	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose	Máximo	usar o número de frascos necessário; confirmar protocolo e níveis séricos em infecção grave
Intervalo	12/12 h nas 3 primeiras doses	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado. Administrar EV em 3–5 min ou diluir para infusão de 30 min.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; criança acima de 2 meses até 16 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

544. Teicoplanina - Sepse por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção grave/neutropenia EV/IM

Via	EV ou IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	10 mg/kg/dose	Máximo	monitorar níveis séricos e ajustar manutenção por função renal após o 4º dia
Intervalo	24/24 h, após as 3 doses de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; manutenção de infecção grave por Gram-positivo ou criança neutropênica, acima de 2 meses até 16 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

545. Teicoplanina - Sepse por bactéria Gram-positiva sensível — >2 meses a 16 anos, manutenção não grave EV/IM

Via	EV ou IM profunda	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	6 mg/kg/dose	Máximo	ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados
Intervalo	24/24 h, após as 3 doses de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma. Para EV, administrar em 3–5 min ou infundir em 30 min; para IM, aplicar profundamente.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; manutenção de infecção por Gram-positivo em geral, acima de 2 meses até 16 anos	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

546. Teicoplanina - Sepse por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, ataque EV

Via	EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	16 mg/kg, dose única de ataque no primeiro dia	Máximo	confirmar idade gestacional, função renal, indicação e protocolo neonatal
Intervalo	dose inicial única no primeiro dia	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

547. Teicoplanina - Sepse por bactéria Gram-positiva sensível — RN <2 meses, manutenção EV

Via	EV — somente infusão de 30 min no recém-nascido	Apresentação	Frasco-ampola brasileiro 400 mg com 3 mL de diluente; volume final aproximado 3,2 mL = 125 mg/mL
Dose	8 mg/kg/dose	Máximo	ajustar manutenção por função renal e níveis séricos quando indicados
Intervalo	24/24 h, após a dose de ataque	Preparo	Reconstituir com todo o diluente sem formar espuma; aspirar o volume calculado e diluir para infusão EV de 30 min conforme protocolo.
Monitorização	Resposta clínica, culturas, creatinina, hemograma, função hepática, reação de infusão e níveis séricos quando indicados	Cautelas	Não misturar diretamente com aminoglicosídeos. Rever dose de manutenção após o 4º dia na disfunção renal; monitorar nefro/ototoxicidade e hipersensibilidade.
Status	Bula profissional brasileira; recém-nascido com menos de 2 meses	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

548. Teofilina - Broncoespasmo — terapia adjuvante selecionada, não de primeira linha

Via	VO ou EV conforme fármaco/produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Janela terapêutica estreita para xantinas; revisar interações, arritmia, convulsão e níveis quando aplicável
Status	Referência documental; benefício-risco e papel atual devem ser confirmados	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

549. Terbinafina - Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente

Via	Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância
Status	Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

550. Terbutalina - Broncoespasmo agudo — alternativa beta-2 agonista conforme protocolo

Via	Inalatória ou EV conforme cenário	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Monitorar FC, K, glicemia e lactato em doses repetidas/infusão; preferir protocolo de asma

Status	Selecionar formulação, via e faixa etária antes do cálculo	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label
---------------	--	--------------------------	---

551. Tetraciclina - Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Status	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

552. Tioconazol - Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente

Via	Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância
Status	Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

553. Tirotricina - Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto

Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Status	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

554. Tirotricina - Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto

Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Status	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

555. Tobramicina - Infecção bacteriana cutânea localizada — formulação tópica conforme produto

Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica

Status	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label
---------------	---	--------------------------	--

556. Tobramicina - Infecção bacteriana ocular localizada — formulação oftálmica conforme produto

Via	Tópica, oftálmica ou otológica conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar integridade timpânica quando otológico, superfície tratada, alergia e risco de absorção sistêmica
Status	Posologia por aplicação/gota depende do produto; cálculo em mL não indicado	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

557. Tolnaftato - Micose/candidíase — selecionar fármaco e via pelo sítio, extensão e agente

Via	Tópica, VO ou EV conforme fármaco e gravidade	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Revisar hepatotoxicidade/interações sistêmicas; anfotericina EV exige formulação específica e alta vigilância
Status	Dose e duração dependem do foco; linhas já validadas do mesmo fármaco permanecem quando existentes	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

558. Topiramato - Epilepsia — manutenção conforme tipo de crise e avaliação neuropediátrica

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Não iniciar/suspender abruptamente; revisar interações, teratogenicidade em adolescentes e monitorização específica
Status	Titulação gradual e dose dependem de idade, co-medicações e síndrome; não automatizada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

559. Tramadol - Dor moderada/intensa — opção opioide selecionada por protocolo e idade

Via	VO, EV, IM ou transmucosa conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Monitorar ventilação/sedação; codeína e tramadol têm restrições importantes em menores de 12 anos e após adenoamigdalectomia
Status	Uso restrito; resposta condicionada às contraindicações etárias e à variabilidade metabólica	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

560. Triancinolona - Doença inflamatória/alérgica específica — corticoide sistêmico ou tópico

Via	VO, IM, tópica ou intra-articular conforme produto	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Não usar rotineiramente em IVAS/bronquiolite; avaliar duração, desmame e imunossupressão
Status	Potência e equivalência variam; selecionar indicação e formulação antes de calcular	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

561. Trimetoprima + Sulfadiazina - Infecção por agente sensível — selecionar por foco, idade, epidemiologia e antibiograma

Via	Via não automatizada; confirmar a apresentação brasileira vigente do fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Confirmar alergia, função renal/hepática, interações, penetração no foco e necessidade de stewardship
Status	Inventário documental; dose, via e apresentação não automatizadas sem validação em bula brasileira vigente	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

562. Urapidil - Emergência hipertensiva

Via	EV	Apresentação	Ampola 50 mg/10 mL = 5 mg/mL, porém sem dose pediátrica validada
Dose	Sem dose pediátrica de consulta rápida validada para esta planilha	Máximo	usar somente protocolo especializado
Intervalo	bolus/infusão conforme centro	Preparo	Não gerar volume a partir de dose adulta. Selecionar agente pediátrico/protocolo institucional.
Monitorização	PA contínua	Cautelas	Preferir labetalol/nicardipina/nitroprussiato conforme etiologia e protocolo
Status	Off-label; dados pediátricos limitados	Risco / off-label	Alta vigilância; Off-label

563. Ureia - Desbridamento enzimático de lesão selecionada

Via	Tópica	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Proteger pele íntegra; confirmar indicação e curativo/protocolo de feridas
Status	Aplicação depende da concentração, área e tipo de lesão; não calcular por peso	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

564. Ureia - Hidratação cutânea de lesão selecionada

Via	Tópica	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Proteger pele íntegra; confirmar indicação e curativo/protocolo de feridas
Status	Aplicação depende da concentração, área e tipo de lesão; não calcular por peso	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

565. Valproato sódico (Ácido valproico) - Epilepsia — manutenção conforme tipo de crise e avaliação neuropediátrica

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Não iniciar/suspender abruptamente; revisar interações, teratogenicidade em adolescentes e monitorização específica
Status	Titulação gradual e dose dependem de idade, co-medicações e síndrome; não automatizada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

566. Vancomicina - Infecção grave por MRSA/Gram-positivo resistente

Via	EV	Apresentação	Frasco 500 mg ou 1 g; 50 mg/mL reconstituído; 5 mg/mL final
Dose	15 mg/kg/dose	Máximo	750–1000 mg/dose conforme serviço
Intervalo	a cada 6 h inicialmente; individualizar por AUC	Preparo	Reconstituir 500 mg com 10 mL ou 1 g com 20 mL = 50 mg/mL. Diluir adicionalmente para 5 mg/mL; infundir por ≥60 min e mais lento conforme dose/reação.
Monitorização	AUC/MIC alvo 400–600, creatinina, reação infusional	Cautelas	Ajustar por função renal e TDM; não usar dose fixa sem monitorização
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

567. Vancomicina - Meningite ou infecção do SNC por Gram-positivo resistente

Via	EV	Apresentação	Frasco 500 mg ou 1 g; 50 mg/mL reconstituído; 5 mg/mL final
Dose	15 mg/kg/dose	Máximo	monitorar AUC; 60 mg/kg/dia inicial frequente
Intervalo	a cada 6 h	Preparo	Reconstituir 500 mg com 10 mL ou 1 g com 20 mL = 50 mg/mL. Diluir adicionalmente para 5 mg/mL; infundir por ≥60 min e mais lento conforme dose/reação.
Monitorização	AUC, culturas/LCR, função renal	Cautelas	Infectologia/farmácia clínica; ajustar à MIC e foco
Status	Uso pediátrico estabelecido	Risco / off-label	Alta vigilância; Não marcado como off-label

568. Vigabatrina - Epilepsia — manutenção conforme tipo de crise e avaliação neuropediátrica

Via	VO	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Não iniciar/suspender abruptamente; revisar interações, teratogenicidade em adolescentes e monitorização específica
Status	Titulação gradual e dose dependem de idade, co-medicações e síndrome; não automatizada	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

569. Vitamina A - Deficiência vitamínica ou indicação clínica específica

Via	VO, IM ou EV conforme vitamina/indicação	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Evitar megadoses e duplicidade em polivitamínicos; confirmar unidade mg, mcg ou UI
Status	Não suplementar automaticamente; dose depende de deficiência, idade e produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

570. Vitamina B1 (Tiamina) - Deficiência vitamínica ou indicação clínica específica

Via	VO, IM ou EV conforme vitamina/indicação	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Evitar megadoses e duplicidade em polivitamínicos; confirmar unidade mg, mcg ou UI
Status	Não suplementar automaticamente; dose depende de deficiência, idade e produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

571. Vitamina B12 - Deficiência vitamínica ou indicação clínica específica

Via	VO, IM ou EV conforme vitamina/indicação	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Evitar megadoses e duplicidade em polivitamínicos; confirmar unidade mg, mcg ou UI
Status	Não suplementar automaticamente; dose depende de deficiência, idade e produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

572. Vitamina B5 (Dexpantenol) - Deficiência vitamínica ou indicação clínica específica

Via	VO, IM ou EV conforme vitamina/indicação	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Evitar megadoses e duplicidade em polivitamínicos; confirmar unidade mg, mcg ou UI
Status	Não suplementar automaticamente; dose depende de deficiência, idade e produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

573. Vitamina B6 (Piridoxina) - Deficiência vitamínica ou indicação clínica específica

Via	VO, IM ou EV conforme vitamina/indicação	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Evitar megadoses e duplicidade em polivitamínicos; confirmar unidade mg, mcg ou UI
Status	Não suplementar automaticamente; dose depende de deficiência, idade e produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

574. Vitamina C - Deficiência vitamínica ou indicação clínica específica

Via	VO, IM ou EV conforme vitamina/indicação	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Evitar megadoses e duplicidade em polivitamínicos; confirmar unidade mg, mcg ou UI
Status	Não suplementar automaticamente; dose depende de deficiência, idade e produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

575. Vitamina E - Deficiência vitamínica ou indicação clínica específica

Via	VO, IM ou EV conforme vitamina/indicação	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	Evitar megadoses e duplicidade em polivitamínicos; confirmar unidade mg, mcg ou UI
Status	Não suplementar automaticamente; dose depende de deficiência, idade e produto	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

576. Zafirlucaste - Asma persistente — controle de manutenção conforme fenótipo e idade

Via	Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão
Status	Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

577. Zafirlucaste - Rinite alérgica — controle de manutenção conforme fenótipo e idade

Via	Inalatória, intranasal ou VO conforme fármaco	Apresentação	Apresentação variável; confirmar produto com registro vigente
Dose	Dose não automatizada: selecionar indicação, idade e apresentação validadas	Máximo	Confirmar máximo por indicação, idade e protocolo
Intervalo	Conforme indicação/produto	Preparo	Confirmar bula do produto, concentração, dispositivo e necessidade de diluição
Monitorização	Resposta clínica e eventos adversos específicos do fármaco	Cautelas	LABA não deve ser usado sem corticoide inalatório na asma; revisar técnica e adesão
Status	Dose depende de idade, dispositivo, potência e etapa terapêutica; não é medicação de resgate	Risco / off-label	Risco padrão; Não marcado como off-label

ANEXO E - CHECKLIST DE AUDITORIA

Catálogo

- ■ Diagnósticos completos e em A-Z
- ■ Medicamentos completos e em A-Z
- ■ Sem duplicatas indevidas
- ■ Scores com fonte e edição
- ■ Apresentações brasileiras revisadas

Cálculo

- ■ Peso e idade válidos
- ■ Base mg/kg correta
- ■ Frequência aplicada
- ■ Máximos aplicados
- ■ Conversão correta
- ■ Arredondamento administrável
- ■ Checagem reversa concordante

Clínica

- ■ Indicação coerente
- ■ Idade mínima
- ■ Alergias
- ■ Contraindicações
- ■ Função renal/hepática
- ■ Interações
- ■ Duplicidade
- ■ Off-label sinalizado
- ■ Alta vs internação coerente

Prévia

- ■ Cabeçalho completo
- ■ Todas as selecionadas presentes
- ■ Vias separadas
- ■ Vias vazias ocultas
- ■ Numeração contínua
- ■ mL/gotas/unidades
- ■ Horários e duração
- ■ Recomendações
- ■ Evolução
- ■ Alarmes
- ■ Retorno

Interface

- ■ Busca e filtros
- ■ Seleção múltipla
- ■ Apresentações clicáveis
- ■ Cópia da prévia
- ■ Responsividade
- ■ Foco e contraste
- ■ Azul/roxo aplicado

Publicação

- ■ Validadores aprovados
- ■ Build aprovado
- ■ Artefato válido
- ■ Revisão visual
- ■ Revisão clínica
- ■ Versão salva
- ■ Implantação confirmada

Nota final: este dossiê documenta a configuração e o inventário do projeto. O conteúdo farmacológico precisa de revisão periódica, especialmente apresentações, registros, idade mínima, contraindicações, máximos, alertas e recomendações off-label.